FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO

BRUNO DA CUNHA DE OLIVEIRA

NÚCLEOS DE APOIO TÉCNICO DO JUDICIÁRIO (NATJUS): A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA PARALELO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE

SÃO PAULO
2025

BRUNO DA CUNHA DE OLIVEIRA

NÚCLEOS DE APOIO TÉCNICO DO JUDICIÁRIO (NATJUS): A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA PARALELO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE

Dissertação apresentada à Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, como requisito para obtenção do título de Mestre em Direito e Desenvolvimento.

Área de concentração: Instituições do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social.

Orientador: Prof. Dr. Daniel Wei Liang Wang.

SÃO PAULO

2025

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV

Oliveira, Bruno da Cunha de.
Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) : a criação de um sistema paralelo de avaliação de tecnologias em saúde / Bruno da Cunha de Oliveira. - 2025.
92 f.

Orientador: Daniel Wei Liang Wang.
Dissertação (mestrado) - Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de São Paulo.

1. Juízes - Decisões. 2. Pareceres jurídicos. 3. Sistemas de suporte de decisão. 4. Tecnologia médica - Avaliação. 5. Sistema Único de Saúde (Brasil). I. Wang, Daniel Wei Liang. II. Dissertação (mestrado) - Escola de Direito de São Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título.

CDU 347.95

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O

BRUNO DA CUNHA DE OLIVEIRA

NÚCLEOS DE APOIO TÉCNICO DO JUDICIÁRIO (NATJUS): A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA PARALELO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE

Dissertação apresentada à Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, como requisito para obtenção do título de Mestre em Direito e Desenvolvimento.

Área de Concentração: Instituições do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social.

Data de aprovação: 11/04/2025

Banca examinadora:

Prof. Dr. (Orientador) Daniel Wei Liang Wang

FGV Direito SP

_____

Profa. Dra. Luciana Gross Cunha

FGV Direito SP

_____

Profa. Dra. Jeruza Lavanholi Neyeloff

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

AGRADECIMENTOS

Em 2021, escrevi nos agradecimentos da minha monografia da Escola de Formação Pública, em referência a meu então chefe, o Prof. Daniel Wang, que "[m]uito do ideal de professor que desejo um dia ser vem do seu exemplo – e é difícil ter referência melhor a seguir." Desde então, continuamos trabalhando juntos em uma série de projetos e o mais recente deles foi esta dissertação, feita sob sua orientação. Quatro anos depois, posso afirmar com ainda mais certeza que é difícil encontrar melhor exemplo para se ter na academia. Fico muito feliz em poder contar com o Prof. Daniel como orientador e mentor e espero que essa parceria possa ainda durar muito tempo.

A construção desta dissertação contou com o apoio também da incrível comunidade acadêmica existente na FGV. Agradeço muito tanto aos incríveis professores e professoras que tive ao longo do mestrado: Luciana Cunha, Michelle Badin, Sergio Mittlaender, Raquel Pimenta, Esteban Saldarriaga, Roberto Gargarella, Henrique Castro, Daniel Wang, Dimitri Dimoulis, Thiago Amparo, José Ghirardi, Carlos Ari Sundfeld e Yasser Gabriel. Agradeço também aos meus colegas de turma – em especial, Edson Joaquim, Quéren Santana, Natália Santos, Betina Le Grazie, Giovanna Inglez, Lívia Menezes, André Curiati, Jéssica Loyola e Pedro Pinho –, que, cada um a sua maneira, influenciaram a concepção e o desenvolvimento desta pesquisa. Agradeço também especialmente às professoras Luciana Cunha e Jeruza Neyeloff, cujos comentários durante a banca de qualificação e de defesa me auxiliaram a fazer uma melhor pesquisa e entregar uma melhor dissertação.

Durante o mestrado, pude ainda aprender bastante com novos professores e colegas no Insper. Agradeço principalmente à Prof. Vanessa Boarati, que tem confiado no meu trabalho para coordenar pesquisas sobre judicialização da saúde no âmbito do Núcleo de Saúde do Centro de Gestão e Políticas Públicas do Insper – atribuição esta que provavelmente foi a que mais me ensinou ao longo dos últimos anos. Seu apoio e incentivo tem sido fundamentais, principalmente nos momentos de maior incerteza e ansiedade típicos da vida acadêmica, e é sempre muito bom poder ter como chefe alguém que você admira e com quem é divertido estar. No Núcleo de Saúde, pude trabalhar e aprender ainda com a Carolina Melo, a Isabela Brandão, a Mariana Skaf, o Victor Rodrigues, o Ivan Prenhaca, o Adriano Teixeira, o Darcio Martins, e, em especial, com a Mariana Puschel, a Giulia Rodrigues e a Maria Sthefanny da Penha, com quem tenho trabalhado mais de perto. Para minha sorte, apesar de já longa, a lista de pessoas incríveis com quem trabalhei e trabalho no Insper não para por aí e, fora do Núcleo de Saúde,

pude ainda aprender muito com os professores Luiz Fernando Esteves, Diego Werneck Arguelhes, Ivar Hartmann, Guilherme de Almeida e Júlio Trecenti.

Em âmbito pessoal, ao longo desta pude continuar contando com o apoio de diversos amigos que me acompanham já há algum tempo: Mariana Niccoli, Marcelo Vaz, Marco Antônio Costa, Julia Rodrigues, Laís Thomaz, Giulia Smith, João Pedro Nobre, Anna Julia Costa, Morena Marconi, Sarah Fink, Isabela Sampaio, Gabrielly Drummond, Lucas Gabriel Walker, Enya Costa, Francisco Cavalcanti e Fabiana Bartholi. Tive também o apoio e incentivo de diversos familiares, que, apesar da distância, sempre se fizeram presentes – em especial, meus avôs Osni e Anilton e minha avó Lúcia.

Mais importante que qualquer outro apoio nesse processo, no entanto, foi aquele vindos da Ana, do Fábio, da Letícia e da Jacqueline – meus pais, minha irmã e minha companheira. A carreira acadêmica tem uma série de dificuldades e vocês toparam entrar nessa aventura comigo. Sem o apoio de vocês, não tenho dúvida de que o caminho seria muito mais difícil e doloroso. Com vocês, o trajeto parece até fácil e é bem mais divertido. A Lê e a Jacque foram também com certeza as pessoas que mais me ouviram falar da minha dissertação e de todo o percurso no mestrado, e tiveram ainda um papel importante na confecção deste trabalho: minha irmã revisou este trabalho e minha companheira sempre leu e comentou tudo o que eu estava escrevendo, contribuindo para que eu lapidasse o texto e continuasse animado com este projeto.

À Jacque, agradeço especialmente por tudo que não tem nada a ver com o mestrado e com a vida acadêmica. Por mais que aprenda e descubra muito sobre pesquisa com você, agradeço principalmente por poder aprender ao seu lado sobre o mundo, sobre a vida e sobre mim mesmo coisas que livro ou título acadêmico nenhum poderiam ensinar. Não existe ninguém no mundo com quem eu goste mais de passar o tempo e me sinto diariamente extremamente privilegiado de poder ver e viver a vida ao seu lado. Te amo mil milhões.

RESUMO

Entre as estratégias institucionais que o Poder Público tem desenvolvido em resposta à judicialização da saúde, os Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) são a principal estratégia de suporte técnico a juízes. Esses órgãos têm a função de emitir pareceres médicos em casos de demandas ligadas à saúde. Sua criação partiu da premissa de que, com acesso a informações mais completas e detalhadas sobre os tratamentos solicitados, os juízes tomariam decisões mais qualificadas. No entanto, apesar do grande esforço para o desenvolvimento e difusão dos NatJus, as evidências acerca de sua eficácia em qualificar decisões judiciais permanecem tanto limitadas quanto ambíguas. Poucos estudos têm avaliado a eficácia desses órgãos, e os que o fizeram apontam resultados contraditórios, além de enfrentarem limitações metodológicas significativas. A incerteza quanto à eficácia dos NatJus contrasta com o investimento substancial que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Judiciário têm feito nesses órgãos. Isso representa um problema, pois a aposta do CNJ parece se basear em hipóteses sobre as causas da judicialização e os potenciais efeitos dos NatJus que ainda não foram devidamente comprovadas, o que pode explicar possíveis falhas dessa política.

Para contribuir com a avaliação do NatJus, construí uma base de dados com mais de 250 mil notas técnicas sobre medicamentos emitidas por NatJus e incluídas na plataforma e-NatJus até 31 de dezembro de 2024. Análise dessa base de dados trouxe dois principais resultados. Em primeiro lugar, foi constatada grande divergência entre os NatJus sobre se determinados medicamentos deveriam ser concedidos ou não. Identifiquei 28 medicamentos em que a diferença entre o NatJus que mais o concedeu e o que menos concedeu foi de 100% – isto é, pelo menos um NatJus foi favorável a todos os pedidos que recebeu e outro foi contrário a todos. Em 119 casos, essa diferença foi de pelo menos 50%. Um agravante desse problema é a possibilidade de os magistrados pedirem parecer tanto para o NatJus local quanto para o NatJus Nacional e, ao escolher entre um dos dois, em diversos casos, os magistrados podem, na prática, decidir se desejam receber um parecer favorável ou contrário à concessão do medicamento. Diante da obrigatoriedade de consulta aos NatJus pelos magistrados em casos de pedidos de medicamentos não incorporados ao SUS, esse cenário de divergências entre NatJus e entre NatJus local e NatJus Nacional pode representar o fomento a uma maior desigualdade regional no acesso a medicamentos.

Além disso, esse trabalho analisou amostra de sentenças judiciais emitidas por magistrados do TJSP em casos que contaram com apoio técnico do NatJus SP. Os pareceres foram citados em 84% dos casos, com os magistrados citando-os com maior frequência quando concordavam

com eles, especialmente para negar a concessão do medicamento. Em demandas de saúde pública, a principal informação extraída dos pareceres referia-se à existência de medicamentos incorporados ao SUS semelhantes aos pleiteados, para verificar o cumprimento dos requisitos do Tema 106 do STJ, o que revela um desvio da atribuição inicial dos NatJus de fornecer "evidências científicas de eficácia, acurácia, efetividade e segurança".

PALAVRAS-CHAVE: Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário; Judicialização da Saúde; Avaliação de Tecnologias em Saúde; e-NatJus; Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT

Among the institutional strategies developed by the Public Authorities in response to the judicialization of health, the Technical Support Centers for the Judiciary (NatJus) have emerged as the main initiative aimed at providing technical support to judges. These centers are responsible for issuing medical opinions in cases involving health-related claims. Their creation was based on the assumption that judges would make more qualified decisions if they had access to more comprehensive and detailed information about the requested treatments. However, despite significant efforts to develop and expand NatJus, evidence regarding their effectiveness in improving judicial decisions remains both limited and ambiguous. Few studies have assessed the effectiveness of these centers, and those that have point to contradictory results and face significant methodological limitations. The uncertainty about the effectiveness of NatJus stands in contrast to the substantial investments made by the National Council of Justice (CNJ) and the Judiciary in these centers. This presents a problem, as the CNJ's commitment appears to be based on unproven hypotheses about the causes of judicialization and the potential impacts of NatJus, which may help explain some of the shortcomings of this policy.

To contribute to the evaluation of NatJus, I built a database of more than 250,000 technical notes on medications issued by NatJus and included on the e-NatJus platform up to December 31, 2024. Analysis of this dataset yielded two main findings. First, there is significant divergence among different NatJus centers regarding whether certain medications should be granted. I identified 28 medications where the difference between the center that most frequently recommended their provision and the one that least frequently did so was 100% – that is, at least one NatJus was favorable in all cases and another was unfavorable in all. In 119 cases, this difference was of at least 50%. This issue is aggravated by the possibility for judges to request opinions from either their local NatJus or the National NatJus. In practice, this allows judges to choose between favorable or unfavorable opinions. Given that judges are required to consult NatJus in cases involving requests for medications not incorporated into the SUS, this divergence – both between local centers and between local and national ones – may contribute to increased regional inequality in access to medications.

Furthermore, this study analyzed a sample of judicial rulings issued by judges from the São Paulo State Court (TJSP) in cases that included technical support from NatJus SP. The opinions were cited in 84% of the rulings, with judges referring to them more often when they agreed with the content, especially to deny the request for medication. In public health claims, the main

information extracted from the opinions concerned the existence of similar medications incorporated into the SUS, in order to verify compliance with the requirements of Theme 106 of the Superior Court of Justice (STJ). This reveals a deviation from the original purpose of NatJus, which was to provide “scientific evidence of efficacy, accuracy, effectiveness, and safety.”

KEYWORDS: Technical Support Centers for the Judiciary; Judicialization of Health; Health Technology Assessment; e-NatJus; Unified Health System (SUS).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **11**
1.1 Estrutura do trabalho 16
2 CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS NATJUS **18**
2.1 Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde (NAT), o pioneiro 18
2.2 Modelos alternativos ao NAT do Rio de Janeiro 23
2.2.1 NATs com atuação pré-processual *23*
2.2.2 NATs desvinculados do Executivo local *25*
2.2.3 NATs atuantes na saúde suplementar *27*
2.3 A determinação nacional de disponibilização de apoio técnico a magistrados 30
2.4 E-NatJus e NatJus Nacional: sistemas complementares aos NatJus locais 33
2.5 Revisão e manutenção do modelo inicial dos NatJus 36
3 NATJUS EM NÚMEROS **40**
3.1 Coleta de notas técnicas do e-NatJus sobre medicamentos 41
3.2 Produção de notas técnicas e inclusão no e-NatJus 45
3.3 Como os NatJus decidem 50
3.4 Divergências entre os NatJus na prática 52
3.5 Consequências da fragmentação dos NatJus 56
4 USO DE PARECERES DO NATJUS SP PELO TJSP **59**
4.1 Avaliações anteriores do impacto de pareceres dos NatJus 59
4.1.1 Taxa de concordância entre pareceres dos NatJus e decisões judiciais *62*
4.1.2 Taxa de citação de pareceres dos NatJus em decisões judiciais *63*
4.2 Coleta e análise sistemática do conteúdo de decisões judiciais do TJSP 68
4.3 Resultados 70
4.3.1 Solicitação dos pareceres e contraditório *73*
4.3.2 Fundamentos normativos das decisões *76*
4.3.3 Mobilização de informações fornecidas pelos pareceres *78*
4.3.4 Por que os juízes discordam dos pareceres técnicos *81*
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS **83**
REFERÊNCIAS **86**

1 INTRODUÇÃO

Na formulação de Wang (2022, p. 64), sintetizando a literatura sobre o caso brasileiro, a judicialização da saúde no Brasil ocorre de modo que evidências científicas não tenham quase nenhuma importância; que o custo-benefício dos tratamentos também não seja avaliado; que as escolhas de alocação de recursos não sejam feitas com base em qualquer princípio razoável de justiça distributiva; e que essa política seja implementada independentemente de se existem outras necessidades mais urgentes, de se existem usos alternativos desses recursos e de se predominam outras preferências entre representantes eleitos, autoridades públicas e outros *stakeholders*. Essa política ainda fortalece a desigualdade de acesso a serviços de saúde, visto que ela beneficia um público que, em média, é de nível socioeconômico superior ao daqueles que normalmente acessam o Sistema Único de Saúde (SUS) (Ferraz, 2021).

Mesmo com tantos problemas, este modelo de judicialização da saúde tem se mostrado resistente. Ele se mantém mesmo frente a uma resposta estrutural do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que vem se desenvolvendo há quase 15 anos (Vasconcelos, 2020; Anjos; Oliveira, 2020; Wang, 2022, cap. 4) e sobreviveu à pandemia da COVID-19, que intensificou a escassez de recursos públicos e poderia ter contribuído para que as alocações de recursos pelo Judiciário fossem repensadas (Vasconcelos et al., 2022; Vasconcelos, 2023).

Dentre as diferentes estratégias institucionais que o Poder Público tem desenvolvido em resposta a esse quadro, os NatJus são a principal estratégia de suporte técnico aos juízes (Yamauti et al., 2020). Esses órgãos têm a função de emitir pareceres médicos em casos de demandas ligadas à saúde. Com a sua criação, pressupunha-se que, se juízes tivessem acesso facilitado a melhores e mais completas informações sobre o tratamento requerido, eles tomariam decisões melhores (Wang, 2018) – isto é, decisões que complementariam em vez de entrar em conflito com as políticas públicas de saúde formuladas pela Administração Pública.

Ocorre que, no âmbito da judicialização da saúde, pareceres de órgãos técnicos são recorrentemente deixados de lado em favor de prescrições médicas. Wang et al. (2020), analisando decisões proferidas em casos envolvendo os municípios de São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis entre 2011 e 2015, identificaram que prescrições médicas são a evidência mais comumente mencionada para justificar decisões judiciais e que, em 45% das decisões que concederam tratamentos cuja segurança e eficácia ainda não haviam sido avaliadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as prescrições médicas foram a única evidência mencionada na motivação da decisão. Como o artigo destaca, essa deferência às prescrições médicas é feita em prejuízo de considerações científicas, regulatórias e de políticas

públicas – considerações essas que correspondem exatamente às informações apresentadas nos pareceres de órgãos técnicos como os NatJus.

Também existem evidências de que a criação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) não teve impacto na política pública de saúde implementada pelo Judiciário. A CONITEC é o principal órgão de avaliação de tecnologias de saúde do Executivo e, por isso, poderia servir como parâmetro acerca da deferência do Judiciário a órgãos técnicos no âmbito da judicialização da saúde. Criada pela Lei n.º 12.401/2011, a CONITEC é responsável por avaliar evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do tratamento avaliado, bem como realizar avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos do tratamento em relação às tecnologias já incorporadas, para, após isso, emitir relatórios recomendando ou não a incorporação da tecnologia avaliada à lista de tratamentos fornecidos pelo SUS (Wang et al., 2020). Os seus relatórios são encaminhados à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde para decisão final acerca da incorporação (Decreto n.º 7.646/2011). Se a secretaria decidir pela incorporação da tecnologia ao SUS, ela deve ser disponibilizada dentro de 180 dias – o que, desde 2018, nem sempre tem ocorrido (Lopes, 2025).

Azevedo et al. (2019) indica que apenas 0,68% das decisões proferidas em 2ª instância entre 2008 e 2017 em casos de judicialização da saúde mencionaram a CONITEC – uma parcela ínfima. Essas citações estão ainda bastante concentradas territorialmente: 89% das menções à CONITEC foram encontradas em decisões proferidas pelo TJRS ou pelo TRF4 (que também abrange o estado do Rio Grande do Sul). Em complemento a esse trabalho, Morgulis (2021) analisou as decisões proferidas entre 2008 e 2017 pela 1ª instância do TJSP, e buscou citações ao NatJus, à CONITEC, a pareceres de peritos judiciais e a protocolos clínicos médicos. Ela encontrou citações em 2302 decisões, de um universo de 15.231 decisões, o que corresponde a uma taxa de citações de 15%. Este número é bem maior que aquele apresentado por CNJ (2019), mas ainda é pequeno, visto que indicaria que apenas 15% das decisões judiciais fizeram uso de evidências médicas e informações sobre as políticas públicas de saúde existentes. Além disso, Morgulis (2021) não encontrou qualquer impacto das citações a órgãos técnicos no resultado das decisões.

Wang et al. (2020), em mesmo sentido, mostrou que os pareceres da CONITEC não costumam ser citados pelos juízes nem mesmo quando as partes os mencionam no processo judicial – na amostra analisada, os juízes mencionaram os pareceres em apenas 2,4% dos casos em que uma das partes havia previamente mencionado parecer da CONITEC. Ademais, os

dados demonstraram que a menção a pareceres da CONITEC pelas partes não afeta a probabilidade de os tribunais determinarem o fornecimento do tratamento pleiteado.

Segatto (2018), por sua vez, entrevistou, no início de 2018, 7 dos 10 juízes que mais determinaram o cumprimento de demandas pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo entre 2005 e 2017 e ouviu de 5 entrevistados que não consideram em suas decisões a lei que criou a CONITEC; de 4 entrevistados que não costumam buscar apoio técnico para decidir; e de 2 entrevistados que nunca haviam ouvido falar da CONITEC.

Estudos anteriores a este justificam, portanto, grande ceticismo quanto à capacidade de órgãos técnicos qualificarem as decisões judiciais no âmbito da judicialização da saúde. Esta dissertação pretende verificar se o NatJus tem tido sucesso em alterar esse quadro. Até o momento, poucos estudos avaliaram a sua eficácia (Borges, 2018; Yamauti et al., 2020) e, entre os que o fizeram, como será discutido ao longo deste trabalho, existem dados tanto em favor quanto em desfavor da eficácia desses órgãos e uma série de limitações metodológicas em relação aos dados existentes.

A falta de certeza quanto a eficácia dos NatJus contrasta com o tamanho da aposta que o CNJ e o Judiciário como um todo vem fazendo nesses. Recentemente, no âmbito do Tema 6 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) fez a maior aposta nestes órgãos até agora. Esse julgamento, concluído em setembro de 2024, tem o potencial de alterar estruturalmente a judicialização da saúde no Brasil. O caso tratou da concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, isto é, tratou de hipótese em que muitas das críticas destacadas no parágrafo inicial desta introdução estão presentes em maior grau. As razões de decidir explicitamente registradas em sua ementa resumem em três premissas principais as bases da decisão:

> 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.
> 6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.
> 6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências.

Em outras palavras, nesta decisão, o STF adotou premissas que respondem a muitas das principais críticas feitas pela literatura crítica ao atual modelo de judicialização da saúde. A tese

determinou que, sob pena de nulidade da decisão judicial, o magistrado, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, deve obrigatoriamente

> aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação;

Nesse sentido, a decisão afastou justamente a justificativa mais comumente adotada pelos magistrados – o documento produzido pelo médico do paciente – e o trocou pelo NatJus. E os NatJus não foram os únicos órgãos de Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) a ter seu papel na judicialização da saúde elevado pelo STF.

Para concretizar as premissas da decisão, a tese firmada atribuiu papel significativo a outro órgão técnico: ela determinou que a concessão judicial de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados ao SUS, demanda, entre o preenchimento de outros requisitos, que o autor da ação comprove "ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011". Além disso, a tese determina também que, sob pena de nulidade da decisão judicial, o magistrado, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, deve obrigatoriamente

> analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

Ou seja, de um órgão pouco citado, a CONITEC passará também a ser figura de presença obrigatória e papel fundamental na judicialização da saúde. Em tese, a CONITEC e os NatJus seriam complementares, com a diferença de que a primeira emite recomendações gerais e a segunda opina sobre casos concretos específicos. No entanto, não é isso que tem acontecido na prática, o que torna ainda mais incertos os efeitos do Tema 6 na judicialização da saúde.

Como narra Dias Júnior (2023), diferentes NatJus têm adotado diferentes posturas em relação ao peso que as recomendações da CONITEC devem ter em suas decisões. Especificamente no caso do Zolgensma, analisado por Dias Júnior, entre janeiro de 2021 e novembro de 2022, o NatJus SP proferiu apenas notas técnicas desfavoráveis à concessão do tratamento, enquanto o NatJus DF proferiu apenas notas técnicas favoráveis a ele. Divergências entre órgãos que fazem ATS são comuns (Stafinski et al., 2011; Allen et al., 2017; Nicod, 2017;

Bloem et al., 2021; Blonda et al., 2022). Diferentes países adotam diferentes fontes, critérios e interpretações em seus procedimentos de ATS e isso leva a resultados também distintos. No entanto, não há registro de país em que, como no Brasil, um sistema de órgãos de ATS criado, desenvolvido e mantido pelo Judiciário concorre com o órgão de ATS da administração pública.

Além disso, também não há registro de sistema subnacional de ATS tão fragmentado quanto o brasileiro. A literatura acadêmica descreve outros países em que divergências ocorrem em nível subnacional, como acontece no Canadá. Nesse país, as províncias podem ou não acatar a recomendação da *Common Drug Review* (CDR) quanto à incorporação da tecnologia avaliada. O nível de concordância entre as províncias e a CDR é estimado entre 74,5% e 85,8% (Allen et al., 2016; Zoratti et al., 2020). No Brasil, no entanto, como será apresentada nesta dissertação, o nível de discordância entre os NatJus locais e a CONITEC – e também entre os diferentes NatJus – atinge taxas ainda maiores.

Nesse sentido, em vez de servir como um sistema complementar à CONITEC, os NatJus podem atuar como um sistema paralelo a ela. Mais grave que isso é que, devido à sua maior proximidade com os magistrados e os tribunais, este sistema concorrente poderia, ao menos em âmbito judicial, se sobrepor à CONITEC. Caso isso ocorra, a menor legitimidade democrática dessa burocracia judiciária já seria, por si só, um problema: a CONITEC foi pensada e criada pelo Congresso Nacional, enquanto seu sistema concorrente foi, como será discutido no segundo capítulo, criado pelo CNJ, por meio de resolução, com base em pouca discussão pública. No entanto, esse quadro é ainda mais problemático quando comparamos a estrutura de cada um desses sistemas.

Como aponta Wang (2021, p. 857), a CONITEC

> possui corpo técnico permanente selecionado e treinado para: a) coletar e revisar sistematicamente a literatura sobre eficácia, acurácia, efetividade e segurança da tecnologia em comparação com outros existentes (o que inclui avaliar a metodologia das pesquisas, a validade interna e a generalizabilidade dos dados, além de lidar com incertezas e lacunas no conhecimento), b) fazer avaliação de custo-efetividade e do impacto orçamentário para entender os custos de oportunidade, e c) produzir diretrizes clínicas para orientar a prática a partir da evidência científica. Esse órgão é constituído por representantes do setor da saúde (Conselho Federal de Medicina, Conselho Nacional de Saúde, ANVISA etc.) e conta com auxílio externo de centros de pesquisa em universidades e hospitais. O processo deve seguir todas as regras e princípios do processo administrativo, além de promover transparência e participação da sociedade e grupos de interesse por meio de audiências e consultas públicas. A decisão que segue essa avaliação vale para todos os pacientes.

Por outro lado, os NatJus adotam um procedimento muito menos sofisticado, transparente e participativo que o da CONITEC, tendendo a serem cópias inferiores deste órgão (Vasconcelos, 2020; Wang, 2018; 2021). A qualidade do corpo técnico e do treinamento por

eles recebido varia enormemente, dependendo das condições fornecidas ao NatJus pelos tribunais locais, e eles nem sempre contam com auxílio externo de instituições de referência e não têm as mesmas obrigações no que diz respeito a transparência e participação da sociedade.

Assim, não só se desenvolveram dois sistemas concorrentes de ATS, mas sistemas de qualidades substancialmente distintas. E o STF, em sua decisão sobre o Tema 6 de Repercussão Geral, para atacar os problemas relacionados à judicialização da saúde, acabou reforçando esse quadro. Magistrados terão de dialogar com ambos os sistemas, mas não é definido como eles deverão sanar eventuais divergências entre a recomendação da CONITEC e dos NatJus. Esta dissertação tem como objetivo produzir informações que iluminem esse contexto, com foco no estudo dos NatJus, por meio da descrição de como os NatJus se desenvolveram, como eles tem atuado e como seus pareceres têm sido utilizados pelos magistrados. Com isso, busco produzir novos dados para avaliar se a aposta feita pelo Judiciário nos NatJus tem-se pagado.

1.1 Estrutura do trabalho

Além dessa introdução e de um capítulo de considerações finais, este trabalho é composto por mais três capítulos. No segundo capítulo, contextualizo como se deu a criação e o desenvolvimento dos NatJus, dando foco para a alta autonomia atribuída aos tribunais locais para definirem o modelo de NatJus que adotariam. Com este capítulo, pretendo demonstrar que o quadro narrado nessas páginas iniciais, de um conflito entre a CONITEC e os NatJus, poderia ter sido antecipado e evitado, mas não foi previamente diagnosticado e tem provocado consequências negativas ao direito à saúde, narradas no restante desta dissertação.

No terceiro capítulo, apresento a principal fonte de dados desenvolvida nesta dissertação: uma base de dados construída a partir da coleta automatizada de todas as notas técnicas sobre medicamentos emitidos por NatJus e incluídas na plataforma e-NatJus até o final de 2024.[1] A partir desta base de dados, discuto os diferentes usos que cada NatJus tem feito da plataforma e a diferença gigantesca entre a taxa de emissão de notas técnicas favoráveis de cada NatJus. Ao fazer isso, busco demonstrar que a alta liberdade dada pelo CNJ aos tribunais locais resultou em órgãos com perfis muito diferentes e um quadro em que pacientes de diferentes estados têm chances significativamente diferentes de receber pareceres favoráveis aos medicamentos que pleiteiam. Além disso, a possibilidade fornecida pelos magistrados de pedir

[1] Todos os códigos elaborados para a coleta e a análise do material, bem como as bases de dados resultantes, estão disponíveis no repositório do OSF associado a esta pesquisa: <https://osf.io/xuptj/>.

parecer tanto para o NatJus local quanto para um NatJus Nacional[2], associado ao Hospital Israelita Albert Einstein, tornou possível que diversos magistrados possam, em muitos casos, escolher se desejam um parecer favorável ou contrário à concessão do caso em questão, bastando para isso optar por um dos dois NatJus que têm a sua disposição. Esse diagnóstico indica que o Tema 6 de Repercussão Geral pode contribuir para que o endereço seja fator determinante para se pacientes irão ou não obter tutela judicial a medicamentos não incorporados ao SUS.

Por fim, no quarto capítulo, realizo estudo de caso sobre o NatJus SP. Inicio discutindo como trabalhos anteriores avaliaram os impactos dos pareceres dos NatJus nas decisões judiciais e, em seguida, analiso amostra de decisões judiciais que requisitaram estes pareceres para entender qual o principal uso que os magistrados têm feito do NatJus, discutindo o que leva um magistrado a citar um parecer em sua decisão. Observo indícios de que os magistrados atualmente fazem uso estratégico dos pareceres, citando-os com mais frequência quando concordam com eles e quando negam os tratamentos. Esses dados apontam para a existência não de uma qualificação técnica isenta e imparcial, mas da possibilidade de os magistrados agregarem argumento de autoridade a suas decisões e terceirizarem a responsabilidade da decisão quando desejarem. Além disso, noto que o principal uso dos pareceres feito pelos magistrados do TJSP foi o de obtenção de informações sobre as políticas do SUS, e não sobre evidências científicas de eficácia e segurança. Sendo esse o principal uso de informações da NatJus, e com base nos demais diagnósticos aqui apresentados sobre esses órgãos, questiono a pertinência da manutenção do modelo atual dos NatJus.

[2] Para saber mais sobre isso, cf. o capítulo 2.4.

2 CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS NATJUS

Para entendermos para onde a participação dos NatJus na judicialização da saúde irá caminhar após a decisão do STF sobre o Tema 6, precisamos primeiro entender onde ela está e como chegou lá. Esse é o objetivo deste capítulo: reconstruir como se deu a criação dos NatJus enquanto sistema e como o modelo desses órgãos se desenvolveu ao longo do tempo.

A descrição apresentada neste capítulo, além de organizar informações que ainda não haviam sido integralmente articuladas pela literatura, tem um enfoque adicional: discutir, além do que foi feito, o que poderia ter sido feito de diferente. Ao organizar os diferentes caminhos que a política judiciária de Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) poderia ter seguido, podemos compreender melhor o caminho que de fato foi percorrido e como seria possível, se desejado, alterar a sua trajetória.

2.1 Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde (NAT), o pioneiro

Na segunda metade dos anos 2000, a judicialização da saúde começou a mudar de patamar. No âmbito federal, a União passou de um gasto anual com aquisição de medicamentos solicitados judicialmente de 2,5 milhões em 2005 para um total de 132,58 milhões em 2010 (Guimarães; Palheiro, 2015). Em âmbito local, esse fenômeno também foi observado, e estados e municípios precisaram se reorganizar para lidar melhor com essas demandas.

No Rio de Janeiro, até o início de 2007, a Secretaria Estadual de Saúde (SES/RJ) não possuía nenhuma estrutura interna para lidar com a judicialização da saúde (Guimarães; Palheiro, 2015). Isso começa a mudar naquele ano com o estabelecimento de uma parceria entre a SES/RJ, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro (Guimarães; Palheiro, 2015). Segundo o acordo firmado, a Defensoria passaria a exigir laudo médico emitido pelo SUS para ajuizar a ação e, antes de judicializar o caso, enviaria um ofício ao município e ao estado questionando se o medicamento estava disponível. Apenas em caso de resposta negativa é que a ação seria ajuizada. Paralelamente a isso, naquele mesmo ano, foi criada, em cumprimento a decisão proferida em ação civil pública (TRF2, [s.d.]), a Central de Atendimento a Demandas Judiciais (CADJ), órgão composto por funcionários do estado e do município do Rio de Janeiro com a função de receber as intimações judiciais, cumprir as decisões e controlar os estoques para evitar compras emergenciais (Silva, 2012; Guimarães; Palheiro, 2015).

Nesse cenário de diferentes iniciativas institucionais promovidas pela SES/RJ, em fevereiro de 2009, foi criado um terceiro órgão voltado ao fenômeno da judicialização da saúde, agora em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ): o Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde (NAT) (Castro, 2012; Silva, 2012; Ferreira; Costa, 2013; Guimarães; Palheiro, 2015; Ribeiro; Hartmann, 2016; Borges, 2018; Freire, 2023; TRF4, [s.d.]).[3] O NAT tem a atribuição de fornecer subsídios técnicos para auxiliar os magistrados a apreciar demandas em saúde e começou como um projeto experimental junto a duas Varas de Fazenda Pública da capital (Castro, 2012; Silva, 2012; Ferreira; Costa, 2013; Guimarães; Palheiro, 2015; TRF4, [s.d.]).[4]

O NAT elabora pareceres técnicos sobre a demanda judicial dos pacientes com base nos documentos médicos apresentados na petição inicial – em especial, prescrições e laudos médicos (Silva, 2012). O documento produzido é dividido em três partes, seguindo uma padronização indicada por gestores do SUS (Silva, 2012; TRF2, [s.d.]b). A primeira parte contém um resumo do pedido do autor. A segunda parte consiste na análise do pedido em si, contendo análise da legislação aplicável ao caso, análise da situação clínica do paciente e análise do tratamento pleiteado. A terceira parte conclui, indicando a existência de alternativas terapêuticas ao pedido do autor, apontando limitações no pedido e ausência de informações relevantes no parecer, e identificando quais endereços o paciente poderia buscar para poder conseguir acessar o tratamento que pleiteia.

Os pareceres são assinados por três ou quatro pessoas, entre farmacêuticos, enfermeiros e médicos que compõem o NAT (Silva, 2012). Alguns poucos pareceres contavam apenas com a assinatura da coordenadora do NAT, em casos em que existiria a preocupação com não violar regras sobre a existência de atos privativos profissionais (Silva, 2012). A coordenação do NAT também é responsável por revisar todos os pareceres, propondo alterações caso necessário (Ferreira; Costa, 2013).

Até a criação do NAT, salvo se uma das partes requeresse perícia, magistrados do TJRJ precisavam optar entre decidir sem apoio técnico e decidir com base em parecer de perito judicial nomeado de ofício (Borges, 2018). O apoio de um perito permitiria aos magistrados

[3] Sobre os detalhes do termo de cooperação firmado, cf. Castro (2012, p. 41-42).

[4] O NAT continua existindo até hoje, mas agora como NatJus do Estado do Rio de Janeiro. Utilizo o termo NAT para me referir apenas ao órgão em sua atuação anterior a 2016, quando os NatJus foram criados.

decidir de maneira mais segura (Castro, 2012; Freire, 2023), mas traria algumas complicações ao caso.[5]

Optar por nomear um perito para atuar no caso implicaria, em primeiro lugar, em maiores custos para as partes, que teriam de arcar com essa despesa processual (Borges, 2018). Quando o NAT foi criado, em 2009, ainda estava vigente o Código de Processo Civil de 1973, que estabelece em seu artigo 33 que, se a perícia foi determinada de ofício pelo juiz, a remuneração do perito será paga pelo autor da ação. Ou seja, a escolha entre requerer apoio técnico ou não, em casos em que o autor não fazia jus a gratuidade da justiça, representava uma escolha também de impor ou não um ônus financeiro ao autor da ação – ao menos até o final do processo, quando a ré, se perdesse, arcaria com o ônus de sucumbência, incluído aqui a despesa processual de contratar um perito.[6]

Além disso, a nomeação de perito aumentaria o tempo até a decisão final da ação (Ferreira; Costa, 2013; Borges, 2018). Em casos de procedimento sumário, o perito tinha 15 dias corridos para apresentar o seu laudo (CPC/1976, art. 280, II), mas nos demais casos não havia prazo máximo para o perito apresentar suas conclusões, ficando o magistrado encarregado de fixar o prazo de entrega do laudo (CPC/1976, art. 421). Caso houvesse a necessidade de prorrogação do prazo ou o primeiro perito nomeado precisasse se escusar do caso, os prazos seriam ainda maiores.[7]

Com a criação do NAT, tanto o custo financeiro quanto o tempo para emissão das notas técnicas seriam reduzidos. De fato, a principal redução do custo às partes vem de uma mudança na alocação dele, visto que uma despesa processual que antes era paga pelas partes passa a ser paga pelo Executivo estadual. Sem o NAT, o Executivo estadual arcava com o custo pericial apenas nas ações em que era réu e perdia. Com o NAT, passou a arcar com esse custo em todas as ações, inclusive naquelas em que sequer era parte, visto que é quem financia o NAT.

No entanto, não obstante essa mudança na alocação dos custos, ainda assim pode-se esperar uma redução no custo de cada parecer, porque, comparada à contratação *ad hoc* de peritos, a instituição de corpo técnico permanente encarregado de emitir notas técnicas tende a

[5] Além das dificuldades narradas a seguir, que receberam maior repercussão, a ministra Cármen Lúcia cita ainda o fato de que nem todos os juízes teriam um perito de confiança, especialmente no interior (STF, 2024, p. 142).

[6] Com o Código de Processo Civil de 2015, que viria 6 anos após a criação do NAT e 1 ano antes da determinação de criação de um NatJus por estado, esse quadro é amenizado. O artigo 95 desse código estabelece que, quando a perícia é determinada de ofício, a remuneração do perito é rateada pelas partes. Nesse caso, a nomeação de perito de ofício ainda imporia um ônus financeiro a quem judicializa requerendo tratamento médico, mas pelo menos o custo, antes do final do processo, cairia para a metade do que era antes.

[7] No novo Código de Processo Civil, os prazos passam a ser um pouco mais bem definidos, mas seguem longos e, mesmo se fossem bastante curtos, certamente já seriam maiores do que simplesmente não haver perícia técnica.

levar a uma maior especialização dos profissionais nessa tarefa. Essa especialização permite que as notas técnicas sejam emitidas de maneira mais célere e por um custo menor, quando comparado a um profissional qualificado, mas que não faz apenas perícias judiciais referentes a judicialização da saúde.

De qualquer maneira, o ganho de tempo na solução dos casos seria o principal benefício derivado da criação do NAT (Castro, 2012; Santiago, 2016). Em conjunto com a perspectiva de um aumento na segurança dos juízes ao decidir, esse efeito levou a um crescente apoio institucional ao NAT. A criação desse órgão foi uma das primeiras respostas institucionais do Judiciário à judicialização da saúde (Silva, 2012) e fez parte de um esforço que ganhou maiores proporções cerca de três meses depois, entre 27 de abril de 2009 e 7 de maio de 2009, quando o STF organizou a Audiência Pública n.º 4 para tratar do tema.

Entre as recomendações apresentadas na audiência pública, foi sugerido que os tribunais adotassem "medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores de direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas envolvendo o direito à saúde" (Ferreira; Costa, 2013, p. 220). O fornecimento de Assessoria Técnica ao Judiciário foi citado 13 vezes na audiência, sendo a terceira sugestão mais citada para contornar a judicialização da saúde (Gomes, 2014). Nesse âmbito, mesmo que ainda recente, o NAT seria modelo e serviria de inspiração ao CNJ e a outros tribunais (Ferreira; Costa, 2015; Ribeiro; Hartmann, 2016; Vasconcelos, 2018; Val; Pelegrino, 2020; Freire, 2023).

Em que pese a Audiência Pública n.º 4 tenha tido baixo impacto imediato nas decisões do STF, ela teve como uma de suas consequências o crescimento da atuação do CNJ sobre a judicialização da saúde (Vasconcelos, 2018). A primeira manifestação disso ocorre em 20 de novembro de 2009, com a instauração de grupo de trabalho para "estudo e proposta de medidas concretas e normativas para as demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde" (Portaria CNJ n.º 650/2009). Em 30 de março do ano seguinte, a partir das contribuições desse grupo de trabalho, o CNJ emitiu a Recomendação n.º 31/2010, que, entre outras medidas, recomendou aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais que

> I. [...]
> a) até dezembro de 2010 celebrem convênios que objetivem disponibilizar apoio técnico composto por médicos e farmacêuticos para auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das questões clínicas apresentadas pelas partes das ações relativas à saúde, observadas as peculiaridades regionais;

Foi recomendado, portanto, que outros estados buscassem realizar convênios semelhantes àquele firmado pelo TJRJ com a SES/RJ, visto que a literatura sobre os NatJus não

menciona a existência de outros órgãos como o NAT naquele momento (Castro, 2012). Em 12 de julho de 2011, o CNJ publicou a Recomendação n.º 36/2011, repetindo essa mesma recomendação, mas agora com foco na judicialização contra a saúde suplementar, dessa vez sem definir qualquer prazo.

A esse endosso dos participantes da audiência pública do STF e do CNJ somou-se um paulatino maior apoio do próprio TJRJ ao NAT. Em outubro de 2009, alguns meses depois da audiência pública, o NAT passou a atender todas as varas de fazenda pública e as câmaras cíveis do tribunal (Castro, 2012; Ferreira; Costa, 2013). Ao longo do tempo, em especial, depois da recomendação do CNJ, o NAT seguiu expandindo a sua atuação, passando a atuar junto à Justiça Federal em 2012 (Ferreira; Costa, 2013; Ribeiro; Hartmann, 2016; Vasconcelos, 2018) e expandindo às comarcas do interior a partir de 2015 (Guimarães; Palheiro, 2015). Essa expansão gradual teve como objetivo não só melhor estruturar o órgão, mas, principalmente, ganhar a confiança dos magistrados (Vasconcelos, 2018).

Além de expandir o NAT aos poucos, em 31 de janeiro de 2012, o TJRJ emitiu o Ato Normativo 5/2012, que estabeleceu que todas as ações relacionadas a medicamentos ou dispositivos médicos com pedido de liminar deveriam ser enviadas ao NAT para emissão de parecer em até 48 horas (Borges, 2018; Saad; Braga; Maciel, 2020). Não obstante essa necessidade de consulta, os pareceres do NAT seguiram não sendo vinculantes, como o parecer de um perito judicial (Silva, 2012; Castro, 2012; Duarte, 2017; Borges, 2018; Vasconcelos, 2018).

Somando-se a essa chancela do CNJ e do TJRJ, em 2014, o NAT foi também mencionado como referência pelo Ministério da Saúde (MS), que recomendou a adoção do modelo do NAT de parceria entre tribunais e secretarias estaduais e municipais de saúde (Freire, 2023). Em um contexto com esses endossos institucionais relevantes e com diversos estados sentindo o crescimento da judicialização da saúde, vários estados começaram a desenvolver órgãos como o NAT para chamar de seus.

2.2 Modelos alternativos ao NAT do Rio de Janeiro

Quando acontece a Audiência Pública n.º 4 do STF, o NAT era o único órgão de apoio técnico médico-científico a magistrados do Brasil. Nesse sentido, é natural que ele fosse a principal inspiração para outras iniciativas que surgiram pouco depois. Igualmente natural é

que, ao criar órgão semelhante, outros tribunais fizessem adaptações ao modelo do NAT para compatibilizá-lo com a realidade e as demandas locais. Nesse processo, destacaram-se três mudanças principais feitas por alguns tribunais: a atuação pré-processual, a desvinculação em relação ao Executivo local e a atuação em casos envolvendo ações contra planos de saúde. Estas alterações persistiriam em alguns locais mesmo após a criação dos NatJus e receberiam maior apoio do CNJ em momentos posteriores.

2.2.1 NATs com atuação pré-processual

A primeira alteração relevante do modelo do NAT se deu na cidade de Araguaína, no Tocantins. Depois do NAT do Rio de Janeiro, que inspirou os demais, esse foi o NAT mais discutido pela literatura. Essa grande influência do NAT de uma cidade que não é capital e que tinha população cerca de 40 vezes menor que a do Rio de Janeiro pode ser atribuída à grande inovação em seu modelo: a atuação pré-processual. Por meio dessa atuação, esperava-se obter ainda mais celeridade na resolução das demandas, evitando que elas sequer fossem judicializadas (Silva; Schulman, 2017). Nesse sentido, essa alteração buscou apostar ainda mais fichas na redução de tempo e de custos associada ao NAT.

O NAT de Araguaína surgiu em 2011 como um projeto-piloto, inspirado no NAT do Rio de Janeiro (Henrique; Brito; Mel, 2013; Ávila; Melo, 2018). Esse projeto foi idealizado pela juíza Milene de Carvalho Henrique, então juíza titular da 2ª Vara da Fazenda de Registros Públicos de Araguaína, e foi desenvolvido em conjunto com a coordenadora da Ouvidoria do Município, Musa Denaise de Sousa Moraes, e o Tribunal de Justiça e executado pela secretaria de saúde municipal (Henrique; Brito; Mel, 2013).

Ao contrário do NAT do Rio de Janeiro, que tinha apenas a função de apoiar o Judiciário por meio da produção de notas técnicas, o NAT de Araguaína tinha duas outras funções (Henrique; Brito; Mel, 2013). Em primeiro lugar, ele atuava como órgão administrativo responsável por estimular o diálogo entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os usuários, de modo a evitar a judicialização de demandas. Além disso, o órgão auxiliava a Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína a identificar quais demandas eram mais frequentes, para facilitar o planejamento das ações da Secretaria.

Henrique, Brito e Mel (2013) produziram dados indicando que essa iniciativa teve sucesso em reduzir a judicialização das demandas. Entre janeiro e junho de 2013, o NAT recebeu 45 requerimentos de nota técnica advindos da Defensoria Pública e 74 do Ministério

Público, que ajuizaram, respectivamente, apenas 2 e 13 ações, resultando em taxas de resolutividade administrativa de mais de 80%. Para além disso, os 15 casos que foram ajuizados seriam casos fora da competência municipal ou relacionados a tratamentos não padronizados pelo SUS. Além desses casos, apenas 6 outras ações sobre judicialização da saúde foram ajuizadas no período, estas sem consulta prévia ao NAT. Em 2014, novamente, cerca de 80% dos casos foram resolvidos administrativamente (Ávila; Melo, 2018).

Em 2013, foi criado NAT do Estado do Tocantins, em uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES/TO). Assim como o NAT de Araguaína, que seguiu existindo, o NAT TO atua tanto antes quanto depois do ajuizamento da ação (Henrique; Mendonça; Braga, 2018; Pinheiro; Chaves, 2020). Entre 2015 e 2017, este NAT obteve taxas de resolutividade administrativa semelhantes àquela reportada em relação ao NAT de Araguaína, superando 70% (Henrique; Mendonça; Braga, 2018; Nascimento; Miranda, 2020).

O mesmo modelo foi adotado pelo município de Palmas, capital do estado , em 2016, o que teria coincidido com um declínio de 20% nos gastos do município com demandas judiciais naquele ano (Sousa; Santos, 2017). A literatura ainda registrou a adoção de modelo semelhante ao de Araguaína pelo NAT de Joinville em 2016, pouco antes da criação dos NatJus (Ornelas, 2018). No ano seguinte à sua criação, o número de ações demandando tratamentos de saúde foi, aproximadamente, 23% menor e o montante empenhado para o pagamento de tais tratamentos foi 41,46% menor (Ornelas, 2018). Diante desses números, Ornelas (2018, p. 35) conclui que "outra não pode ser a conclusão, senão a de que a criação do NAT no Município de Joinville é uma ação administrativa dotada de efetividade." Ao contrário dos dados produzidos por Henrique, Brito e Mel (2013), no entanto, a causalidade inferida por Sousa e Santos (2017) e por Ornelas (2018) parece menos clara, visto que os dados produzidos (redução no número de ações e de custos de tratamento) podem ter uma série de outras causas que se confundem com os efeitos da criação do NAT. Ainda assim, diante dos números encontrados, a atuação pré-processual de NATs e NatJus teria potencial para reduzir a judicialização.[8]

[8] Para mais informações sobre os NATs pré-processuais, cf. Asensi e Pinheiro (2015).

2.2.2 NATs desvinculados do Executivo local

A segunda grande alteração no modelo do NAT buscou solucionar a principal crítica feita a ele: a sua suposta parcialidade, derivada do fato de que o órgão é composto por servidores advindos da SES/RJ. No regime vigente com o CPC/1973, os peritos eram nomeados pelo juiz (CPC/1976, art. 421), escolhidos "entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente [...]" (CPC/1973, art. 145, § 1º) e a eles se aplicam os motivos de impedimento e de suspeição aplicáveis a juízes (CPC/1973, art. 138). Nesse sentido, havia a pretensão de que eles fossem tão isentos e imparciais quanto magistrados. O NAT, por outro lado, era composto por servidores oriundos da SES/RJ, ré em parcela significativa dos casos avaliados pelo NAT. Segundo Vasconcelos (2019), o NAT até mesmo se submete à coordenação do assessor-chefe da assessoria técnica da Subsecretaria Jurídica da SES/RJ, o que representa um alto grau de vinculação à secretaria de saúde.

A vinculação do NAT à SES/RJ levou a questionamentos sobre se esta vinculação não comprometeria a igualdade, o contraditório e a ampla defesa de quem ajuizou ação contra o Estado pleiteando medicamento (Ferreira; Costa, 2013; Val; Pelegrino, 2020). No Rio de Janeiro, Silva (2012, p. 104) identificou inclusive decisão judicial que argumentou que, por o NAT ser composto de funcionários do Estado, sua imparcialidade seria comprometida e, por isso, sua manifestação não poderia se sobrepor aos documentos apresentados pela autora. Críticas semelhantes foram feitas ao NAT do Mato Grosso por André Luiz Prieto, então defensor público geral daquele estado (SES/MT, 2011, *apud* Ferreira; Costa, 2013). O NAT MT, assim como sua versão carioca, era composto por profissionais provenientes da secretaria de saúde estadual. Seria a criação do NAT uma opção do Tribunal de Justiça de privilegiar os interesses do Estado em detrimento das pessoas defendidas pela defensoria pública?

Relacionado a essas críticas, Freire (2023, p. 11) destaca que só integrariam o NAT servidores de carreira da SES/RJ, o que garantiria a eles "a liberdade de exercer um papel estritamente técnico e formular pareceres favoráveis ou contrários aos interesses tanto dos autores das ações, quanto dos réus". Nesse sentido, Guimarães e Palheiro (2015) argumentam que os servidores do NAT têm plena consciência de que exercem um papel puramente técnico e, por isso, possuem total independência para emitir pareceres contrários ao interesse do Estado. Por outro lado, Freire (2023, p. 11) menciona que, em que pese sejam servidores de carreira, são os servidores de carreira alocados pela SES/RJ para essa função e isso pode ocorrer com a "intenção de que o órgão do Executivo pudesse tentar controlar minimamente o resultado das ações judiciais em saúde".

Vasconcelos (2018) cita duas estratégias adotadas pelo NAT do Rio de Janeiro para reduzir alegações de imparcialidade que foram. A primeira consiste no deslocamento do NAT para o prédio dos tribunais, de modo a afastar os funcionários do ambiente da secretaria de saúde e incluí-los no ambiente judicial – algo que não ocorreu, por exemplo, em Santa Catarina. A segunda seria a realização de revisões de literatura que partam de uma abordagem de Medicina Baseada em Evidências. Ambas, no entanto, teriam baixo potencial em impedir intervenções da secretaria de saúde no órgão, visto que o deslocamento físico não impediria pressões externas e a revisão de literatura *per se* não impediria que determinadas interpretações sobre as evidências científicas fossem impostas aos funcionários dos NATs.

Para amenizar o peso dessa alegação de imparcialidade, Ferreira e Costa (2013) sugerem garantir que, especialmente nos casos de negativa dos tratamentos solicitados embasada na nota técnica emitida pelo NatJus, os autores da ação devem ter a possibilidade de exercer o contraditório antes da decisão do magistrado. Essa garantia é especialmente importante devido à diferença entre a maneira como os peritos judiciais e os técnicos do NAT produzem seus pareceres. O documento produzido pelo perito deve seguir a legislação processual brasileira, que permite a nomeação de assistente técnico para acompanhar os trabalhos do perito e a elaboração de quesitos que deverão ser respondidos pelo perito, de modo a maximizar o contraditório – o que não ocorre no caso do NAT (Silva, 2012). Nesse sentido, não se deveria atribuir ao documento resultante do NAT o mesmo peso que um perito judicial tem no processo. Na prática, entretanto, pode haver alguma dúvida sobre se os magistrados efetivamente fazem essa distinção, o que gera uma maior desconfiança em relação aos NatJus vinculados a secretarias de saúde.[9]

Ao criar um órgão de assessoramento técnico, caso a estabilidade dos funcionários integrantes do NAT e o reforço da necessidade de se garantir a ampla defesa e o contraditório não sejam suficientes para afastar a suspeita de parcialidade do NAT, são necessárias mudanças mais estruturais. Ferreira e Costa (2013, p. 227) apresentam duas sugestões para solucionar esse problema: "a criação de um quadro plural de servidores, composto não apenas por médicos e técnicos das Secretarias do Estado, mas também por um corpo técnico independente que integrasse o próprio tribunal" e a "desvinculação formal do NAT da Secretaria de Saúde dos estados e vinculação ao Tribunal de Justiça em que estiverem instalados, com o objetivo de preservar uma autonomia maior". Podemos entender essas duas propostas como uma

[9] No Rio de Janeiro, no entanto, Castro (2012) identificou entre magistrados entrevistados uma grande preocupação em levar o fato de que o órgão pode ser parcial em consideração ao valorar o seu conteúdo.

desvinculação parcial e uma desvinculação total do NAT em relação à Secretaria do Estado de Saúde local, e o modelo do NAT do RJ como uma vinculação total.

Além dos já citados NATs do Rio de Janeiro e do Mato Grosso[10], adotaram modelos de NAT vinculados à Secretaria de Saúde do Estado pelo menos os NATs de Santa Catarina (Ornelas, 2018; Vasconcelos, 2018; Caetano; Matheus; Diehl, 2021), de Goiás (Rocha; Queiroz; Rodrigues, 2021) e de Pernambuco (Barros; Castro, 2016). A desvinculação parcial do NAT foi observada no Piauí. Neste órgão, compunham também o NAT funcionários do Departamento de Saúde do próprio Tribunal de Justiça e de conselhos e associações de trabalhadores da área da saúde (Ferreira; Costa, 2013). Outra hipótese interessante de desvinculação parcial foi observada em Minas Gerais. Neste estado, foi firmado convênio entre o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), a Secretaria de Estado de Saúde e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (SES/MG) (Nogueira; Carvalho; Dadalto, 2017). Neste modelo, a SES/MG financiaria a atuação do NAT, mas este seria composto por funcionários do HC-UFMG, que teriam ampla liberdade para emitir as notas técnicas. Por fim, desvinculações totais não foram observadas nesse período anterior à criação dos NatJus, mas seriam adotadas em estados como o Rio Grande do Sul e o Paraná, que contam com NatJus estaduais vinculados aos departamentos médicos do TJRS e do TJPR, respectivamente.

2.2.3 NATs atuantes na saúde suplementar

No Paraná, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) local contou, em seu lançamento, em 2013, com médicos cedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pela Secretaria de Estado de Saúde e por operadoras de planos de saúde (TJPR, 2013), sendo o primeiro NAT a atuar também atendendo demandas da saúde suplementar (Vasconcelos, 2020). Em Minas Gerais, o Núcleo de Avaliação em Tecnologia em Saúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (NATS HC/UFMG) atuou, a partir de 2014, elaborando notas técnicas para casos envolvendo saúde suplementar, por meio de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Instituto Brasileiro para Estudo e Desenvolvimento do Setor de Saúde (Nogueira; Carvalho; Dadalto, 2017). Em São Paulo, no

[10] Sobre a atuação desse NAT, cf. também Arruda (2017).

entanto, o terceiro estado a desenvolver convênio desse tipo, é que esta atuação foi a mais controversa.

Foi criado em 2015 junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) o Núcleo de Apoio Técnico e de Mediação (NAT) (Vasconcelos, 2018). Apesar do nome, o NAT de São Paulo diferia significativamente dos demais, porque atuava apenas no âmbito da saúde suplementar.[11] O órgão foi criado mediante termo de cooperação com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge) e a Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) e deveria atuar tanto como espaço de mediação entre operadoras de planos de saúde e consumidores quanto como órgão de apoio técnico responsável por emitir pareceres para instruir decisões judiciais, mas esta função consultiva nunca entrou em funcionamento (Vasconcelos, 2018). No que diz respeito à sua função de mediação, entre sua criação, em outubro de 2015, e agosto de 2016 foram encaminhados ao núcleo para mediação apenas 70 processos, uma média de sete por mês (Cambricoli, 2016). A estimativa é de que ingressavam no tribunal cerca de 400 novas ações por mês, então o NAT estava atuando em menos de 2% dos casos. Além disso, o índice de processos que terminaram em acordos no NAT era bem baixo, de cerca de 10% (Cambricoli, 2016).

O fracasso do NAT SP pode ser parcialmente explicado pela grande oposição feita a ele por entidades de defesa dos direitos dos consumidores. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) liderou campanha criticando o NAT e contou com o apoio do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública de São Paulo (NUDECON); do procurador de justiça Vidal Serrano Nunes Junior, coordenador do Centro de Apoio Operacional Consumidor do Ministério Público do Estado de São Paulo; da Fundação Procon-SP; da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/SP; entre outros. Além da assinatura destas entidades, o IDEC coletou também 2.500 assinaturas em documento entregue ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Oncoguia, 2015).

As principais críticas ao NAT foram sintetizadas em carta enviada ao presidente do TJSP pela Associação Juízes para a Democracia (AJD), que também apoiou a campanha do

[11] Em 2018, com o NAT paulista aqui descrito já não mais em funcionamento, foi criado em São Paulo NatJus que segue os moldes de um NAT padrão, com foco na judicialização contra o SUS. Antes disso, para auxiliar magistrados a decidir demandas contra o SUS, São Paulo contava com o programa "Acessa SUS", uma parceria entre o TJSP e a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES/SP), em que técnicos orientariam os magistrados sobre a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS (TJSP, 2017); e com um grupo de farmacêuticos cedidos pela SES/SP com a função de auxiliar juízes dos Juizados Especiais e juízes da Fazenda Pública da capital em casos que requeiram algum tipo de mediação entre a SES/SP e os usuários antes que as decisões liminares sejam proferidas (Vasconcelos, 2018).

Idec (Rodas, 2015; AJD, 2015). Primeiramente, a AJD defendeu que operadoras de saúde teriam amplas oportunidades extrajudiciais para se autocomporem com as partes, sendo desnecessária atuação conjugada com o Judiciário para este fim. Em segundo lugar, ela argumentou que o condicionamento da apreciação do pedido de tutela de urgência à formulação de proposta de mediação, previsto no Termo de Cooperação Técnica n.º 000.045/2015, que criou o NAT paulista, seria incompatível com o direito do consumidor à facilitação da defesa dos seus direitos (Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII) e afrontaria o artigo 303, § 1º, II, do Código de Processo Civil de 2015, que prevê a autocomposição após a concessão da tutela de urgência. Além disso, a AJD alegou que a atuação do NAT no âmbito da autocomposição liminar extrapolaria o que o CNJ recomendou que os tribunais fizessem no que diz respeito a apoio técnico, retardaria a prestação jurisdicional e poderia resultar em transações inválidas sob a ótica do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade do consumidor perante a operadora. Diante desses argumentos, a AJD requereu a supressão do segmento de mediação liminar do NAT e a manutenção apenas do setor de apoio técnico, que deveria receber uma série de mudanças.

O NAT SP seria composto apenas por representantes das empresas de planos de saúde, sem participantes de entidades de defesa do consumidor, mas, apontou a AJD, o termo de cooperação não indicou: "(i) proveniência e forma de seleção dos profissionais de saúde; (ii) forma de atuação do setor no caso concreto (individual ou colegiada), (iii) forma de escolha dos profissionais que atuarão em determinado processo, (iv) forma e origem da remuneração dos técnicos." [p. 3] Sem essas delimitações, não estaria garantida a idoneidade probatória dos pareceres técnicos emitidos.

Para sanar esses problemas, a AJD propôs que o NAT fosse composto por profissionais sem vinculação direta ou indireta com operadoras e seguros de saúde. Se fosse admitido o ingresso de profissionais indicados por essas entidades, deveria também ser assegurada a participação, de forma igualitária, de profissionais indicados por entidades de defesa dos direitos dos consumidores. Neste caso, a avaliação técnica deveria ser colegiada, em grupos de três profissionais em que fosse assegurada a participação de um profissional indicado por entidade de defesa dos direitos dos consumidores e de um profissional desvinculado.

Além disso, deveria ser publicada previamente listagem contendo os profissionais de saúde que integrariam o NAT e a escolha dos profissionais que atuariam em cada caso deveria observar a ordem da listagem, conforme as respectivas áreas de especialização e ressalvados casos de impossibilidade, impedimento e suspeição e deveria ser aplicada aos profissionais do

NAT a normatização pertinente aos peritos, principalmente no que diz respeito à responsabilidade pelas informações prestadas. Por fim, os profissionais de saúde que compusessem o NAT não poderiam receber qualquer remuneração ou auxílio, a qualquer título, direta ou indiretamente, das operadoras de planos e seguros de saúde.

O NAT englobou, portanto, diversas críticas aplicáveis a NATs pré-processuais e vinculados (com a diferença, é claro – potencialmente um agravante – de que a vinculação era a planos de saúde). Estas críticas levaram a uma reformulação também mal sucedida do NAT, que eventualmente foi descontinuado e substituído por um NatJus aos moldes do NAT do Rio de Janeiro.[12]

2.3 A determinação nacional de disponibilização de apoio técnico a magistrados

Enquanto diferentes estados desenvolviam suas próprias versões do NAT, o CNJ ficou, no que diz respeito à saúde pública, mais de 5 anos sem produzir norma sobre o tema. Somente em setembro de 2016 o CNJ voltaria a atuar sobre ele, agora com nova abordagem.

Por meio da Resolução CNJ n.º 238/2016, o CNJ determinou a criação de comitês estaduais de saúde no âmbito de todos os tribunais de justiça e tribunais regionais federais do país. Esses comitês seriam compostos por membros com diferentes atribuições dentro do poder público, como magistrados e gestores, e teriam como uma de suas funções a de auxiliar os tribunais na criação de Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus[13]) (Resolução CNJ n.º 238/2016, Art. 1º, §1º). De acordo com a nova norma, os NatJus seriam compostos por profissionais da saúde e elaborariam pareceres acerca da medicina baseada em evidências. O CNJ se inspirou no NAT do Rio de Janeiro para desenhar os NatJus (Vasconcelos, 2018).

A Resolução n.º 238/2016 do CNJ representou uma inflexão na atuação do órgão sobre o tema da judicialização da saúde. Por meio dessa norma, o CNJ deixou de apenas recomendar ações para os tribunais e passou a determiná-las. No entanto, o comando manteve-se contido, não estabelecendo prazo para a criação dos NatJus nem estabelecendo sanção em caso de não cumprimento da resolução.

[12] Para mais sobre o assunto, cf. Norões (2018).

[13] Neste primeiro momento, era utilizada a sigla "NATJUS". No entanto, opto por utilizar a sigla atualmente adotada, para evitar qualquer confusão.

Sem prazo fatal, os tribunais de justiça e tribunais regionais federais não se apressaram em criar esses órgãos. Vasconcelos (2018, p. 68) identificou a criação de apenas 11 NatJus até 2018, referentes aos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Tocantins, Mato Grosso, Amapá, Acre e Ceará – estes 3 últimos posteriores à Resolução n.º 238/2016.[14] Para esse levantamento, a autora partiu de relatório do TCU sobre o tema e o atualizou com base nas notícias veiculadas no site do CNJ. Ferreira e Costa (2013) mencionam também a existência de núcleos de apoio técnico no Piauí, no Espírito Santo e em Pernambuco, estados esses não incluídos no levantamento de Vasconcelos (2018). Mesmo supondo que todos os estados em que há registro da criação de órgãos análogos ao NAT antes da Resolução n.º 238/2016 tenham convertido imediatamente essas iniciativas em NatJus, a quantidade de estados que cumpriram a determinação da resolução nos dois primeiros anos após a sua publicação ultrapassa por pouco a metade (14 de 27).[15] Isso quer dizer que quase metade dos estados estiveram pelo menos dois anos em mora com o CNJ. O fato de o comando vir agora como uma determinação do CNJ foi suficiente para movimentar apenas um pequeno conjunto adicional de tribunais.

A demora de muitos estados em criar os NatJus não parece ser explicada por alguma dificuldade em cumprir o que o CNJ esperava dos tribunais. Assim como ocorreu nas Recomendações n.º 31/2010 e 36/2011, a Resolução n.º 238/2016 deixou o formato de funcionamento dos NatJus bastante aberto. O CNJ não emitiu qualquer direcionamento aos tribunais sobre qual estrutura de assessoria técnica seria mais adequada (Duarte, 2017). Em que pese uma recomendação tenha se tornado uma determinação, o comando pareceu o mesmo: tribunais devem agir para fornecer apoio técnico de médicos e farmacêuticos aos magistrados. A continuidade dessa flexibilidade se viu expressa na manutenção de diferenças significativas entre os NatJus: o NatJus do Tocantins continuou atuando extrajudicialmente (TJTO, s/ data), estados como Santa Catarina e Rio de Janeiro atuaram mediante convênios com diferentes instituições parceiras (Vasconcelos, 2018) e alguns estados criaram órgão composto por servidores do próprio tribunal (Duarte, 2017).

Nesse sentido, os tribunais poderiam adotar quaisquer modelos que lhes estivessem à disposição. Não era esperado que do dia para noite fosse ofertado apoio técnico para todos os juízes de um dado tribunal, bastava a criação de projetos-piloto, atendendo poucas varas e

[14] Sobre a criação do NatJus CE, cf. Mariano et al. (2018).

[15] Duarte (2017) encontrou iniciativas de assessoramento técnico em 19 estados. Essa diferença parece estar associada a uma não exigência de Duarte a que a assessoria seja prestada via órgão análogo aos NatJus.

comarcas, para que a determinação fosse cumprida – ao menos até que o CNJ alterasse sua determinação e passasse a ser mais exigente.

Diante desse quadro, para verificar se os tribunais haviam atendido a determinação ou não, pouco mais de um ano depois, em dezembro de 2017, a ministra Cármen Lúcia, então presidente do CNJ, proferiu despacho determinando a autuação de procedimento de acompanhamento de decisão (Acompanhamento de Cumprimento de Decisão n.º 0000020-88.2018.2.00.0000). Neste processo, todos os tribunais de justiça e tribunais regionais federais foram intimados para prestar informações sobre o cumprimento da resolução.

Além de não definir prazo, o comando da resolução não trouxe qualquer determinação concreta específica sobre como os NatJus deveriam ser constituídos. Coube aos tribunais decidir que profissionais de saúde contratar para atuar nos NatJus e como fazer essa contratação, o que fez com que os NatJus assumissem formas com diferenças significativas (Santiago, 2016; Duarte, 2017; Vasconcelos, 2020; 2021), optando por diferentes estratégias quanto à atuação pré-processual e à desvinculação ao Executivo local discutidas no tópico anterior. A única limitação à escolha dos profissionais foi a delimitação de que a criação dos NatJus deveria observar o disposto no art. 156 do Código de Processo Civil Brasileiro, que trata sobre a contratação de peritos. Nesse sentido, o CNJ buscou aproximar os NatJus da figura dos peritos judiciais.

O art. 156 dispõe que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico (art. 156, *caput*) e que os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado (art. 156, § 1º). Para a elaboração desse cadastro de órgãos técnicos ou científicos, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na internet ou em jornais de grande circulação, consultar diretamente universidades, conselhos de classe, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados (art. 156, § 2º). Com possibilidades tão abrangentes de escolha dos profissionais e das instituições credenciadas, os tribunais teriam ampla liberdade para decidir quem deveria compor os seus NatJus. Convém notar que o Executivo local não é mencionado no art. 156, § 2º, mas isso não impediu que diversos estados continuassem contando com NAT composto por funcionários provenientes da Secretaria de Saúde Estadual, como Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pernambuco.

Além disso, de acordo com o art. 156, os tribunais deveriam realizar avaliações periódicas para manutenção do cadastro, levando em consideração a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência de peritos interessados (art. 156, § 3º). Nos locais em que não houvesse inscrito no cadastro do tribunal, a nomeação do perito seria de livre escolha pelo juiz, devendo recair sobre profissional órgão técnico ou científico "comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia" (art. 156, § 5º). Por parte dos órgãos técnicos ou científicos nomeados para realização de perícia, há a obrigação de informar ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da elaboração do parecer, para verificar eventual impedimento ou suspeição (art. 156, § 4º).

Para além dessas poucas limitações, também ficou em aberto exatamente que fontes e quais procedimentos deveriam ser utilizados pelos profissionais dos NatJus para emitir pareceres acerca da medicina baseada em evidências aplicável a cada caso. Como será discutido no próximo capítulo, a liberdade dada pelo CNJ aos tribunais levou a diferentes modelos de NatJus, com resultados também bastante distintos, e a liberdade quanto ao procedimento de análise dos casos muito provavelmente é a principal responsável por isso.

Nesse primeiro momento, portanto, o CNJ deixou em aberto a possibilidade de os NatJus também atuarem pré-processualmente ou não, de se desvincularem das secretarias de saúde estaduais ou não, e de atenderam demandas provenientes da saúde suplementar ou não. A única obrigação instituída pelo CNJ é que deveria haver um NatJus, não importando que molde esse órgão deveria ter, salvo algumas pequenas restrições.

2.4 E-NatJus e NatJus Nacional: sistemas complementares aos NatJus locais

Além de determinar a criação dos NatJus, a Resolução n.º 238/2016 também trouxe comando determinando que os tribunais deveriam criar sítio eletrônico que permita acesso a "banco de dados com pareceres, notas técnicas e julgados na área da saúde, para consulta pelos Magistrados e demais operadores do Direito", que seria criado e mantido pelo CNJ (Resolução CNJ n.º 238/2016, Art. 2º). Essa plataforma foi lançada pela ministra Cármen Lúcia, então presidente do CNJ, em novembro de 2017, sob o nome e-NatJus (Montenegro, 2017).

Em seu modelo inicial, o e-NatJus continha bases de dados como a Biblioteca Cochrane (Montenegro, 2017), especializada em revisões sistemáticas e meta análises de tratamentos médicos. Em outubro de 2018, o ministro Dias Toffoli, que assumiu a presidência do CNJ,

anunciou que a plataforma passou a estar em pleno funcionamento, permitindo que tanto o público externo quanto membros do Poder Judiciário pudessem acessar pareceres e notas técnicas na plataforma (CNJ, 2018). Os pareceres consistem na avaliação em abstrato das evidências científicas sobre uma determinada tecnologia, enquanto as notas técnicas tratam de casos concretos específicos, após provocação de magistrados.[16]

O e-NatJus foi mais especificamente regulamentado pelo Provimento CNJ n.º 84/2019, emitido junto da criação do NatJus Nacional. Este NatJus é fruto de uma parceria entre o CNJ, o Hospital Israelita Albert Einstein e o Ministério da Saúde (Fortunato; Botelho, 2021). Ele iniciou seu funcionamento em agosto de 2019 e fornece o serviço de assessoria técnica 24 horas por dia, sete dias por semana (Montenegro; Genu, 2019; CNJ, [s.d.]) – serviço que nem todos os NatJus locais forneciam e ainda não fornecem.

A partir da criação do NatJus Nacional, os magistrados puderam passar a escolher entre solicitar apoio técnico ao NatJus do seu Estado e ao NatJus Nacional (Provimento CNJ n.º 84/2019, art. 1º, *caput*). As solicitações ao NatJus Nacional são feitas somente por meio do e-NatJus (Provimento CNJ n.º 84/2019, art. 1º, § 1º). Solicitações ao NatJus local podem ser feitas via sistema próprio, caso o tribunal já disponha de sistema destinado a isso, e, nesse caso, o órgão deve alimentar a base de dados do e-NatJus com a nota técnica emitida (Provimento CNJ n.º 84/2019, art. 1º, § 2º).

Ainda sobre esse tema, o Art. 1º, § 4º, do Provimento CNJ n.º 84/2019 contém norma que pode gerar alguma confusão. Estabelece ela o seguinte:

> 4º Nas demandas com pedido de tutela antecipada sob a alegação de urgência, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica nº 051/2018, celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde, o Magistrado, quando tiver a necessidade de apoio técnico do NATJUS NACIONAL, ainda que o Tribunal disponha de sistema próprio, e neste caso, determinará por decisão, a solicitação de nota técnica diretamente por meio do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus).

Apesar de estar limitado a casos com pedido de tutela antecipada sob a alegação de urgência, esse dispositivo pode gerar dúvida inclusive sobre outras hipóteses. Segundo o *caput* e os parágrafos anteriores, o magistrado pode solicitar apoio tanto ao NatJus local quanto ao NatJus Nacional (*caput*), e isso deve ser feito via e-NatJus (*§ 1º*), a não ser que o tribunal já tenha um "sistema próprio de apoio técnico" *(§ 2º*) – nesse caso, o magistrado pode solicitar apoio tanto por meio do sistema do tribunal quanto pelo e-NatJus. Se o magistrado solicitar via

[16] Na plataforma e-NatJus, é feita essa distinção entre parecer e nota técnica, mas a literatura frequentemente utiliza esses termos como sinônimos.

sistema local, o NatJus deve alimentar posteriormente a base de dados do e-NatJus com o seu parecer *(§ 2º*).

Já o parágrafo 4º diz que, em casos com pedido de tutela antecipada sob a alegação de urgência, "ainda que o Tribunal disponha de sistema próprio, e neste caso", se o magistrado precisar do NatJus Nacional, ele deve solicitar nota técnica diretamente ao e-NatJus. Sem o qualificador sobre sistema próprio, o Art. 1º, § 4º, é claro: ele estabelece uma exceção para uma exceção. Magistrados devem, em geral, solicitar apoio via e-NatJus, mas podem fazê-lo via sistema local caso ele exista, a não ser que seja uma demanda urgente: nesse caso, a solicitação precisa ser feita diretamente via e-NatJus e determinada via decisão.

Por que, então, acrescentar o qualificador "ainda que o Tribunal disponha de sistema próprio, e neste caso"? Uma interpretação possível seria a de que, caso o tribunal disponha de sistema próprio de apoio técnico – isto é, tenha já um NatJus local –, o magistrado deve solicitar apoio apenas para o NatJus local, mas o caso de urgência seria uma exceção a isso. No entanto, essa interpretação parece entrar em conflito com os demais itens do art. 1º do provimento, que poderiam ser muito mais categóricos caso houvesse uma proibição geral de consultar o NatJus Nacional caso já exista um NatJus local. Além disso, essa interpretação é conflitante com a prática atual – hoje, existem NatJus em todos os tribunais, e ainda assim o NatJus Nacional é o que mais produz pareceres e não produz mais pareceres sobre casos urgentes que outros NatJus.

A explicação mais simples, e que entendo ser a correta para esse caso, é que se tratou simplesmente de má técnica legislativa. Isso por que há outro elemento que apoia essa tese: de que sistema o dispositivo está falando? O art. 1º, § 2º, fala em "sistema próprio de apoio técnico" – o que compreendo como sendo o próprio NatJus local. Já o § 3º, se refere a "sistema próprio de solicitação de apoio técnico" – o que entendo que pode ser meramente uma página no sistema interno do tribunal em que o apoio é solicitado. O § 4º citado na íntegra acima não especifica qual desses dois sistemas se refere. Havendo pouca clareza quanto a esse ponto, é menos surpreendente que o artigo em si seja pouco claro. Dessa maneira, entendo que o § 4º deve ser compreendido como a exceção da exceção que expliquei acima.

O provimento estabelece um último ponto relevante: os NatJus locais podem utilizar a plataforma para solicitar tutoria para elaboração de suas notas técnicas (Provimento CNJ n.º 84/2019, art. 1º, § 3º). Ao fazer essa solicitação, os NatJus são apoiadas por Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) selecionados pelo Ministério da Saúde e integrantes da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde (REBRATS) (Hossepian Júnior; Rocha, 2018). Essa parceria, concretizada no Termo de Cooperação n.º 021/2016, conta

com recursos provenientes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI). Fora isso, há dispositivos pontuais sobre quem terá acesso ao sistema do e-NatJus (magistrados e servidores dos NatJus) (Art. 3º) e a determinação que o CNJ disponibilizaria manual de uso da plataforma (Art. 4º).

Em conjunto, o e-NatJus, o NatJus Nacional e os NatJus locais foram as bases do atual sistema judicial de avaliação de tecnologias em saúde. Nesse contexto, vale destacar a ausência de trabalhos anteriores que tenham se aprofundado na discussão sobre o NatJus Nacional, que, como será abordado no capítulo seguinte, é atualmente, por uma margem significativa, o NatJus que mais emite notas técnicas.

2.5 Revisão e manutenção do modelo inicial dos NatJus

Em 2021, o CNJ publicou a Resolução n.º 388/2021. Essa norma reestruturou os comitês estaduais de saúde, que passaram a existir vinculados ao Fórum Nacional da Saúde (Art. 1º, parágrafo único) e tiveram suas competências destrinchadas (Art. 2º) e suas composições revistas (Arts. 3º e 4º). Assim como na resolução anteriormente vigente (Resolução CNJ n.º 238/2016), é definida como competência dos comitês estaduais auxiliar na criação dos NatJus (Art. 2º, II). Nesse sentido, essa resolução representou uma oportunidade de se reformular as determinações sobre como devem ser os NatJus. No entanto, não foi isso que aconteceu.

A única mudança implementada acerca dos NatJus foi a definição de que a elaboração das notas técnicas deixou de ter de ser "acerca da medicina baseada em evidências" para ser "baseadas em evidências cientificas de eficácia, acurácia, efetividade e segurança". Nada mais foi dito sobre a formatação dos NatJus, que puderam, portanto, continuar assumindo uma variedade de modelos diferentes.

Além desse dispositivo, a resolução trouxe as determinações de que um profissional integrante do NatJus, indicado pelo magistrado que o coordena, deveria integrar o comitê estadual de saúde (Art. 3º, III); de que compete ao coordenador do comitê e, na sua ausência, ao vice-coordenador supervisionar as ações do NatJus (Art. 6º, VII); de que os tribunais devem disponibilizar espaço eletrônico para "ampla divulgação das ações do Comitê Estadual de Saúde e do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) local, bem como a relação dos seus integrantes ou instituições que compõem esses órgãos" (Art. 10, II); e de que compete ao tribunal a que estiver vinculado o coordenador do comitê estadual de saúde designar um

servidor para alimentar a plataforma e-NatJus com as notas técnicas produzidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) (Art. 11, II).

Os acréscimos à regulamentação dos NatJus, portanto, buscam promover uma maior participação dos NatJus nos comitês estaduais de saúde; um maior controle do NatJus pelo comitê; uma maior divulgação das atividades do NatJus e de quem são os seus integrantes; e a garantia de disponibilização das notas técnicas produzidas pelo NatJus local ao e-NatJus, reforçando, neste caso, as determinações provenientes do Provimento CNJ n.º 84/2019. Essas melhorias buscam aperfeiçoar a atuação dos NatJus, mas é interessante notar que nenhuma delas interfere na atuação em si do órgão, promovendo maior celeridade ou qualidade dos pareceres.

Somente em novembro de 2023 o CNJ começou a aventar a possibilidade de mudanças estruturais aos NatJus. Neste mês, o CNJ instituiu, por meio da Resolução n.º 530/2023, a Política Judiciária de Resolução Adequada das Demandas de Assistência à Saúde. A política instituída por essa resolução tem duração de seis anos, contados a partir de janeiro de 2024, e contém 16 eixos de atuação, fazendo o sistema NatJus parte de seis deles.

O eixo 2 prevê a revisão de tabelas e formulários do e-NatJus e o aprimoramento dos bancos de notas técnicas e pareceres, visando fomentar a utilização do e-NatJus na magistratura nacional. Assemelha-se a esse eixo o 9, que tem como objetivo melhorar a plataforma e-NatJus, aprimorando a sua funcionalidade de busca e integrando-a aos sistemas de gestão processual dos tribunais. Estes eixos parecem buscar enfrentar o fato de que nem todos os NatJus têm utilizado sistematicamente o e-NatJus – como será debatido no capítulo seguinte – e que os magistrados não têm ainda o costume de buscar notas anteriores para decidir, preferindo pedir nova opinião ao órgão mesmo em caso semelhante aos demais.

No eixo 3, é determinada a criação de programa de capacitação de profissionais de saúde para integrar os NatJus, que consistiria na promoção de cursos de atualização de profissionais e no aprimoramento do sistema e da plataforma dos e-NatJus. Com esse programa, seria formalizada em resolução do CNJ iniciativa já existente, em que o Hospital Sírio-Libanês (HSL), entre 2018 e 2020 e depois novamente em 2023, com financiamento do PROADI, forneceu treinamento técnica a diversos NatJus (Toledo *et al*., 2024). Entre os eixos dessa iniciativa, são relevantes para a presente pesquisa o fato de que o HSL desenvolveu atividades para fortalecer os NatJus no que diz respeito ao uso de ferramentas, conceitos e métodos propostos pelas áreas de Medicina Baseada em Evidências e Avaliação de Tecnologias em Saúde, e para ensinar e qualificar servidores dos NatJus a melhorar o desenvolvimento das notas técnicas que irão emitir (Toledo *et al*., 2024).

Com funcionários com cargos oficializados, que passam por formações, a tendência é que o resultado que eles irão produzir mude. Para que isso tenha efeito positivo, entretanto, é necessário que o órgão tenha clareza em relação à para que ideal pretende mudar: colocados em uma sala os funcionários dos NatJus de São Paulo e Distrito Federal, que decidem de maneira tão diferente (Dias Júnior, 2023), que tipo de formação cada um desses grupos deve ter? A formação deve buscar uniformizar a atuação desses diferentes órgãos? Se sim, uniformizar utilizando que forma de pensar e agir? A resposta a essas perguntas depende de um nível de detalhamento acerca do que é esperado dos NatJus que o CNJ até agora não apresentou. A implementação da política aqui discutida pode, por isso, representar um segundo ponto de inflexão na atuação do CNJ junto aos NatJus rumo ao desenho de órgãos que possam exercer um maior e melhor impacto nas decisões judiciais. Nesse sentido, é curioso ver que o CNJ optou por não interferir normativamente na definição de que procedimentos e métodos os NatJus utilizariam para emitir suas decisões, mas permitiu que o HSL, por meio de formações técnicas, influenciasse os NatJus na escolha deles. Ou seja, o CNJ não interferiu diretamente nos procedimentos decisórios dos NatJus, mas escolheu instituição para tentar interferir indiretamente para que estes órgãos a adotem certas técnicas e métodos.

Os três eixos de atuação restantes retomam discussões anteriores sobre modelos alternativos ao NAT. O eixo 8 tem como meta fomentar a integração da saúde suplementar ao NatJus Nacional. Para isso, planeja-se cooperar com órgãos e entidades públicas e privadas competentes para permitir que a magistratura nacional utilize o e-NatJus também para atender demandas relacionadas à Saúde Suplementar. No eixo 10, é estipulado que será elaborado um projeto-piloto para testar a expansão da atuação dos NatJus para uma atuação pré-processual, isto é, anterior à judicialização, a partir de demandas de advogados e membros das Defensorias Públicas. No eixo 13, é instituída a meta de criação de cargos de servidores dos NatJus, que seria alcançada por meio do fomento da oficialização dos órgãos internos dos tribunais e da criação de estrutura administrativa de apoio e cargos para os profissionais de saúde que compõem o NatJus. Assim, em alguma medida, cada um dos modelos alternativos ao NAT apresentados anteriormente podem passar a compor o NatJus em si. Para a implementação de cada um destes eixos, as lições tiradas de tentativas anteriores podem e devem ser estudadas. Exemplo disso é o próprio eixo 8, que, ao atribuir a emissão de pareceres ao NatJus Nacional, pode evitar muitas das críticas que o NAT de São Paulo recebeu.

* * *

O que começou como uma iniciativa da SES/RJ e do TJRJ inspirou outros tribunais e até o CNJ, que tornou obrigatório que todos os tribunais criassem órgãos semelhantes ao NAT. Ao fazer isso, no entanto, o CNJ não avaliou e se posicionou acerca das diferentes formas que estes novos órgãos poderiam assumir, deixando para que os tribunais tomassem essa decisão. As consequências disso são discutidas no próximo capítulo.

3 NATJUS EM NÚMEROS

Atualmente, notas técnicas de todos os NatJus são organizadas para compor a plataforma e-NatJus (Vasconcelos, 2020). Estudos anteriores já analisaram notas técnicas ali disponíveis, mas sempre tendo como foco algum tipo de tecnologia específica, como anticoagulantes (Almeida et al., 2022; Domingues et al., 2023), o medicamento Zolgensma (Dias Júnior, 2023; Gomes et al., 2023) ou produtos à base de canabidiol (Portela et al., 2023; Gonçalves et al., 2024).

No entanto, ao fazer apenas essas análises focalizadas em tecnologias específicas, a literatura deixa uma lacuna metodológica e outra substancial. Metodologicamente, perde-se o principal benefício oferecido pela plataforma e-NatJus: o tamanho e a padronização de sua base de dados. Se o e-NatJus não existisse, seria necessário coletar dados em plataformas diferentes para cada NatJus, ao invés de serem coletados dados a partir de um único site. Mais relevante que isso, no entanto, é o fato de que o e-NatJus demanda um modelo padronizado de parecer: todos os NatJus preenchem os mesmos campos de um questionário ao incluir uma nota técnica na plataforma. Sem essa padronização, seria bastante difícil realizar qualquer comparação entre NatJus sem investir muito tempo e pessoal para poder, além de coletar informações de cada um dos tribunais, organizar as informações sobre os pareceres de maneira que permita a sua comparação, o que dificultaria a realização de pesquisas de grande porte. Com o e-NatJus, é possível coletar centenas de milhares de notas técnicas totalmente padronizadas e, por isso, prontas para análise.

No que diz respeito à lacuna substancial, aliada da lacuna metodológica apresentada, cabe destacar que o foco em doenças específicas impede a análise dos NatJus de um ponto de vista institucional, isto é, o que os dados dizem sobre a atuação dos NatJus em si. O único trabalho que utiliza o e-NatJus para comparar a atuação de diferentes NatJus é Dias Júnior (2023).[17] O autor comparou as notas técnicas emitidas pelo NatJus SP e pelo NatJus DFT entre janeiro de 2021 e novembro de 2022 sobre o medicamento Zolgensma. No período analisado, o NatJus SP emitiu 18 notas desfavoráveis à concessão do medicamento e nenhuma favorável, enquanto o NatJus DFT concedeu nenhuma nota desfavorável e 21 favoráveis. Para chegar a resultados tão distintos, os órgãos adotaram procedimentos também bastante diferentes.

[17] Outros trabalhos que comparam NatJus diferentes, como Duarte (2017) e Vasconcelos (2018), focam em seu funcionamento, não discutindo a produção de pareceres de cada um desses órgãos.

O NatJus SP utilizou como base para decidir a manifestação mais atualizada da CONITEC à época. A ausência de um pronunciamento positivo da CONITEC para a incorporação do medicamento foi considerada um fator relevante e o NatJus SP também apontou para a ausência de evidências técnicas sobre a eficiência do tratamento e seu alto custo. O NatJus DFT, por sua vez, reanalisou estudos clínicos e científicos, concluindo pela eficácia do medicamento e sua superioridade em relação às terapias incorporadas ao SUS. Além disso, adotou entendimento distinto quanto ao custo, mencionando análises de custo-oportunidade realizadas pelas agências de avaliação de tecnologias em saúde da Inglaterra e do Canadá para argumentar que a dosagem única do Zolgensma se justificaria frente aos custos dos tratamentos contínuos que concorrem com o Zolgensma.

Os dados coletados por Dias Júnior (2023) demonstram, em primeiro lugar, as dificuldades inerentes associadas à elaboração de notas técnicas baseadas em evidências cientificas de eficácia, acurácia, efetividade e segurança ou na Medicina Baseada em Evidências, como manda o CNJ. Diferentes profissionais, mesmo que igualmente capacitados, podem chegar a conclusões diametralmente opostas. Nesse sentido, as chances de fenômeno de grande divergência como esse acontecer apenas em relação a dois NatJus e um único medicamento são bastante baixas, considerando que existe pelo menos um NatJus por estado e são requisitados inúmeros medicamentos diferentes.

Este capítulo tem como objetivo central utilizar o ganho metodológico decorrente de se analisar mais de 200 mil notas técnicas sobre medicamentos para descrever como tem sido a atuação dos NatJus e verificar a existência de mais divergências entre eles. Os resultados encontrados reforçam o quadro identificado por Dias Júnior (2023) acerca da existência de enormes e consistentes divergências entre os NatJus e promovem o diagnóstico de que a falta de avaliação do Judiciário acerca da política institucional dos NatJus pode estar ativamente contribuindo para o fortalecimento de desigualdades no acesso a tratamentos de saúde, quando deveria estar atuando ativamente para reduzir esse problema.

3.1 Coleta de notas técnicas do e-NatJus sobre medicamentos

Compilei base de dados com todos as notas técnicas sobre medicamentos publicados na plataforma e-NatJus entre a sua criação e o dia 31 de dezembro de 2024. A opção por focar em medicamentos, deixando de lado produtos e procedimentos, se deu pelos medicamentos serem

o tipo de tecnologia mais avaliado pelos NatJus, o mais estudado pela judicialização da saúde e por entender que este seria o tipo de tecnologia em que discussões regulatórias seriam mais controversas – como a decisão recente do STF no âmbito do Tema 6 indica.

Para realizar a coleta das notas técnicas, desenvolvi código em *python* que passou sequencialmente por todas as notas, do número 1 ao número 300.000. Isso foi possível porque todas as notas técnicas têm a mesma estrutura de link, a junção entre "https://www.pje.jus.br/e-NatJus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=" e o número da nota técnica. Das 300.000 primeiras notas técnicas, 35.621 não estavam disponíveis, seja por não serem indicadas como existentes, seja por demandarem login na plataforma para serem consultadas. Das notas técnicas restantes, 2.626 foram eliminadas por terem sido produzidas em 2025, restando 261.753 notas técnicas.

Desde pelo menos setembro de 2021, a plataforma permite que os NatJus juntem mais de uma nota técnica em um só *link*. Assim, em caso de pacientes que demandam mais de uma tecnologia, em vez de publicar notas técnicas separadamente, como se não houvesse nada em comum entre elas, é possível publicar, em um só *link*, notas técnicas sobre todos os medicamentos requeridos. Isso ocorreu em 50.751 das notas técnicas raspadas. A quantidade de notas técnicas agregadas em um só *link* variou de 2 a 42, e uma soma total de 197.877. Contabilizando separadamente as notas técnicas agregadas desta maneira, o total parcial da base de dados era de 408.879 notas técnicas.

No entanto, para a raspagem dessas notas técnicas agregadas em um só *link*, é necessária nova etapa de raspagem de dados. A raspagem inicial se baseou no conteúdo recebido do servidor do site quando se tenta acessá-lo e esse conteúdo contém apenas a primeira nota técnica do *link*. Para acessar as demais notas técnicas, é necessário clicar em certas partes da página, o que não é possível de ser realizado utilizando esse primeiro método de coleta de dados. Para resolver isso, foi elaborado novo programa em *python*, dessa vez usando a biblioteca *selenium*, que permite que, de maneira automatizada, sejam simulados os cliques necessários para coletar os dados sobre todos as notas técnicas.

Para a realização dessa segunda etapa de raspagem de dados, a base de dados foi dividida em duas: a de notas técnicas simples e a de notas técnicas múltiplas. No caso das notas técnicas simples, foram identificadas as notas técnicas que tratavam de medicamentos e elas foram salvas para posterior tratamento e análise. De 211.002 notas simples, sobraram 109.419.

Já as notas técnicas múltiplas foram identificadas e foram raspadas novamente, utilizando o método descrito. Esta nova etapa resultou em 187.138 notas técnicas. 10.739 notas

não puderam ser acessadas – em diversos casos, ao menos uma das notas técnicas estava indisponível por nunca ter sido concluída ou demandar login para ser acessada. Excluindo as notas técnicas duplicadas, as notas técnicas sobre procedimentos e produtos e as notas técnicas proferidas já em 2025, restaram 142.777, que se somaram às 109.419 notas técnicas simples previamente identificadas para um conjunto final de 252.196 notas técnicas.

Em que pese nem todos os dados fornecidos pela plataforma sejam úteis para esta pesquisa, foram coletadas todas as informações disponíveis na plataforma. Com isso, pretendo facilitar que outros trabalhos utilizem os dados disponíveis no e-NatJus.

Para fins deste capítulo, no entanto, são relevantes os dados sobre a conclusão da nota técnica (se favorável ou não à concessão do tratamento); qual é a doença do paciente (CID 10); qual é o princípio ativo pleiteado; a data de emissão da nota; se o medicamento requerido tem registro na Anvisa; se o medicamento foi prescrito em conformidade com a indicação aprovada no registro (isto é, se é indicado *off label* ou não); se o medicamento é previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante; se o medicamento está inserido no SUS; qual é a recomendação da CONITEC para o fornecimento do medicamento na situação clínica do demandante; e, por fim, que instituição emitiu a nota técnica.

O dado sobre que instituição emitiu a nota técnica era de preenchimento aberto, o que tornou necessária a sua padronização. Para fins de exemplo, cito as menções ao Hospital Israelita Albert Einstein, responsável pelo NatJus Nacional. Foram 176 as formas distintas como o responsável por incluir a nota técnica na plataforma se referiu ao hospital, incluindo diversas combinações de minúsculas e maiúsculas, abreviações e erros de ortografia. Não foi possível identificar a instituição que emitiu a nota técnica em 1.897 casos – nestas notas técnicas, o preenchimento dessa variável se limitou principalmente a menções genéricas a ‘Nat Jus’, sem especificar qual.

Em que pese tenha sido determinada a criação de um NatJus por cada comitê estadual de saúde, alguns estados contam com mais de uma instituição conveniada para emitir notas técnicas, o que se manifestou na identificação das notas. O principal caso em que isso ocorre é o Rio Grande do Sul, em que o tanto o Departamento Médico Judiciário do TJRS (DMJ/TJRS) quanto o TelessaúdeRS, órgão de avaliação de tecnologias em saúde vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já emitiram milhares de notas técnicas.

Nos demais estados com mais de uma instituição conveniada, entretanto, a dispersão de notas entre órgãos levou a quantidades pequenas de notas técnicas emitidas por parte

significativa delas. No Paraná, encontramos menções ao NatJus PR em si em 4.192 casos, mas também ao Centro de Assistência Médica e Social do TJPR (CAMS/TJPR) em 603 casos, ao Centro Hospitalar de Reabilitação em 162 casos, à Universidade Estadual de Londrina em 85 casos e à Universidade Federal do Paraná em 76 casos. Como, com exceção do CAMS/TJPR, essas amostras são relativamente pequenas, optei por, para facilitar a visualização dos dados, juntar todos esses órgãos sob a classificação de NatJus PR.

Tratamento semelhante ocorreu em relação a instituições do Amazonas e de São Paulo. No Amazonas, o NatJus local tem tanto convênio firmado com a secretaria municipal quanto com a secretaria estadual de saúde, com 100 e 389 notas técnicas emitidas por cada uma, respectivamente. Além delas, encontrei 18 menções que não especificavam qual das duas secretarias emitiu a nota técnica, apenas fazendo referência ao NatJus AM. Como essas amostras são também relativamente pequenas, optei por juntar as menções a estes três órgãos sob a classificação 'NatJus AM'. Em São Paulo, além de menções ao NatJus SP, há 144 menções ao Hospital das Clínicas da USP, que é uma das instituições conveniadas com o TJSP.[18] Como na maioria dos casos não é possível identificar, a partir dos dados raspados, que instituição conveniada concedeu a nota técnica do NatJus SP, incluí as notas técnicas identificadas como tendo sido emitidos por este hospital junto às demais classificadas como emitidas pelo NatJus SP.

Por fim, houve 150 casos em que a instituição declarada foi o NatJus RS. Como não foi possível, nestes casos, identificar se a nota técnica foi emitida pelo DMJ/TJRS ou pelo TelessaúdeRS, optei por juntar estes casos aos demais casos em que não foi possível identificar que instituição emitiu a nota técnica. Restaram, portanto, 26 NatJus locais, duas instituições que atuam como NatJus no Rio Grande do Sul e o NatJus Nacional.

A distribuição final das notas técnicas por instituição pode ser conferida na Tabela 1. Em que pese esses tratamentos dos dados tenham sido necessários para facilitar as análises aqui realizadas, destaco que se, como será demonstrado, existe grande diferença entre cada instituição que emitiu notas técnicas, não há motivo para acreditar que não haja diferenças substanciais também entre diferentes instituições conveniadas para emitir notas técnicas em nome de um mesmo NatJus. Nesse sentido, trabalhos posteriores, com maior quantidade de dados, poderão trazer maior detalhamento para a comparação entre instituições de um mesmo Estado.

[18] São também conveniadas a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp), o Hospital E. Jesus Zerbini, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) e a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (TJSP, [s.d.]).

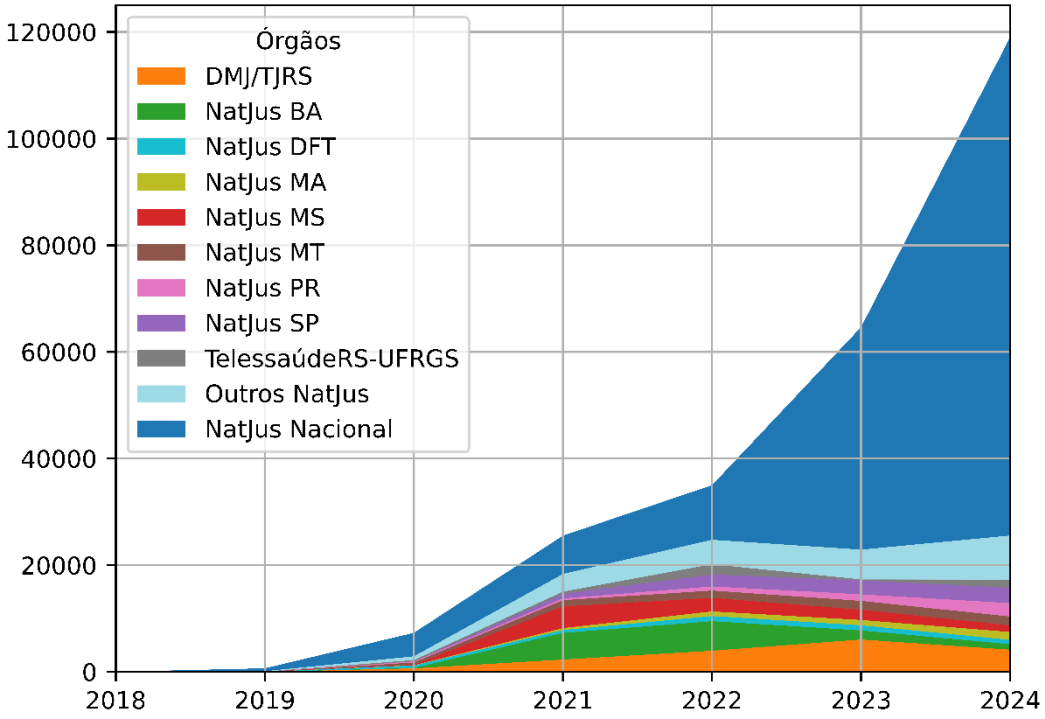
No que diz respeito à análise de dados, elaborei estatísticas descritivas sobre a quantidade de notas técnicas emitidos por cada NatJus. Para isso, quando elaborei gráficos, utilizei a biblioteca *matplotlib*, com a paleta de cores *tab20*. Os dados sobre padrão decisório incluem apenas subconjuntos de 100 ou mais notas técnicas.

Os códigos e as bases de dados utilizadas para a elaboração deste capítulo estão disponíveis em: <https://osf.io/xuptj/>. Por não serem pertinentes ao objetivo deste capítulo, não os discuto, mas dados sobre os principais princípios ativos, os principais grupos de doenças e os principais CIDs encontrados nos pareceres de cada NatJus podem ser encontrados na pasta "Capítulo 3/4 Analise/0 Descritivos gerais" do *link* disponibilizado acima.

3.2 Produção de notas técnicas e inclusão no e-NatJus

O número de notas técnicas sobre medicamentos acrescentados à plataforma e-NatJus aumenta anualmente desde a sua criação (Figura 1). No entanto, em anos recentes, esse crescimento foi puxado principalmente pela atuação do NatJus Nacional, que atende magistrados todos os tribunais. Em 2019 e 2020, quando o e-NatJus ainda era incipiente, o NatJus Nacional anexou à plataforma mais notas técnicas que todos os demais NatJus juntos, mas, em 2021 e 2022, isso deixou de acontecer. Em 2023, ocorre um crescimento estrondoso do NatJus Nacional, que aumentou em 308% sua produção de notas técnicas e passou a emitir mais que duas vezes o número de notas técnicas que os demais NatJus somados. Em 2024, o NatJus Nacional dobra de tamanho e passa a produzir quase quatro vezes o número de notas técnicas emitidas pelos demais NatJus.

Figura 1. Produção anual de notas técnicas sobre medicamentos



Fonte: elaboração própria.

Em parte, essa discrepância pode ser explicada pelo fato de que o NatJus Nacional, por ser nativo à plataforma e-NatJus – suas notas técnicas podem ser requisitadas tão somente por esta –, inclui no e-NatJus a totalidade das notas técnicas que produz, o que não ocorre em todos os NatJus. O maior exemplo disso é o NatJus MG. Apesar de atender o estado com a segunda maior população do país, o NatJus MG juntou apenas 40 notas técnicas à plataforma, todos em 2020. Em sua biblioteca digital, por outro lado, estão disponíveis mais de 3 mil notas técnicas (TJMG, [s.d.]).

Além do NatJus MG, também abandonaram o e-NatJus os NatJus AP, GO, PI e SC (Tabela 1). Nenhum destes NatJus incluiu no e-NatJus qualquer parecer em 2024 – PI e SC não o fazem desde 2023, para ser mais preciso. Como todos esses NatJus continuam em atuação, vemos que isso é explicado não pela baixa produção de notas, mas pelo desinteresse em incluí-las no e-NatJus. E essa falta de desinteresse persiste mesmo que, em 2021, o CNJ tenha determinado que compete ao tribunal a que estiver vinculado o coordenador do Comitê Estadual de Saúde local "designar um servidor para alimentar a plataforma E-NatJus, com as notas técnicas produzidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus)" (Resolução CNJ n.º 388/2021).

Tabela 1. Notas técnicas incluídas na plataforma e-NatJus, por NatJus, por ano

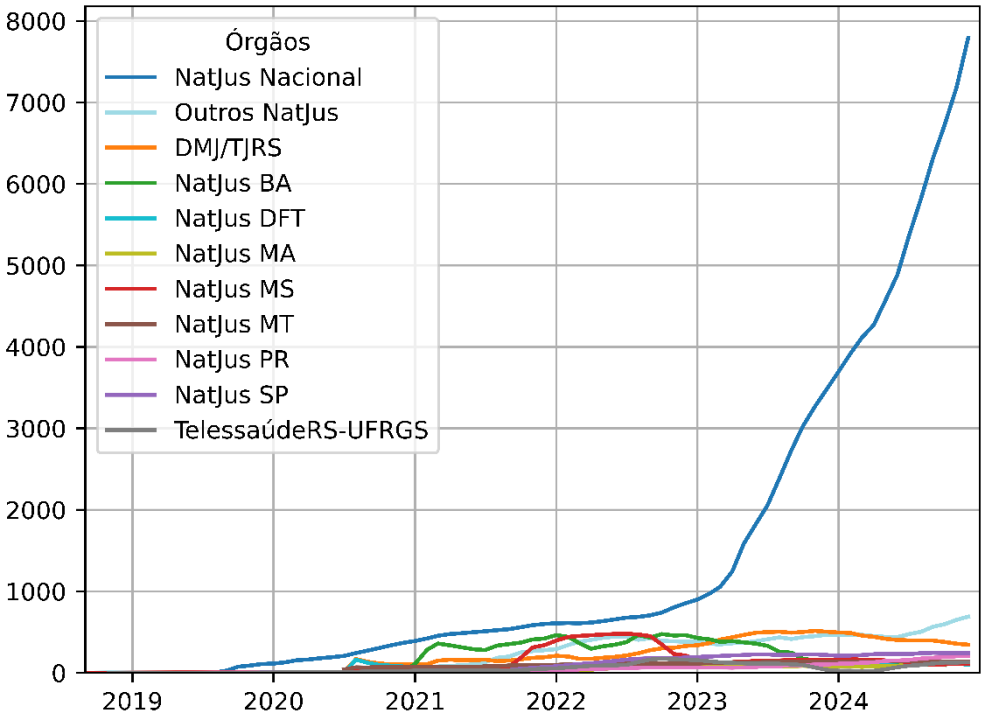
NatJus	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
DMJ/TJRS	0	0	636	2.290	3.948	6.045	4.139	17.058
NatJus AC	0	9	34	21	90	160	136	450
NatJus AL	0	0	0	0	5	2	507	514
NatJus AM	0	0	2	10	9	153	333	507
NatJus AP	0	0	0	0	1	2	0	3
NatJus BA	0	1	84	5.002	5.550	1.714	1.017	13.368
NatJus CE	0	0	0	0	0	4	55	59
NatJus DFT	0	0	465	536	950	956	829	3.736
NatJus ES	0	0	0	10	33	1.968	1.511	3.522
NatJus GO	0	0	0	1.006	807	103	0	1.916
NatJus MA	0	0	43	366	878	1.002	1.480	3.769
NatJus MG	0	0	40	0	0	0	0	40
NatJus MS	1	0	90	4.059	2.541	1.935	1.229	9.855
NatJus MT	0	0	428	1.174	1.361	1.641	1.669	6.273
NatJus Nacional	0	537	4.404	7.185	10.236	41.737	93.492	157.591
NatJus PA	0	0	22	7	8	70	229	336
NatJus PB	0	0	0	0	0	59	368	427
NatJus PE	0	0	0	691	554	604	598	2.447
NatJus PI	1	0	0	53	44	0	0	98
NatJus PR	0	37	184	334	777	1.232	2.512	5.076
NatJus RJ	0	0	41	557	1.230	768	799	3.395
NatJus RN	0	52	92	332	581	543	738	2.338
NatJus RO	0	0	1	0	0	0	1	2
NatJus RR	0	0	31	39	16	198	466	750
NatJus SC	4	0	18	259	91	0	0	372
NatJus SE	0	0	224	211	534	894	566	2429
NatJus SP	0	4	6	853	2.239	2.618	2.881	8.601
NatJus TO	3	5	194	61	95	2	185	545
Não preenchido	0	0	18	66	125	69	1.769	2.047
TelessaúdeRS-UFRGS	1	5	252	411	1.926	168	1.539	4.302
Total	10	650	7.309	25.533	34.629	64.647	119.048	251.826
Total sem NatJus Nacional	10	113	2.905	18.348	24.393	22.910	25.556	94.235

Fonte: elaboração própria.

Quanto aos demais NatJus, por mais que possa haver algum descolamento entre a data em que cada nota técnica foi emitida e quando ela foi incluída na plataforma, não parece haver motivos para acreditar que os NatJus que incluíram mais pareceres no e-NatJus tenham deixado de incluir notas técnicas em ordem de magnitude que equilibre a quantidade de notas técnicas emitidas pelos NatJus locais e pelo NatJus Nacional. Assim sendo, o NatJus Nacional realmente produz notas em quantidade significativamente superior ao de qualquer outro NatJus. Isso fica

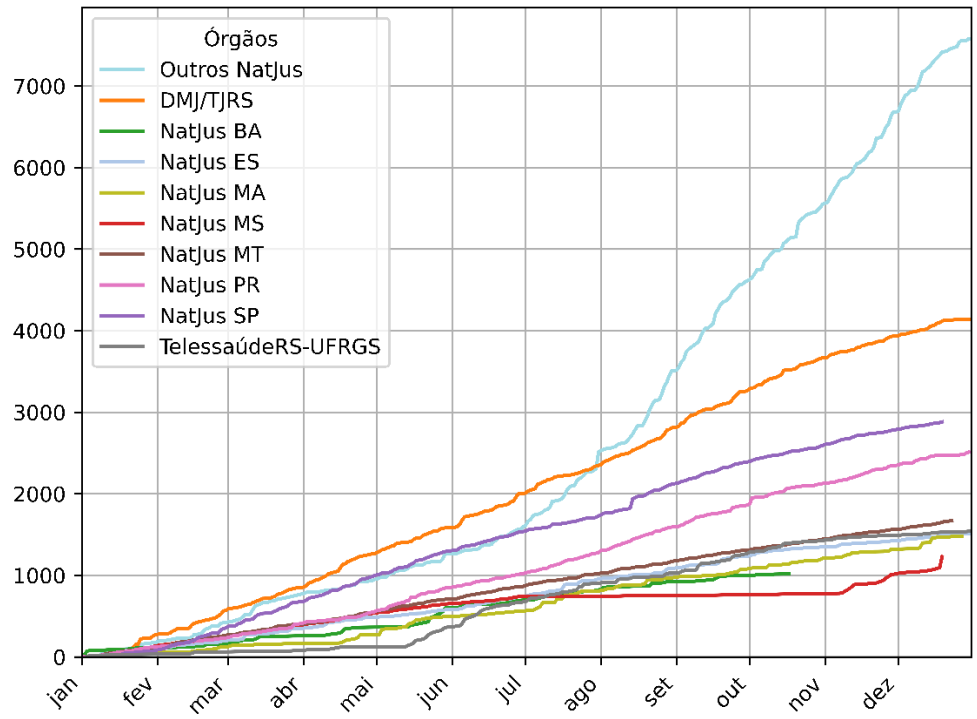
ainda mais claro ao observarmos a média móvel de produção de pareceres a cada 12 meses (Figura 2).

Figura 2. Média móvel de pareceres incluídos na plataforma e-NatJus (12 últimos meses)



Fonte: elaboração própria.

Figura 3. N.º acumulado de notas técnicas incluídas no e-NatJus em 2024, sem o NatJus Nacional



Fonte: elaboração própria.

Tabela 2. Número de notas técnicas por cem mil habitantes

NatJus	N.º notas técnicas (2024)	População do Estado	N.º de notas técnicas por cem mil habitantes
NatJus RR	466	636.303	73,2
NatJus RS*	5.678	10880.506	52,2
NatJus MT	1.669	3.658.813	45,6
NatJus MS	1.229	2.756.700	44,6
NatJus ES	1.511	3.833.486	39,4
NatJus DFT	829	2.817.068	29,4
NatJus SE	566	2.209.558	25,6
NatJus RN	738	3.302.406	22,3
NatJus PR	2.512	11.443.208	22,0
NatJus MA	1.480	6.775.152	21,8
NatJus AC	136	830.026	16,4
NatJus AL	507	3.127.511	16,2
NatJus TO	185	1.511.459	12,2
NatJus PB	368	3.974.495	9,3
NatJus AM	333	3.941.175	8,4
NatJus BA	1.017	14.136.417	7,2
NatJus PE	598	9.058.155	6,6
NatJus SP	2.881	44.420.459	6,5
NatJus RJ	799	16.054.524	5,0
NatJus PA	229	8.116.132	2,8
NatJus CE	55	8.791.688	0,6
NatJus RO	1	1.581.016	0,1
NatJus AP	0	733.508	0,0
NatJus GO	0	7.055.228	0,0
NatJus MG	0	20.538.718	0,0
NatJus PI	0	3.269.200	0,0
NatJus SC	0	7.609.601	0,0

Fonte: elaboração própria.

* Neste caso, junto o DMJ/TJRS e o TelessaúdeRS-UFRGS porque ambos os NatJus atendem a população do Rio Grande do Sul.

A inclusão de notas técnicas produzidas pelos NatJus locais ao e-NatJus teve um crescimento tímido em 2018 e 2019, no início do e-NatJus. De 2019 para 2020, o número de notas emitidas e incluídas na plataforma e-NatJus cresce de 113 para 2.905 e, no ano seguinte, para 18.349. Nos anos seguintes, se consolida na faixa de cerca de 25 mil notas técnicas anuais, com uma queda para 23 mil notas técnicas em 2023.

A redução na produção de notas técnicas pelos NatJus estaduais ocorrida em 2023 se deu principalmente na redução de notas acrescentadas pelo NatJus BA à plataforma. Em 2021 e 2022, o NatJus BA foi, depois do NatJus Nacional, o NatJus que mais incluiu notas técnicas na plataforma, superando nos dois anos a quantia de 5000 notas técnicas. Em 2023, o órgão passou para a 5ª colocação, com cerca de 1700 pareceres e, em 2024, caiu novamente, indo para

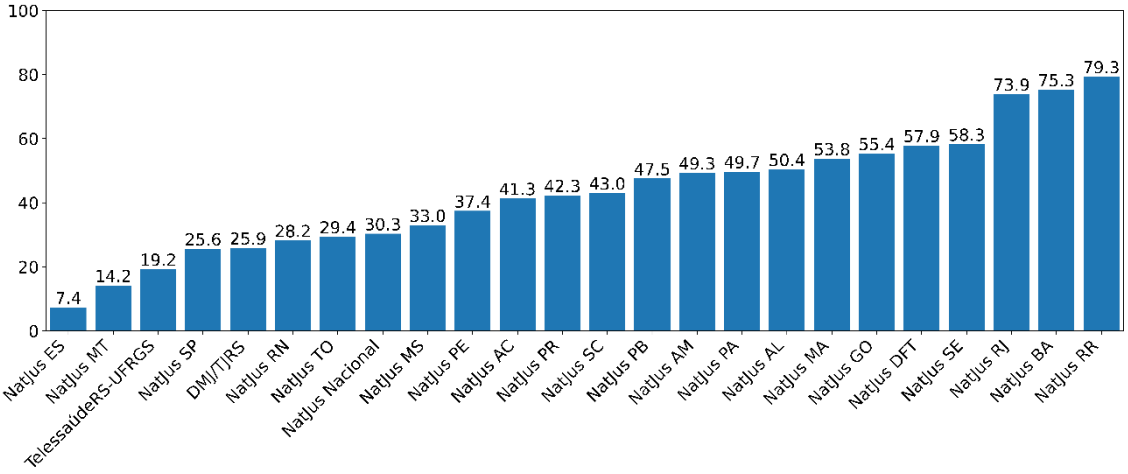
a 10ª colocação, com 1000 pareceres. Também diminuíram a inclusão de notas técnicas na plataforma naquele ano o NatJus GO, o NatJus MS e o TelessaúdeRS-UFRGS. Os dois primeiros seguiram em queda no ano seguinte, enquanto o TelessaúdeRS voltou ao patamar anterior no ano seguinte.

Em 2024, os NatJus que mais produziram pareceres foram o DMJ/TJRS, o NatJus SP e o NatJus PR (Figura 3). Controlando pela população do Estado (Tabela 2), no entanto, é interessante notar uma alta produção de notas técnicas pelo NatJus RR, MT e MS, além do RS, que, além de contar com o NatJus que mais juntou pareceres ao e-NatJus, é o único que conta, em número de pareceres, com duas grandes instituições conveniadas. Estes dados indicam grande discrepância entre os tribunais no que diz respeito ao uso dos NatJus e o uso destes da plataforma e-NatJus.

3.3 Como os NatJus decidem

Diferentes NatJus têm taxas de emissão de notas técnicas favoráveis à concessão dos medicamentos pleiteados significativamente diferentes (Figura 4). O NatJus ES concedeu apenas 7,4% de notas técnicas favoráveis à concessão de medicamento, pouco mais da metade do quanto o segundo colocado concedeu. Enquanto isso, três NatJus emitiram cerca de dez vezes mais notas técnicas favoráveis que o NatJus ES: os NatJus do Rio de Janeiro, da Bahia e de Roraima.

Figura 4. Taxa de emissão de notas técnicas favoráveis à concessão do medicamento, por NatJus



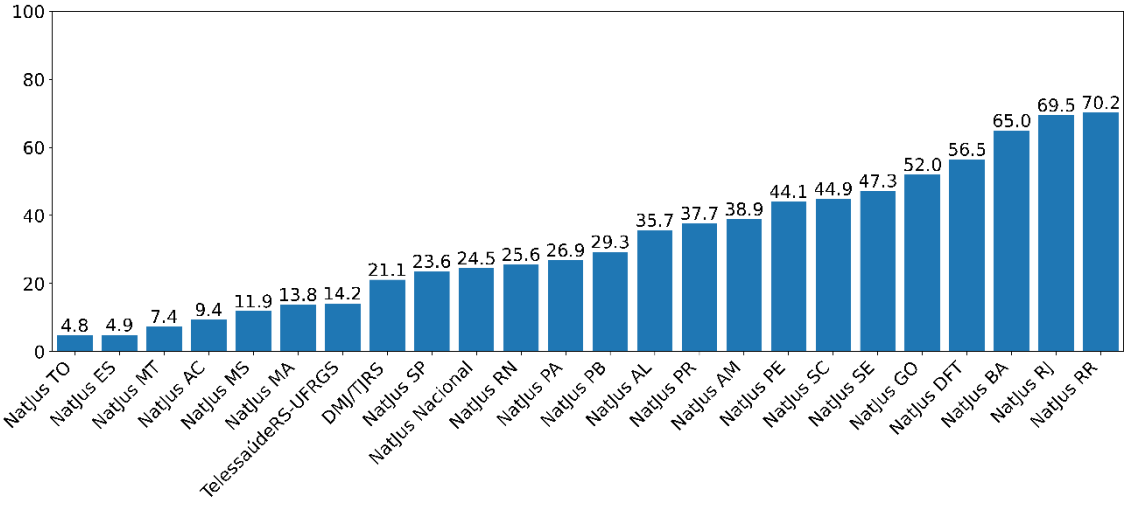
Fonte: elaboração própria. São incluídos apenas os NatJus que emitiram pelo menos 100 notas técnicas.

Esse resultado é especialmente interessante por demonstrar que a composição do NatJus não explica – ao menos não integralmente – o padrão decisório de um NatJus. Tanto o NatJus

do Espírito Santo quanto o NatJus do Rio de Janeiro estão associados às secretarias de saúde de seus respectivos estados, mas, no período analisado, estiveram em polos opostos na distribuição de decisões favoráveis.

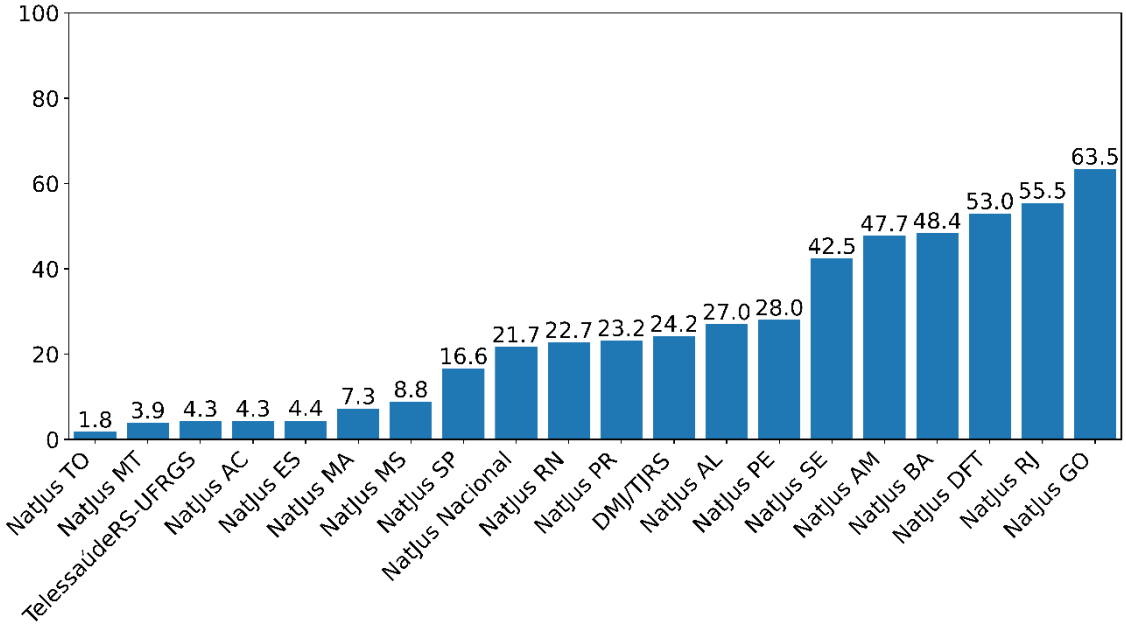
Uma hipótese que poderia explicar essa grande diferença na taxa de emissão de notas técnicas favoráveis à concessão de medicamentos entre diferentes NatJus seria a de que essa diferença estaria associada não a características dos NatJus em si, mas sim do conjunto de medicamentos que eles analisaram. Se um NatJus analisa mais pedidos de medicamentos sem comprovação de eficácia, seria esperado que ele concedesse menos decisões favoráveis. No entanto, vemos uma diferença grande na taxa de emissão de notas técnicas favoráveis à concessão de medicamentos dos NatJus mesmo quando consideramos apenas medicamentos não incorporados ao SUS ou medicamentos que receberam recomendação da CONITEC desfavorável à incorporação (Figuras 5 e 6).

Figura 5. Taxa de emissão de notas técnicas favoráveis à concessão do medicamento em casos de medicamentos não incorporados ao SUS, por NatJus



Fonte: elaboração própria.

Figura 6. Taxa de emissão de notas técnicas favoráveis à concessão do medicamento em casos com recomendação desfavorável da CONITEC à incorporação do medicamento ao SUS, por NatJus



Fonte: elaboração própria.

3.4 Divergências entre os NatJus na prática

O diagnóstico apresentado no tópico anterior é reforçado ao analisarmos as divergências entre os NatJus a nível dos medicamentos e das doenças que estes buscam tratar. Verifiquei, para cada combinação de CID e medicamento que recebeu ao menos dez pareceres de pelo menos dois NatJus, qual foi a diferença entre a taxa mais favorável e a taxa menos favorável à concessão daquele medicamento para tratar aquela doença. Das 247 combinações que cumpriram esses critérios, em 28 a diferença foi de 100% – isto é, pelo menos um NatJus foi favorável a todos os pedidos que recebeu e outro foi contrário a todos. Em 67 casos, a diferença foi igual ou superior a 80%; em 119 casos, foi de pelo menos 50%; e em 168 casos foi de pelo menos 20%.

Quadro 1. Medicamentos com 100% de diferença entre taxas de nota favorável envolvendo pelo menos três NatJus

Princípio ativo	CID	Sempre concede(m)	Nunca concede(m)
Pembrolizumabe	Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34)	NatJus BA	TelessaúdeRS-UFRGS e NatJus MT
Pembrolizumabe	Melanoma maligno da pele (C43)	NatJus PR e NatJus MS	NatJus MT
Nivolumabe		NatJus BA e NatJus SE	TelessaúdeRS-UFRGS e NatJus MT
Abemaciclibe	Neoplasia maligna da mama (C50)	NatJus BA, NatJus MS e NatJus DFT	NatJus MT
Succinato de Ribociclibe		NatJus DFT, NatJus SE e NatJus PE	NatJus MT
Cloridrato de metformina + Dapagliflozina	Diabetes mellitus não-insulino-dependente (Tipo 2) (E11)	NatJus BA	NatJus RN, NatJus SP, NatJus MS e NatJus ES
Empagliflozina		NatJus BA	NatJus RN, TelessaúdeRS-UFRGS, NatJus SP, NatJus MS e NatJus ES
Empagliflozina + Linagliptina		NatJus BA	NatJus PR, TelessaúdeRS-UFRGS, NatJus GO e NatJus ES
Elexacaftor + Ivacaftor + Tezacaftor	Fibrose cística (E84)	NatJus RJ	TelessaúdeRS-UFRGS e NatJus MT
Pirfenidona	Outras doenças pulmonares intersticiais (J84)	NatJus SE	TelessaúdeRS-UFRGS, NatJus SP, NatJus MS e NatJus MT
Ustequinumabe	Doença de Crohn (K50)	NatJus BA e NatJus PR	NatJus MT

Fonte: elaboração própria.

No Quadro 1, destaco os casos em que a diferença entre o NatJus mais favorável à concessão daquele medicamento e o menos favorável foi de 100% e mais de um NatJus sempre concedeu ou sempre negou aquele tratamento para determinada doença. Estes exemplos demonstram que há discordância absoluta entre NatJus até mesmo em casos em que mais de um NatJus compreende que aquele medicamento sempre ou nunca deve ser concedido para tratar aquela condição.

Com exceção de Cloridrato de Metformina + Dapagliflozina e Glyxambi (Empagliflozina + Linagliptina), todos os princípios ativos indicados no Quadro 1 estiveram associados a discussões sobre custo-efetividade. Pembrolizumabe, Nivolumabe, Empagliflozina e Pirfenidona já foram avaliados pela CONITEC e receberam parecer recomendando a não incorporação devido a custo-efetividade desfavorável (CONITEC, 2018a,

2018b, 2021b, 2023). Abemaciclibe, Succinato de Ribociclibe e Ustequinumabe foram incorporados, mas receberam inicialmente recomendação de não incorporação por seu alto impacto financeiro no SUS (CONITEC, 2021a). Elexacaftor + Ivacaftor + Tezacaftor (Trikafta) foi incorporada, mas é considerado medicamento de alto custo, podendo demandar cerca de R$ 1,2 milhão por ano por paciente (Lisboa, 2024).

Esses dados sugerem que houve grande divergência entre NatJus em relação a como valorar informações relacionadas a custo-efetividade. Essa hipótese é ainda corroborada pelo fato de que, como o Quadro 1 indica, as discordâncias extremas entre os NatJus, de mais de 80%, estão concentradas principalmente entre alguns NatJus específicos.[19] Dos 67 casos de discordância extrema, o NatJus BA e o NatJus SE estiveram envolvidos como aqueles que sempre emitem nota técnica favorável sobre certo tratamento em 39 e 10 casos, respectivamente. Do outro lado, os NatJus MT, TelessaúdeRS-UFRGS, NatJus ES e NatJus MS foram aqueles que nunca emitem nota técnica favorável em 27, 23, 13 e 10 casos, respectivamente. Isso sugere que NatJus BA e NatJus SE dão pouco peso a custo-efetividade, enquanto os NatJus MT, TelessaúdeRS-UFRGS, NatJus ES e NatJus MS dão bastante peso.

Essas divergências entre os NatJus sugerem a existência de dois sistemas de NatJus concorrentes: um que, assim como a CONITEC, leva a sério considerações de custo-efetividade, e outro que, ao desconsiderar esse fator, irá recorrentemente emitir recomendações que contrastam com o que a CONITEC decidiu e podem vir a se sobrepor ao órgão de ATS do SUS. Até o momento, o CNJ não se manifestou de maneira clara sobre a necessidade de um sistema prevalecer sobre o outro, deixando os tribunais livres para decidir como atuar também neste âmbito, o que pode permitir que as consequências negativas da judicialização da saúde para o SUS passem a ser mais localizadas territorialmente, visto que alguns estados trabalharão para superá-las e outros não, ao menos no que diz respeito a más alocações de recursos públicos associadas à falta de avaliações de custo-efetividade.

[19] Menciono neste parágrafo aqueles que apareceram ao menos 10 vezes em um dos dois lados.

Tabela 3. Maiores aumentos na taxa de nota técnica favorável optando pelo NatJus local

NatJus	Princípio ativo	CID	Aumento
DMJ/TJRS	Cloridrato de Sertralina	F33	100
NatJus BA	Pregabalina	G82	
	Insulina Asparte	E11	
	Insulina Degludeca + Liraglutida		
	Benzoato de Alogliptina		
	Imipramina	G82	
	Besilato de Levanlodipino	I10	
NatJus MA	Sinvastatina		
	Espironolactona	I25	
NatJus RJ	Brometo de Tiotrópio + Brometo de Tiotrópio monoidratado	J44	93,8
NatJus GO	dimesilatodelisdexanfetamina	F90	90,1
NatJus MS	Brometo de Umeclidinio + Trifenatato de Vilanterol	J44	89,5
NatJus SE	Pirfenidona	J84	88,8
NatJus SP	Cloridrato de Escetamina	F33	82,2
NatJus PE	Tetraidrocanabinol + canabidiol	G40	70,5
NatJus PR	Romosozumabe	M81	63,9
NatJus DFT	Pirfenidona	J84	61,7
NatJus RN	Hidroclorotiazida + Olmesartana Medoxomila	I10	54,5
TelessaúdeRS-UFRGS	Succinato de Ribociclibe	C50	36,3
NatJus MT	Enoxaparina	D68	35,2
NatJus AM	Esilato de Nintedanibe	J84	26,5
NatJus AL	Sacubitril Valsartana Sódica hidratada	I50	24,3
NatJus ES	Olanzapina	F20	24,2
NatJus PB	Aflibercepte	H36	20,6

Fonte: elaboração própria.

Tabela 4. Maiores aumentos na taxa de nota técnica favorável optando pelo NatJus Nacional

NatJus	Princípio ativo	CID	Aumento
NatJus ES	Risperidona	F91	94,1
NatJus RN	Fenobarbital	G40	93,9
NatJus SP	Cloridrato De Memantina	G30	85,1
TelessaúdeRS-UFRGS	Fosfato De Ruxolitinibe	C94	83,1
NatJus MT	Risperidona	F84	81,2
NatJus MS	Omalizumabe	L50	74,7
DMJ/TJRS	Cloridrato De Memantina	G30	71,8
NatJus MA	Baclofeno	G82	61,9
NatJus RJ	Risperidona	F84	51,3
NatJus PE	Sulfato De Hidroxicloroquina	M32	50
NatJus TO	Levotiroxina Sódica	E03	46,2
NatJus DFT	Dupilumabe	L20	44,7
NatJus PR	Upadacitinibe Hemi-Hidratado	L20	44
NatJus BA	Ácido Acetilsalicilico	I50	39
NatJus AM	Dupilumabe	L20	24,6
NatJus GO	Ocrelizumabe	G35	14,2
NatJus PA	Esilato de Nintedanibe	J84	7,9
NatJus SE	Bevacizumabe	H36	7,5
NatJus AC	Cloridrato De Duloxetina	M79	1

Fonte: elaboração própria.

Não sendo este problema suficiente, o sistema dos NatJus apresenta ainda um complicador e agravante: o NatJus Nacional. Magistrados podem optar por pedir nota técnica para o NatJus Nacional ou para seu NatJus local. Diante de diferenças tão significativas entre os diferentes NatJus, essa escolha pode ser bastante estratégica. Conhecendo bem os dois órgãos à sua disposição, o magistrado poderia em muitos casos, na prática, escolher que resposta técnica ele deseja receber. Nesse sentido, o que deveria ser um apoio que qualifica a sua decisão acaba se tornando apenas um argumento de autoridade para defender o que o magistrado já pretendia decidir.

Na comparação apresentada no Quadro 1, não incluí o NatJus Nacional. Comparando as taxas de nota técnica favorável emitida pelo NatJus Nacional referente a medicamentos com pelo menos dez pedidos às taxas de nota técnica favorável de cada um dos NatJus que também analisaram pelo menos dez vezes o medicamento em questão, podemos fazer 1.252 comparações. Em nove delas, a diferença entre o NatJus Nacional e o NatJus local foi de 100%; em 44, foi de 80% ou mais; em 220, de 50% ou mais; e, em 562, de 20% ou mais. Esses números revelam que em quantidade relevante de casos é possível aumentar as chances de emissão de uma nota técnica favorável em pelo menos 20% pelo mero ato de escolher entre o NatJus local e o NatJus Nacional. Em 442 casos, o magistrado aumentaria as chances de receber nota técnica favorável ao optar pelo NatJus Nacional. Nos outros 120 casos, o aumento viria permanecendo com o NatJus local. Nas tabelas 3 e 4, apresento, respectivamente, os casos de cada NatJus em que a probabilidade de nota técnica favorável mais aumentariam ao se optar pelo NatJus local e pelo NatJus Nacional.

3.5 Consequências da fragmentação dos NatJus

Está capítulo discute as consequências do que foi apresentado nos capítulos anteriores: frente a um CNJ que não avaliou os NatJus enquanto política pública à medida que apostava mais fichas nesta política e deu aos tribunais plena liberdade para criá-los sem seguir um modelo ou procedimentos decisórios pré-estabelecidos, foi gerado um sistema paralelo, que com frequência concorre com a CONITEC, e que, internamente, apresenta graves incongruências. No âmbito judicial, se um tribunal julga de maneira muito divergente dos demais, o autor da ação pode recorrer às instâncias superiores e buscar precedentes que impeçam ou ao menos minimizem as divergências interpretativas, mas isso não é possível no sistema de ATS criado pelo Judiciário. São grandes as diferenças na maneira como cada NatJus avalia cada tecnologia

e atualmente não há qualquer meio de sanar estas divergências e fixar diretivas a serem seguidas pelos NatJus.

Ao menos no que diz respeito à opinião da assistência técnica que será fornecida aos magistrados, habitantes de diferentes estados terão direitos à saúde muito diferentes. Obviamente o direito sempre é influenciado por quem é responsável por determiná-lo, mas a função pretendida dos NatJus era a de qualificar a judicialização, não aumentar os agentes envolvidos com poder discricionário para emitir opiniões pautadas ou não em evidências científicas e nas normas do SUS. O que se obteve, ao final, foi um sistema em que, a depender de onde o paciente mora, suas chances de obter judicialmente um medicamento, se os magistrados seguirem os NatJus, varia consideravelmente.

Diante disso, o NatJus Nacional é um problema, mas também pode ser solução. Este órgão é problema, pois dificulta decisões judiciais mais equitativas na medida em que permite que haja notas técnicas diametralmente diferentes no que dizem respeito às conclusões sobre tratamento até mesmo em um único tribunal, além de permitir aos magistrados uma espécie de *fórum shopping* de assistência médica-científica. Ao mesmo tempo, o NatJus Nacional surge como possível solução, pois a maneira mais fácil de tornar o sistema menos incoerente seria atribuir um maior papel a ele.

O NatJus Nacional emitiu, em 2024, quase quatro vezes mais notas técnicas que os NatJus estaduais combinados, segundo os dados do e-NatJus. Não parece ser impossível que ele passe a ser o único emissor de notas técnicas do país. Com isso, a tendência seria a diminuição de notas técnicas divergentes para um mesmo tratamento e, havendo um único órgão emissor de notas técnicas, tornar-se-ia muito mais fácil garantir maior convergência entre os técnicos encarregados de emitir pareceres. Além disso, em média, essa troca poderia aumentar a qualidade dos profissionais que emitem os pareceres, visto que o NatJus Nacional é administrado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, centro de referência cujo conhecimento técnico médio tenderia a ser superior ao dos componentes de NatJus que recebem menos apoio dos seus tribunais e são compostos majoritariamente por servidores do próprio tribunal.

Contra essa possibilidade pesam dois pontos principais. O primeiro é o de que a maior resistência aos NatJus veio na forma de protestos embasados na autonomia dos tribunais e na independência dos magistrados. A proposta de acabar com os NatJus locais aumentaria essas críticas. Além disso, a maioria dos NatJus emitem notas técnicas favoráveis em proporção superior a do NatJus Nacional. Como a maioria dos magistrados brasileiros concedem a maioria dos pedidos judiciais de medicamentos, essa mudança levaria os magistrados a ter de lidar com

uma maior quantidade de notas técnicas contrárias às suas predisposições ao julgar, aumentando resistências em relação ao uso adequado das notas técnicas em suas decisões. Sendo adotada essa solução ou qualquer outra, não parece razoável manter os NatJus da forma como eles atualmente estão funcionando, devido às grandes diferenças na forma como cada NatJus decide e os impactos decorrentes disso na equidade entre cidadãos de diferentes estados que acessam o Judiciário e no próprio sistema público de saúde, que tem de lidar com tribunais com a possibilidade de escolher criar burocracia que irá ou não respeitar a legislação do SUS.

4 USO DE PARECERES DO NATJUS SP PELO TJSP

No capítulo anterior, discuti como tem sido a atuação dos NatJus no que diz respeito à emissão de notas técnicas. Neste capítulo, trato da etapa seguinte: o que os magistrados fazem ao receber o parecer emitido pelo NatJus? Para responder a essa pergunta, realizo estudo de caso focado na relação entre o NatJus SP e o TJSP.

A escolha de realizar essa análise no TJSP se deu pela maior disponibilidade de dados deste tribunal. Primeiro, porque o TJSP é o estado que fornece informações mais completas via raspagem de dados[20] (Azevedo et al., 2019; Morgulis, 2021). Além disso, o NatJus SP é o único NatJus que, além de preencher o formulário padronizado do e-NatJus, anexa a esta plataforma parecer emitido com base em formulário próprio, que contém a identificação do processo judicial ao qual o parecer está vinculado – informação esta que não faz parte do formulário padrão do e-NatJus. Com isso, não apenas é possível coletar uma série de informações sobre os pareceres de maneira automatizada por meio da plataforma e-NatJus, como é possível também avaliar as decisões proferidas nos processos sobre os quais os pareceres foram requisitados com mais facilidade e precisão.

Também é relevante a escolha de iniciar a coleta de dados a partir dos pareceres dos NatJus, e não diretamente das decisões do TJSP. Essa opção se justifica pela existência de trabalhos anteriores, apontando que nem todas as decisões judiciais proferidas em processos em que foi solicitado parecer do NatJus citaram os respectivos pareceres. Se a pesquisa buscasse diretamente por decisões judiciais que citam os pareceres dos NatJus, a análise da taxa de citação perderia essa nuance.

Antes de apresentar a metodologia completa para a realização dessa análise e os resultados encontrados, no entanto, início discutindo como a literatura tem avaliado o impacto dos pareceres dos NatJus nas decisões dos magistrados que os solicitaram.

[20] Raspagem de dados consiste na coleta automatizada de dados disponíveis na internet. Em geral, isso é feito por meio da criação de programas automatizados que fazem requisições aos sites e se aproveitam da maneira como essas páginas são estruturadas via HTML para coletar as informações desejadas. (Mitchell, 2018).

4.1 Avaliações anteriores do impacto de pareceres dos NatJus

Em março de 2011, o desembargador Manoel Alberto Rebelo dos Santos, então presidente do TJRJ, declarou que o NAT era um sucesso (Cavalcanti, 2011). A métrica que ele destacou para corroborar essa afirmação é especialmente interessante: o NAT produziu 987 pareceres em 2009, 1448 em 2010 e mais de 400 apenas nos 3 primeiros meses de 2011, frequência essa que, se se sustentasse, levaria a num novo recorde anual.

No período anterior à determinação da criação dos NatJus, a maioria dos trabalhos que produziram dados empíricos sobre a atuação de algum NAT, assim como o presidente do TJRJ, focaram em dados sobre a quantidade de pareceres produzidos (Castro, 2012; Ferreira; Costa, 2013; Guimarães; Palheiro, 2015), indicando um crescimento no número de pareceres solicitados a cada ano. Fugiu disso apenas Silva (2012), a produção mais completa sobre um NAT nesse período.

Silva (2012) analisou uma amostra de processos julgados entre setembro de 2009 e outubro de 2010 nas varas de fazenda pública da capital, todas já com acesso aos pareceres do NAT. Ao total, foram analisados 187 processos. O trabalho constatou que entre os 109 casos com sentença de mérito, houve parecer do NAT em 83 de 109 casos (76,1%). No entanto, destas 83 decisões, apenas 15 (18%) mencionaram o parecer do NAT na decisão e, mesmo entre as sentenças que mencionaram o NAT, nenhum fez referência ao conteúdo em si do parecer do NAT. Assim, não havia evidências empíricas de que os pareceres o NAT efetivamente mudaram a maneira como os magistrados decidiam os casos. Nesse sentido, Silva (2012, p. 185) observou que:

> apesar do potencial favorável [da] intervenção do NAT, no sentido de fornecer os subsídios médicos e sanitários, sua não incorporação na argumentação e decisão impediram e/ou reduziram as possibilidades de melhoria da prestação jurisdicional, no que se refere às preocupações sanitárias iniciais, pretendidas pela gestão judiciária e de saúde ao criarem o Núcleo.

O quadro identificado por Silva (2012) põe em xeque a capacidade de órgãos como o NAT exercerem impacto positivo na judicialização da saúde, para além de ganhos de eficiência derivados de decisões finais mais rápidas. A produção de pareceres em si ser uma métrica de sucesso faz bastante sentido se adotarmos como premissa que cada parecer emitido equivale a tempo e recursos financeiros economizados e uma decisão judicial mais qualificada. No entanto, essa correlação não necessariamente existe e, principalmente no que diz respeito à qualificação da decisão, existem evidências que contestam a alegação de que ela de fato tenha

ocorrido. Ainda assim, Silva (2012, p. 185) adotou postura positiva quanto aos benefícios do NAT:

> A não identificação de uma mudança efetiva das decisões judiciais que contaram com assessoria técnica em seu processo decisório não significa que a intervenção do NAT não tenha acarretado efeitos benéficos. Tais consequências não são ainda mensuráveis no desfecho do processo – a decisão judicial –, mas seus efeitos não inegáveis. Nesse sentido, os participantes do processo passaram a conhecer novas premissas, ofertando possibilidades de ampliação da compreensão desses participantes, de formação essencialmente jurídica, das dimensões complexas médicas e sanitárias que envolvem os pedidos judiciais. Os efeitos desta exposição podem ser benéficos, mas demandam esforços dos participantes na reformulação de suas argumentações no processo judicial, e dos gestores judiciários e da saúde, na manutenção do estímulo das discussões e da introdução de novas possibilidades discursivas entre ciência, técnica, direito e saúde, no processo judicial.

Neste capítulo, foco em discutir as métricas utilizadas para avaliar os benefícios mensuráveis dos NatJus. Frente aos dados apresentados na introdução que justificam ceticismo quanto ao impacto de órgãos técnicos na judicialização da saúde e às críticas apresentadas por Vasconcelos (2020) e Wang (2018; 2021) à existência dos NatJus, entendo que benefícios não mensuráveis não são suficientes para justificar a existência de estrutura paralela de Avaliação de Tecnologia de Saúde, especialmente diante dos problemas apresentados no capítulo anterior.

* * *

Não há indícios de que Silva (2012) nem qualquer outra pesquisa acadêmica tenha sido utilizada como base para avaliar um dos NATs e justificar a criação dos NatJus. A fonte que mais provavelmente embasou as decisões do CNJ quando determinou a criação dos NatJus foi Asensi e Pinheiro (2015), relatório encomendado pelo próprio CNJ. Entretanto, mesmo essa produção não encontrou resultados que promovessem otimismo em relação aos NATs, já que concluiu que "a maioria das decisões não fez menção ao NAT como uma estratégia para a atividade judicante em saúde, apesar de se observar nos dados uma tendência a sua utilização, especialmente nas capitais" (Asensi; Pinheiro, 2015, p. 43).

Entre a criação dos NatJus e as recentes atuações do CNJ em relação a estes órgãos, diversos artigos se voltaram a analisar estes órgãos. Seguiram sendo levantadas informações sobre a quantidade de pareceres produzidos (Nogueira; Carvalho; Dadalto, 2017; Sousa; Santos, 2017, p. 669; Henrique; Mendonça; Braga, 2018, p. 17; Ornelas, 2018, p. 34; Celestino, 2019, p. 139; Chagas, 2019, p. 80; Mota, 2021; Rocha; Queiroz; Rodrigues, 2021, p. 133; Calixto, Almeida, França, 2023; Pires, 2023, p. 99), ao que se somou ainda dados sobre a quantidade de

juízes, varas ou comarcar que solicitaram pareceres (Arruda, 2017; Henrique; Mendonça; Braga, 2018, p. 17; Andrade, 2020, p. 17; Regolin et al., 2022, p. 5).

Com exceção de Calixto, Almeida e França (2023), que analisaram uma amostra de apenas 94 processos ajuizados entre 2019 e 2021, os artigos indicam a permanência de uma tendência de aumento no número de pareceres solicitados e de solicitantes e, consequentemente, o desenvolvimento gradual de um hábito por parte dos magistrados de requerer pareceres ao NatJus. Entretanto, como Silva (2012) demonstrou, informações sobre a quantidade de solicitações ao NatJus – seja em número absoluto de pareceres produzidos, seja em número de solicitantes – dizem pouco sobre o uso efetivo desses documentos, isto é, se são citados e se seu conteúdo é efetivamente trabalhado na fundamentação da decisão.

No que diz respeito ao conteúdo das decisões judiciais, que podem melhor representar o real impacto dos pareceres dos NatJus, outras métricas foram recorrentemente coletadas, como taxa de concordância entre o parecer do NatJus e a decisão judicial e a taxa de citação dos NatJus nas decisões judiciais, utilizada previamente por Silva (2012) e Asensi e Pinheiro (2015).

4.1.1 Taxa de concordância entre pareceres dos NatJus e decisões judiciais

Sousa e Santos (2017, p. 669) observaram taxa de concordância total entre o TJTO e o NAT TO em 2014 de 52,98% e concordância parcial de 17,88% (para um total de concordância total ou parcial de 70,86%). Vasconcelos (2018, p. 180) entrevistou coordenador do NatJus RJ e obteve a informações de que, em 2016, entre as decisões em processos que solicitaram parecer, 73% delas estavam em conformidade total com o parecer e 10% conformidade parcial. Rocha, Queiroz e Rodrigues (2021, p. 134), analisando o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), encontraram taxa de concordância com o NatJus GO de 100% em 2018, 91,63% em 2019 e 86,96% em 2020.[21] Por fim, Soares (2021) observou em Santa Catarina, em decisões proferidas em 2019 que citam o NatJus, taxa de concordância total de 93,3% e taxa de concordância parcial de 5,6%. Nesse sentido, foi observada uma taxa mínima de concordância total ou parcial com os pareceres dos NatJus de cerca de 70%, um valor bastante alto.

[21] Esta mudança gradual na taxa de concordância pode estar associada a um aumento de solicitações de parecer feitos por magistrados mais dispostos a discordar do NatJus que os primeiros a adotarem a prática de pedir parecer.

No entanto, há duas limitações nessa métrica, que fazem com que ela, assim como a quantidade de solicitações a pareceres, represente muito pouco sobre o impacto dos NatJus. Em primeiro lugar, os pesquisadores que apresentam taxas de concordância parcial não definem o que seria isso. Caso a recomendação final do parecer seja diferente do dispositivo da decisão, o que é necessário para que seja declarada concordância parcial entre o parecer e a decisão? A resposta a essa pergunta não fica clara.

Em segundo lugar, há um problema maior: a taxa de concordância pode ser alta até mesmo em um cenário em que magistrados ignorem completamente o conteúdo dos pareceres. Para isso, basta que os magistrados que pedem recorrentemente pareceres do NatJus estejam com frequência recebendo exatamente parecer no sentido que gostariam, e magistrados que costumam ter opiniões distintas das do NatJus, ao perceber essa diferença, deixem de pedir pareceres dos NatJus. Ou seja, uma alta taxa de concordância não implica qualquer relação de causalidade e pode tão somente representar uma correlação na forma como o NatJus local e os magistrados do tribunal local decidem.

Há ainda um agravante nessa possibilidade: a chance de o NatJus e o Tribunal de Justiça local concordarem pelo mero acaso é bastante alta. Wang et al. (2020) estima com base em 13.263 decisões judiciais provenientes de São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis que a taxa de decisões favoráveis em casos de judicialização da saúde é de 92%. Adotando esse valor como base, para que haja, em média, uma taxa de concordância, ao acaso, de mais de 70%, basta que o NatJus conceda pareceres favoráveis à concessão de tratamento em 73,8% dos casos – isto é, probabilisticamente falando, se dois órgãos costumam ser favoráveis a algo em grandes proporções, também será grande a proporção de concordância entre eles. Na comparação entre os NatJus e os tribunais, mantidas as taxas apresentadas de emissão de parecer favorável, os órgãos irão concordar em cerca de 70% dos casos, mesmo que nunca tenham lido o que o outro escreveu. Assim, a taxa de concordância, assim como números relacionados à quantidade de solicitações, dizem muito pouco para aferirmos o sucesso ou não dos NatJus.

4.1.2 Taxa de citação de pareceres dos NatJus em decisões judiciais

Uma métrica que começa a traçar melhor o panorama de atuação dos NatJus é o da citação aos pareceres nas decisões judiciais. Ainda é possível, como Silva (2012) observou, que o parecer seja citado sem que haja qualquer discussão efetiva de seu conteúdo na decisão. Pior,

é possível que o magistrado cite a existência de parecer sem sequer ler o seu conteúdo. No entanto, a mera citação já demonstra um nível de intencionalidade adicional dos magistrados perante o NatJus: além de solicitar, o magistrado menciona o parecer. Apesar de pouco, os dados mostram que nem sempre esse mínimo é feito.

As pesquisas que analisaram a taxa de citação aos NatJus encontraram resultados bastante divergentes, influenciados pelas diferentes estratégias utilizadas para constituir suas amostras. Celestino (2019) encontrou taxas de citações baixíssimas. A autora não informou qual foi o número absoluto, mas indicou que "raríssimas decisões no universo estudado [...] ou mencionam parecer proveniente do NATJUS-CE" (Celestino, 2019, p. 119). Esse resultado pode ser parcialmente explicado pelo fato de que essa pesquisa analisou amostra de 235 acórdãos, isto é, decisões de 2ª instância, o que tende a sub-representar a frequência de citações a pareceres dos NatJus.[22]

Por outro lado, como seria de se esperar, pesquisas que analisaram taxas de citação envolvendo decisões de 1ª instância e analisando somente casos em que foi requerido parecer do NatJus local encontraram taxas maiores. Arruda (2017), com base em dados fornecidos pelo NAT MT, registrou que, entre 86 pareceres que passaram pelo órgão em 2011, em 84% dos casos o parecer foi citado pelo magistrado. Em 2012, entre 1.462 casos que passaram pelo NAT MT, em 94% houve citação ao parecer na decisão. Soares (2021) analisou amostra de 100 decisões que receberam parecer do NatJus SC e verificou que o NatJus foi citado em 89 decisões. Já Regolin et al. (2022) coletaram processos judiciais envolvendo artroplastia de quadril no TJRJ e no TRF2 e encontraram taxas de citações distintas em cada um desses tribunais: no TJRJ, a taxa de "alusão ao parecer do NatJus em pelo menos uma decisão" foi de 40% (em um conjunto de 15 casos) e, no TRF2, foi de 73% (em um conjunto de 37 casos). Pereira (2023) analisou casos em que magistrados citaram os pareceres do NatJus do Rio Grande do Norte entre 2017 e 2019. A taxa de citação encontrada pela autora esteve em patamar semelhante ao relatado em outros trabalhos: 88,2% (187 de 212). Este número permaneceu alta mesmo quando controlamos para o resultado do parecer – a taxa de citação foi de 87% em casos em que o parecer foi favorável (120 de 138) e 88,9% em casos de parecer desfavorável (56 de 63).[23]

[22] Dados do Tocantins (NAT-TO, s/ data; 2016; 2017; 2018) apontam que a participação dos magistrados de 2ª instância nas consultas aos NatJus entre 2014 e 2017 variou entre 3,5% e 19% do total. Nesse sentido, a adoção dos números de citações aos NatJus em 2ª instância como parâmetro tende a subestimar o real efeito que os pareceres estão tendo em 1ª instância.

[23] Nesse caso, não foram incluídos os resultados parcialmente favoráveis ou inconclusivos.

Como até o julgamento do Tema 6 pelo STF os magistrados não eram obrigados a requerer pareceres dos NatJus, essas altas taxas de citação são esperadas diante do fato de que os magistrados que pedem pareceres mesmo não sendo obrigados a isso tendem a ser mais receptivos aos pareceres do que aqueles que, não sendo obrigados a tal, se recusam a solicitar parecer. Esse fato, inclusive, pode confundir alguns dados associados a citações.

Soares (2021), por exemplo, observou que, em casos em que não houve manifestação do NAT/SC, liminares foram concedidas em 91% dos casos, enquanto em casos em que houve a concessão caiu para 75%. Em sentido semelhante, Calixto, Almeida e França (2022) observaram taxa de deferimento total de tutelas de urgência em 58% das decisões com apoio técnico, contra 91% em casos sem apoio; deferimento parcial em 31% nos casos com apoio e 2% nos casos sem; e indeferimento em 11% dos casos com apoio e 7% nos casos sem. Não é possível atribuir à citação em si essas mudanças nas taxas de concessão, visto que o pedido de apoio técnico pode estar correlacionada com um perfil de magistrado que, mesmo sem apoio, já estaria pré-disposto a indeferir os pedidos por medicamento em um número maior de casos.

* * *

No que diz respeito à mensuração da taxa de citação, merece ainda destaque o relatório patrocinado pelo CNJ sobre a judicialização da saúde (Azevedo et al., 2019). Esse estudo muito provavelmente foi e continua sendo uma das principais fontes de informações utilizadas pelo CNJ ao tratar desse tema, visto que foi produzido com apoio do próprio órgão e é citado como referencial teórico em publicações mais recentes (CNJ, 2021). O trabalho, além de descrever a judicialização da saúde, buscou verificar o uso de pareceres do NatJus.

Azevedo et al. (2019) analisaram todas as decisões proferidas entre 2008 e 2017 em casos de judicialização da saúde julgados em 2ª instância e contabilizaram citações aos NatJus. Esse relatório teve o grande mérito de avaliar não apenas um NatJus, mas todos, visto que tomou como base decisões proferidas por todos os tribunais. Os pesquisadores observaram que apenas 0,31% das decisões analisadas mencionaram os NatJus – menos de metade do número de citações feitas à CONITEC no mesmo período, outro órgão técnico analisado pela publicação. Esse número representa apenas 511 decisões dentre 164.587 analisadas, sendo 153 delas provenientes do Rio de Janeiro e 151 do Mato Grosso do Sul. Ou seja, um número ínfimo de decisões mencionou os NatJus e essas poucas menções são concentradas em apenas dois

estados, que correspondem a cerca de 60% das citações. Analisando a frequência relativa de citações por estado, Rio de Janeiro tem citações ao NatJus em 2,78% de suas decisões e o Mato Grosso do Sul, 3,26%. Além desses dois estados, apenas dois tem taxa de mais de 1%, Espírito Santo, com 1,09% (obtido com apenas 11 decisões), e Mato Grosso, com 18,05% (obtido com 72 decisões).

Para além das limitações relacionadas à mera contagem de citações, que podem ou não estar associadas a um efetivo diálogo com a fonte citada, os dados fornecidos por Azevedo et al. (2019) contêm algumas limitações adicionais. Destaco de antemão que essas limitações decorrem principalmente do fato de que o objetivo central da pesquisa não era o de avaliar os efeitos dos NatJus, mas sim fazer um levantamento bastante amplo – muito provavelmente o mais amplo já feito – acerca da judicialização da saúde no Brasil. Como a base de dados não foi construída especificamente com tal objetivo em mente, ela teve uma série de limitações que muito provavelmente não teria se a pesquisa fosse desenhada especificamente com o objetivo de avaliar os NatJus.

A pequena taxa de citações encontrada pode ser explicada, em primeiro lugar, pelo fato de que, como apresentado nesse capítulo, nenhum estado tem NatJus desde 2008, o início do período analisado, e, mesmo ao final do período estudado, o ano de 2017, nem todos os estados já haviam criado seus NatJus. O período examinado pelo trabalho, portanto, tende a não ser representativo da taxa de citações em qualquer ano específico após a criação de um NatJus.

Em segundo lugar, o conjunto de decisões analisadas abarcou todas as decisões sobre judicialização da saúde, o que inclui decisões associadas a planos de saúde (cerca de 30% do total) e engloba também temas como erro médico. Em nenhum destes dois casos seria esperado que os NatJus fossem citados, já que seu escopo costuma ser limitado à saúde pública e sua atuação abarca apenas discussões sobre fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos, não incluindo tópicos como responsabilidade civil na área da saúde. Por conta disso, o universo selecionado tende a subestimar a utilização de pareceres dos NatJus em casos em que eles efetivamente devem ser utilizados.

Em terceiro lugar, os dados sobre a eficácia dos NatJus são também limitados pela opção de se analisar decisões de 2ª instância. Como já mencionado, os números de 2ª instância podem não ser representativos do real quadro de influência dos NatJus.

Por fim, complicando ainda mais a avaliação dos dados fornecidos por Azevedo et al. (2019), vemos que a metodologia de contagem de citações aos pareceres dos NatJus tende a

gerar resultados imprecisos. Azevedo et al. (2019, p. 135) buscou no conteúdo das decisões judiciais as expressões "Núcleo de Apoio Técnico", "NatJus" e "NAT". Não fica claro como exatamente essas expressões foram buscadas, já que os códigos utilizados para isso não foram compartilhados. No entanto, a busca computadorizada por expressões regulares em documentos tende a diferenciar letras maiúsculas e minúsculas, o que deixaria de fora menções a "NATJUS", por exemplo. Já a busca apenas por "NAT" abriria margem para falsos positivos como, por exemplo, a menção ao "Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial do Ministério Público – NAT". A depender de como essa expressão for implementada, ela pode inclusive retornar resultados positivos para menções a "NATUREZA JURÍDICA" ou "DESTINATÁRIO".[24]

A principal fonte de informações do CNJ sobre os NatJus, portanto, apresenta uma série de limitações metodológicas que dificultam a extração de quaisquer conclusões definitivas sobre os NatJus. Seus resultados em si, no entanto, se considerados sem essas limitações, apresentam um quadro bastante negativo do uso de pareceres dos NatJus durante o período analisado. As demais produções que coletaram esse dado, por outro lado, apontam que, ao menos considerando apenas os casos em que parecer foi solicitado, as taxas de citação a ele são relativamente altas, acima de 80% nas maiores amostras analisadas.

Mesmo este resultado supostamente positivo, no entanto, tem ao menos duas limitações. Em primeiro lugar, poder-se-ia esperar que absolutamente todos os magistrados citassem o parecer que solicitaram, seja para concordar com ele, seja para discordar dele. Se o magistrado acata o conteúdo do parecer, a citação reforça a sua fundamentação. Se o magistrado discorda, de mesmo modo, o registro de porque não acata o parecer fortalece a fundamentação da sua decisão. Se um dos objetivos dos NatJus é qualificar as decisões dos magistrados, não dialogar com o parecer parece necessariamente implicar em uma decisão menos bem qualificada quando comparada a uma decisão do mesmo magistrado que dialoga com o parecer. Um quadro em que magistrados requerem pareceres, mas não dialogam com eles, então, conflita com o propósito que motiva o Judiciário a criar e manter os NatJus, ou ao menos minimiza os efeitos desejados.

A não citação do parecer parece condizente apenas com o objetivo de acelerar a produção das decisões, para além de facilitar o trabalho dos magistrados em revisar a legislação e as evidências científicas. Se o magistrado puder ler e não citar o parecer, ele poderá produzir

[24] Nenhum desses exemplos é meramente hipotético. Eles foram obtidos em teste de palavras-chave por meio de expressões regulares a partir de base de decisões do TJSP de 1ª instância.

uma decisão com resultado semelhante ao que produziria citando-o, mas com uma fundamentação mais simplificada, consequentemente, mais fácil de ser escrita. Esse pequeno ganho de velocidade na produção da decisão talvez seja uma deturpação do ganho de velocidade originalmente concebido para os NatJus, derivado de se ter corpo técnico permanente para auxiliar tecnicamente os magistrados, reduzindo assim prazos com escolha e contratação de peritos. Nesse sentido, os dados sobre citação demonstram implicitamente o conflito existente entre conciliar velocidade e qualidade.

4.2 Coleta e análise sistemática do conteúdo de decisões judiciais do TJSP

Ao utilizar o buscador da plataforma e-NatJus, os seus resultados são limitados aos 1.500 pareceres mais recentes para cada filtro de buscas. Isto é, pesquisando por pareceres sobre medicamentos emitidos pelo NatJus SP, por mais que existam mais de 1.500 pareceres que preenchem esses critérios juntados à plataforma, a plataforma irá retornar apenas 30 páginas de 50 resultados cada, permitindo ao usuário acessar apenas os 1.500 pareceres mais recentes. Por isso, antes da construção da base de dados descrita e utilizada no capítulo anterior dessa dissertação, para obter acesso à lista completa de pareceres proferidos pelo NatJus SP disponibilizados no sistema e-NatJus foi necessária requisição ao CNJ, responsável pelo e-NatJus, via Lei de Acesso à Informação. O pedido foi realizado dia 21/07/2023. Após dois recursos, protocolados em 26/08/2023 e 27/09/2023, obtive resposta dia 04/10/2023. Todos os pareceres aqui analisados foram incluídos na plataforma antes do dia 03/10/2023, quando o órgão coletou tais informações.

Com base na lista de pareceres fornecida, realizei a raspagem dos dados de todos os 8.343 pareceres disponíveis na plataforma naquele dia.[25] A plataforma contém pareceres sobre medicamentos, procedimentos e produtos. Como no capítulo anterior, optei por seguir o processo de coleta apenas com os medicamentos, o principal tipo de tecnologia requisitado. Esse recorte levou a um total de 5.194 entradas na base de dados. Entre as informações raspadas, são relevantes para este artigo duas: a conclusão do parecer (se favorável ou não à concessão do produto) – que será comparado com as conclusões do magistrado de cada caso – e o *link* do documento anexo ao parecer.

[25] Com o link específico do parecer, é possível acessar pareceres que não estejam entre os 1500 mais recentes.

Na etapa seguinte, utilizei código que faz a leitura do PDF contido no *link* do documento anexo ao parecer – em geral, formulário padrão do NatJus SP – e raspei, utilizando expressões regulares, o número do processo associado àquele parecer. Foi possível coletar o número do processo de 4.513 dos 5.194 pareceres de medicamentos. Essa diferença é explicada pelo fato de que nem todos os pareceres anexados contém número do processo judicial, em que pese a maioria (87%) tenha.

Feito isso, selecionei os processos que correm na justiça estadual com base no número do processo – casos que correm na justiça estadual contém o identificador ".8.26." e, na justiça federal, ".4.03.". Esse recorte foi realizado de modo a facilitar a coleta dos dados e por a Justiça Estadual ser a principal solicitante de pareceres do NatJus. Esse filtro retornou 4.025 casos, o que corresponde a 89% dos casos com identificação do processo disponível.

Como última etapa do processo de composição do universo da amostra, utilizei código para buscar de maneira automatizada o número do processo judicial no buscador de sentenças de 1º grau do TJSP e verificar quais casos já tinham sentença disponível na data da busca (15/02/24 – quatro meses e doze dias depois após a data de coleta dos pareceres). Sentença já havia sido proferida em 2.303 casos, conjunto que corresponde ao universo desta pesquisa.

Para proceder com a análise sistemática do conteúdo das decisões judiciais[26], sorteei amostra representativa do conjunto de casos que receberam pareceres do NatJus e que já tiveram alguma decisão judicial publicada. A amostra é de 330 casos (nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%). Foram analisadas as primeiras decisões judiciais após a emissão do parecer, sejam elas sentenças ou apelações. Nesse processo, coletei dados sobre o sistema de saúde sobre o qual a sentença diz respeito, se público ou suplementar; sobre de quem foi a iniciativa de requerer manifestação do NatJus, se do paciente, do poder público ou do plano de saúde, do juiz, ou de desembargador; em que momento processual foi solicitado parecer,se antes da decisão cautelar ou entre a decisão cautelar e a sentença, ou se antes da sentença em caso em que não houve decisão cautelar, ou em 2ª instância ou se após o julgamento de recursos; se foi dada oportunidade para as partes se manifestarem sobre o parecer do NatJus e, se sim, se as partes aproveitaram essa oportunidade; quais foram os fundamentos jurídicos mobilizados pela decisão, e se a decisão concedeu ou não o medicamento pleiteado.

Por fim, foram coletadas duas informações que buscam fazer com que essa pesquisa possa avançar sobre as avaliações anteriores do uso dos pareceres dos NatJus em decisões

[26] Sobre esse método de pesquisa, cf. Hall e Wright (2008).

judiciais: (1) se o parecer do NatJus é parte da fundamentação da decisão e, nos casos em que é, que informações fornecidas pelo parecer foram mobilizadas pela decisão; e (2) nos casos em que o juiz discorda do parecer, quais justificativas ele mobiliza para não acolher a conclusão do NatJus. Com isso, busquei entender com mais profundidade que papel os pareceres dos NatJus têm exercido sobre as decisões dos magistrados.

Para a análise dos dados quantitativos, foi utilizado código em *python*. Nesse processo, foi criada a variável "concordância", que é positiva caso o parecer recomende a concessão do medicamento e a decisão o conceda ou ambos opinem pela não concessão do medicamento. Nos demais casos, a variável é negativa. Nesse sentido, ao contrário de outros trabalhos discutidos anteriormente, não adoto a possibilidade de concordância parcial.

Para a realização de testes de associação entre variáveis, foi utilizado o teste qui-quadrado por meio da função *chi2_contigency* da biblioteca *scipy*. Foram considerados significativos testes em que $p < 0.05$. Os códigos e as bases de dados utilizadas para a elaboração deste capítulo estão disponíveis em: <https://osf.io/xuptj/>. As estatísticas completas referentes aos testes de associação realizados podem ser encontradas no arquivo "7. Testes-Correlacao.ipynb", na pasta referente ao capítulo 4.

4.3 Resultados

Entre as 330 decisões analisadas, 276 (83,6%) tratam de pedidos associados ao sistema de saúde pública e 54 (16,4%) ao sistema de saúde suplementar – isto é, pareceres do NatJus foram solicitados em casos de saúde pública cinco vezes mais que em casos de saúde suplementar. As decisões foram favoráveis à concessão do medicamento em 55,2% dos casos (n=182); contrárias, em 43,6% (n=143); e o processo foi extinto por razões processuais em 1,2% dos casos (n=4)[27], todos estes provenientes de pedidos relacionados à saúde suplementar. Para as análises realizadas no restante do artigo, os quatro casos extintos por motivos processuais serão desconsiderados. Essa taxa de decisões favoráveis à concessão de medicamentos é bastante inferior àquela observada no âmbito geral da judicialização da saúde, o que ressalta que a amostra aqui analisada, por ser parte de conjunto de decisões em que houve a solicitação de pareceres, não é representativa da judicialização da saúde como um todo. Em

[27] Em 3 casos, foi homologado acordo entre as partes e, em 1 caso, foi declarada falta de interesse de agir superveniente, devido ao falecimento do réu.

especial, esse dado reforça a suspeita de que o perfil de magistrados que solicitam estes pareceres é significativamente distinto do magistrado médio que não solicita pareceres para o NatJus SP.

A taxa de sucesso dos pacientes foi de 52,5% no âmbito da saúde pública (n=145) e 74% na saúde suplementar (n=37). Foi observada uma associação significativa entre o sistema de saúde demandado e o resultado da ação (p=0,007).[28] Ambas as taxas de sucesso são bastante inferiores àquelas encontradas em outros estudos sobre judicialização da saúde no TJSP.[29] Esse resultado sugere que o NatJus, quando provocado, pode estar exercendo algum impacto na judicialização da saúde, especialmente na pública, e levando a uma menor taxa de sucesso dos pacientes. Entretanto, como será discutido posteriormente, essa mudança pode também estar associada ao julgamento do Tema 106 do STJ, que estabeleceu critérios para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

Apesar dessas taxas de sucesso serem inferiores àquelas encontradas em outros estudos, elas ainda são superiores àquelas obtidas no âmbito do NatJus nesse mesmo conjunto de casos. A taxa geral de pareceres favoráveis no NatJus foi de 21,2% (n=69). Separando por setor, a taxa foi de 15,9% (n=44) no âmbito da saúde pública e 50% (n=25) no âmbito da saúde suplementar. Essa diferença entre setores é significativa (p<0,00001).[30]

Em que pese as taxas de sucesso dos pacientes no NatJus e no TJSP sejam tão díspares, foi observada associação entre o resultado do parecer do NatJus e da decisão judicial (p<0,00001). A taxa geral de concordância entre esses dois documentos foi de 64,1% (n=209). No âmbito da saúde pública, essa taxa foi de 62,7% (n=173), enquanto na saúde suplementar foi de 72% (n=36). Essa diferença entre os dois sistemas não é significativa (p=0.27).

Por outro lado, existe uma associação extremamente significativa entre a concordância do juiz com o parecer e a concessão ou não do medicamento (Tabela 5).[31] Em geral, magistrados

[28] Esse efeito é ainda maior se incluirmos os casos extintos por razões processuais na análise (p<0,000001).

[29] Cf., por exemplo, Wang et al. (2023) para dados sobre saúde suplementar e Wang et al. (2020) para dados sobre saúde pública.

[30] Convém destacar que, atualmente, o formulário padronizado do e-NatJus não contém campo para indicação sobre se o parecer foi emitido para caso envolvendo saúde pública ou saúde suplementar, nem campo informando sobre se o tratamento está inserido no rol da ANS ou não. Por isso, para a coleta de dados por setor de saúde, atualmente é necessário coletar essa informação por meio das decisões judiciais as quais os pareceres estão associados.

[31] Considera-se significante a associação de p < 0,05. Neste caso específico, o p demandaria 29 zeros antes de seu primeiro dígito relevante.

apenas discordam dos pareceres para conceder medicamentos. Os motivos que justificam essas discordâncias serão discutidos em subtópico próprio.

Tabela 5. Relação entre concordância com o parecer e concessão de medicamento

	Concede o medicamento	**Não concede o medicamento**	**Total**
Concorda com o parecer	67	142	209
Não concorda com o parecer	115	2	117
Total	182	144	326

Fonte: elaboração própria.

A última variável de grande destaque é o percentual de decisões que citam o NatJus (Tabela 6).[32] Em 79,8% dos casos (n=260), a decisão menciona o parecer e cita ao menos uma informação proveniente desse documento, como, por exemplo, o seu resultado ou algum dado sobre a eficácia do medicamento. Em 15,3% dos casos (n=50), não houve qualquer menção à existência de manifestação do NatJus na decisão. Isto é, não fossem os casos provenientes de amostra de pareceres disponibilizados via e-NatJus, sequer seria possível identificar por meio da leitura dessas decisões que foi proferido parecer sobre o caso. Essa quantia relevante de casos em que o parecer sequer foi citado reforça a relevância de pesquisas que partam não das decisões judiciais, mas dos pareceres do NatJus. Por fim, em 4,9% dos casos (n=16), houve apenas menção à existência de manifestação do NatJus, sem qualquer informação mobilizada na decisão ser apresentada como proveniente do parecer.

Tabela 6. Análise de associação das variáveis sistema de saúde, concordância e resultado com a citação de parecer do NatJus

O conteúdo da manifestação do NatJus é parte da fundamentação da decisão?		**Sim, e a decisão cita alguma informação proveniente do parecer em sua fundamentação**	**Não, mas há menção à existência de manifestação do NatJus SP**	**Não, e não há menção ao NatJus na decisão**
Sistema de saúde (p = 0,82)	Saúde pública	221 (80,1%)	14 (5,1%)	41 (14,9%)
	Saúde suplementar	39 (78%)	2 (4%)	9 (18%)
Concordância com parecer (p = 0,0001)	Concorda	181 (86,6%)	5 (2,4%)	23 (11%)
	Discorda	79 (67,5%)	11 (9,4%)	27 (23,1%)
Resultado do pleito (p = 0,002)	Concede o medicamento	133 (73,1%)	13 (7,1%)	36 (19,8%)
	Não concede o medicamento	127 (88,2%)	3 (2,1%)	14 (9,7%)
Geral		260 (79,8%)	16 (4,9%)	50 (15,3%)

Fonte: elaboração própria.

Achado relevante para entender como magistrados se comportam nesses casos é a associação entre a concordância dos magistrados com o parecer do NatJus e a citação que fazem

[32] A análise das variáveis discutidas nesse subtópico será aprofundada nos subtópicos seguintes.

aos pareceres (p=0,0001).[33] Magistrados citam os pareceres com maior frequência quando concordam com esses documentos. Ademais, citam os pareceres com maior frequência também quando não concedem os medicamentos (p=0,002). Essas duas associações podem se confundir, visto que, como indicado anteriormente, há também uma associação entre a concordância dos magistrados com os pareceres e a concessão de medicamentos. No entanto, preliminarmente, esses dados sugerem que magistrados "escondem" os pareceres quando estes documentos não concordam com o resultado que os magistrados pretendem justificar e consideram importante citar informações técnicas ao não conceder os medicamentos – se auto-submetendo a um ônus maior de justificação nesses casos, o que é condizente com o que se esperaria em um contexto em que a esmagadora maioria dos casos sobre fornecimento de medicamentos são decididos em favor dos pacientes.

4.3.1 Solicitação dos pareceres e contraditório

Foram compilados dados sobre a maneira como os pareceres dos NatJus têm acessado os processos: quem os solicita, quando e o que é dito sobre eles. A coleta desses dados por meio da análise das decisões, no entanto, é bastante difícil. Como não há padronização sobre o que deve constar no relatório desses documentos, os dados de interesse dessa parte da pesquisa recorrentemente não são informados. Na maioria dos casos (52,1%, n=170), não foi possível coletar informações sobre nenhuma das três variáveis que aqui serão apresentadas.[34]

Esse quadro de dificuldades é reforçado pelo fato de que a maioria dos casos é proveniente de juizados especiais (59,8%, n=195), em que a seção de relatório da sentença é dispensada.[35] Apenas 33,6% (n=44) das decisões provenientes da Justiça Comum não apresentaram nenhuma das informações discutidas nesse tópico. Já nos Juizados Especiais, essa taxa é de 64,6% (n=126), uma diferença significante (p<0,00001).

---

[33] Se juntarmos as opções "não há qualquer menção ao parecer" e "há menção apenas à existência de parecer", a associação entre essas variáveis se mantém.

[34] A coleta dessas informações não se limitou ao relatório, mas teve nesta parte da sentença sua principal fonte de dados. Se, ao longo da sentença, o magistrado trouxe alguma das informações discutidas nesse tópico, elas também foram coletadas.

[35] O artigo 38 da Lei dos Juizados Especiais (Lei Nº 9.099/1995) estabelece que "[a] sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório."

Em que pese os dados aqui apresentados possam representar algum viés derivado do alto conjunto de casos em que a informação não foi identificada, elas apresentam um primeiro olhar sobre como os pareceres do NatJus tem sido mobilizados e podem contribuir com os esforços para aumentar a adesão às atividades do órgão.

O principal solicitante de pareceres do NatJus foram magistrados, com 43 solicitações (13,2%) (Tabela 7). Em seguida, vem os requeridos, com 19 solicitações (4,9%). Em nove casos, as solicitações vieram do Poder Público e, em sete casos, de operadoras de planos de saúde. Isso significa que as operadoras de saúde demandaram parecer em maior quantidade, dado que a quantidade de casos de saúde suplementar na amostra foi bem menor que a de casos envolvendo saúde pública.

Pacientes, por sua vez, requisitaram parecer do NatJus em apenas um caso (0,3%). Essa diferença é condizente com a diferenciação conceitual entre litigantes habituais e litigantes repetitivos (Galanter, 1974; Asperti et al., 2019), que indica que aqueles que litigam com maior frequência, como o Estado e as operadoras de saúde, teriam maior conhecimento técnico para, por exemplo, requerer pareceres técnicos em casos nos quais estes lhes poderiam ser favorável. Dado que a taxa de pareceres favoráveis do NatJus SP não superou um quarto nos casos da amostra, poder-se-ia esperar que esses litigantes habituais houvessem o acionado mais vezes.

Foram também observadas solicitações provenientes de desembargadores (1,5%, n=5) e do Ministério Público (MP)[36] (0,9%, n=3). Esses casos indicam a relevância da atuação das instâncias superiores e do MP para uma maior taxa de casos em que pareceres do NatJus são solicitados.

Tabela 7. Iniciativa de requerimento de parecer

De quem foi a iniciativa de requerer manifestação do NatJus?	**N.º (%)**
Do(a) paciente	1 (0,3%)
Do poder público e/ou do plano de saúde	16 (4,9%)
Do(a) juiz(a) (de ofício)	43 (13,2%)
Do(a) desembargador(a) (de ofício)	5 (1,5%)
Do Ministério Público	3 (0,9%)
Não é possível identificar	259 (79,4%)
Total	326 (100%)

Fonte: elaboração própria. Mais de um agente pode ter requerido manifestação do NatJus em um mesmo processo.

Convém destacar que a coleta desses dados encontrou como principal barreira a linguagem utilizada pelos magistrados. Em 97 casos, foi registrada menção à solicitação do

[36] Em nenhuma das decisões foi possível identificar o que motivou o MP a atuar naquele caso. Em nenhum desses casos o órgão atuou representando o autor.

parecer, mas a menção utilizou construções baseadas no uso da voz passiva ou de sujeito indeterminado, de modo que não fosse possível identificar com precisão quem efetivamente solicitou o parecer do NatJus.[37] Em todos os casos o requerimento dependeu de despacho do magistrado, mas essas construções dificultam a constatação de se o requerimento foi realizado de ofício ou mediante provocação de uma das partes.

No que diz respeito ao momento de emissão do parecer, a divisão principal ocorreu entre emissão antes da decisão cautelar (14,1%, n=46) e entre a decisão cautelar e a sentença (18,4%, n=60) (Tabela 8). Esses dados indicam que, na maioria das vezes, a decisão cautelar é proferida apenas com base na prescrição e no relatório médicos, sem contar com os aportes técnicos do NatJus.

Tabela 8. Momento de emissão do parecer

Em que momento foi emitido parecer do NatJus?	**Nº (%)**
Antes da decisão cautelar	46 (14,1%)
Antes da sentença, mas não houve decisão cautelar	7 (2,1%)
Entre a decisão cautelar e a sentença	60 (18,4%)
Em 2ª instância	4 (1,2%)
Após a prolação da sentença (após o retorno do processo à primeira instância após julgamento de recursos)	3 (0,9%)
Não é possível identificar	206 (63,2%)
Total	326 (100%)

Fonte: elaboração própria.

Como modo de estimar em que momento o parecer teria sido emitido nos casos em que o momento de emissão do parecer não foi identificado, utilizei a diferença entre as datas de emissão do parecer e da decisão judicial. Nos casos em que a emissão do parecer foi anterior à decisão cautelar, a diferença entre essas duas datas foi, em média, de 191 dias. Nos casos em que a emissão ocorreu entre a decisão cautelar e a decisão, a diferença média foi de 71 dias. Adotando como limiar entre essas duas possibilidades a média entre elas (131 dias), supus como tendo os pareceres sido proferidos antes da decisão cautelar os casos em que a diferença entre o parecer e a decisão foi superior a esse limiar e como tendo sido proferida entre a decisão cautelar e a sentença aqueles com diferença inferior a ele. Esse cálculo resultou numa estimativa de 129 casos emitidos após a decisão cautelar (62,6%) e 77 antes da decisão cautelar (37,4%). A distribuição entre essas duas possibilidades se manteve próxima daquela encontrada nos casos em que esse dado foi efetivamente coletado, em que os percentuais foram de 56,6% e

[37] Exemplos incluem: “foi solicitada nota técnica...”, “solicitou-se informações...”, “determinada a solicitação...”, “veio aos autos parecer...”, “ a nota técnica do NatJus foi juntada...”, “foi feita avaliação...”

43,3%, respectivamente, se considerados apenas os casos em que o parecer foi emitido em um desses dois momentos.

Por fim, foram coletadas informações sobre o aproveitamento pelas partes de oportunidades para se manifestar sobre os pareceres técnicos (Tabela 9). Na maioria dos casos em que esta informação foi identificada (54% desses casos), autor e réu aproveitaram a oportunidade de se manifestar sobre o relatório. Como será discutido posteriormente, essa faculdade mostrou-se bastante importante, visto que o segundo motivo mais frequente para o afastamento das conclusões do parecer técnico foi o argumento de que, no caso concreto, ele não seria aplicável e, recorrentemente, o parecer foi afastado por complementos das partes às informações previamente informadas, que permitiram contrariar as conclusões do parecer técnico.

Tabela 9. Oportunidade para contraditório

As partes tiveram a oportunidade de opinar sobre o parecer?	**Nº (%)**
Sim e ambas as partes se manifestaram	27 (8,3%)
Sim, mas apenas o(a) paciente(a) se manifestou	9 (2,8%)
Sim, mas apenas o requerido se manifestou	9 (2,8%)
Sim, mas ninguém se manifestou	3 (0,9%)
Sim, mas não foi informado se alguém se manifestou	2 (0,6%)
Não há menção expressa de que isso tenha ocorrido	276 (84,6%)
Total	326 (100%)

Fonte: elaboração própria.

4.3.2 Fundamentos normativos das decisões

Foram coletadas informações também sobre os fundamentos jurídicos mobilizados na decisão, para além das discussões sobre o parecer do NatJus (Tabela 18). No âmbito da saúde pública, o principal fundamento mobilizado foi o Tema 106 do STJ, julgado em 2018, que, como discutido anteriormente, motivou a mobilização de informações acerca das alternativas disponíveis no SUS aos medicamentos demandados. As menções ao tema superam, inclusive, as citações aos pareceres do NatJus, que ocorreram em 234 casos de saúde pública.

A alta taxa de mobilização dessa decisão indica que seu julgamento pode ter afetado significativamente a maneira como a judicialização de medicamentos é decidida, em contraposição às altas taxas de sucesso dos pacientes em período anterior a essa decisão (ver Wang et al., 2020). Nesse âmbito, a atuação do NatJus pode ser determinante para uma efetiva mudança na jurisprudência, visto que o órgão permite que o magistrado verifique o

cumprimento dos requisitos definidos pelo Tema 106 para o fornecimento de medicamentos com maior precisão e mais facilidade.

Tabela 10. Fundamentos jurídicos mobilizados pelas decisões, com pelo menos 10 citações

Fundamento mobilizado	Saúde Pública	Saúde Suplementar
Tema 106 do STJ	236 (72,4%)	1 (2%)
Constituição Federal	174 (53,4%)	6 (12%)
Jurisprudência do TJSP	131 (40,2%)	24 (48%)
Jurisprudência do STJ	89 (27,3%)	25 (50%)
Lei do SUS	92 (28,2%)	1 (2%)
Súmula do TJSP	61 (18,7%)	28 (56%)
Jurisprudência do STF	59 (18,1%)	1 (2%)
Tema 793 do STF	57 (17,5%)	0 (0%)
Constituição Estadual	47 (14,4%)	0 (0%)
Tema 1234 do STF	42 (12,9%)	0 (0%)
Legislação estadual	19 (5,8%)	0 (0%)
Lei dos Planos de Saúde	0 (0%)	19 (38%)
Código de Defesa do Consumidor	0 (0%)	17 (34%)
Resolução CNJ nº 238/2016	17 (5,2%)	0 (0%)
Código de Ética Profissional do Conselho Federal de Medicina	15 (4,6%)	0 (0%)
Enunciado da Jornada de Direito da Saúde (FONAJUS)	10 (3,1%)	1 (2%)
Súmula 608 do STJ	0 (0%)	10 (20%)
Lei do Rol Exemplificativo (Lei 14.454/22)	0 (0%)	10 (20%)
Total	276 (100%)	50 (100%)

Fonte: elaboração própria. Cada decisão pode citar mais de uma base normativa.

Nos casos de saúde pública, surpreenderam também as citações à Resolução CNJ n.º 238/2016 (que determinou a criação dos NatJus) e ao Código de Ética Profissional do Conselho Federal de Medicina, que aparecem em polos opostos do entendimento sobre como os pareceres do NatJus devem ser mobilizados. A resolução é citada para se destacar que o CNJ determinou a criação dos NatJus para que esses orientem tecnicamente os magistrados e, por isso, o conhecimento científico disponibilizado não deve ser desprezado. Com exceção de uma, todas as citações a essa resolução foram feitas pelo juiz Hermano Flávio Montanini de Castro, juiz que mais proferiu decisões entre os casos da amostra. Já as menções à antiga versão do Código de Ética Profissional dos Médicos (Resolução n.º 1.246, de 08/01/1988) foram feitas por seis magistrados diferentes, que mobilizaram o diploma para embasar o argumento de que a prescrição de medicamento é competência exclusiva do médico e que, por isso, ela não pode ser afastada por órgãos burocráticos. Em nenhum dos casos foi especificado a que dispositivo da resolução os magistrados faziam referência.

No âmbito da saúde suplementar, reforça-se a constatação de que julgados envolvendo o setor se baseiam principalmente em súmulas do TJSP e na jurisprudência do TJSP e do STJ

para decisão, em detrimento da Lei dos Planos de Saúde, que aparece em menor proporção, e das regulações do setor, que não apareceram em quantidade relevante de casos (Wang et al., 2023). Neste setor, nenhuma fundamentação jurídica superou os pareceres do NatJus em número de citação (41), o que difere de amostras de casos que não necessariamente houve parecer do NatJus, em que a atuação de peritos técnicos e do NatJus são bastante raras (Wang et al., 2023).

4.3.3 Mobilização de informações fornecidas pelos pareceres

Nas decisões em que o magistrado traz alguma informação atribuída ao parecer do NatJus, foi coletada a informação acerca de que tipo de dado foi mencionado (Tabela 11). Tanto em demandas do sistema público quanto do sistema suplementar, a principal informação citada foi o resultado do parecer (se favorável ou não favorável à concessão do medicamento). Essa informação foi a que mais apareceu também isoladamente, sendo contabilizados 37 casos em que a única informação mobilizada foi essa (somando ambos os sistemas de saúde), o que corresponde a 57% das citações entre casos que mobilizam apenas uma informação do parecer.[38] Nestes casos, o parecer é mencionado apenas como argumento de autoridade reforçando a conclusão do magistrado ou em breve menção ("em que pese o parecer tenha concluído...") sem peso argumentativo relevante.

[38] Para efeito de comparação, o segundo colocado, informações sobre a existência de alternativas terapêuticas no SUS, aparece apenas 12 vezes e as demais aparecem menos de 6 vezes cada.

Tabela 11. Frequência de citação às informações provenientes do parecer, por sistema de saúde

Que informação proveniente do parecer do NatJus é mobilizada na decisão?	**Saúde Pública**	**Saúde Suplementar**
O resultado do parecer	162 (73,3%)	28 (71,8%)
A existência de alternativas disponíveis no SUS	115 (52%)	6 (15,4%)
Avaliação do NatJus acerca da existência ou qualidade de evidências sobre o tratamento	82 (37,1%)	26 (66,7%)
Avaliação do NatJus sobre a indicação do medicamento à condição do autor	67 (30,3%)	17 (43,6%)
Fato de que o medicamento pleiteado é fornecido pelo SUS	33 (14,9%)	6 (15,4%)
Resumo da decisão da CONITEC sobre o medicamento	22 (10%)	5 (12,8%)
Informação sobre a situação regulatória do medicamento (no Brasil ou em outro país)	15 (2,3%)	10 (25,6%)
Avaliação do NatJus sobre a urgência do tratamento	10 (4,5%)	7 (17,9%)
Total	221 (100%)	39 (100%)

Fonte: elaboração própria. Cada decisão pode trazer mais de um dado atribuído ao parecer.

Em seguida, nos casos de saúde pública, a principal informação obtida dos pareceres foram informações sobre a existência (ou inexistência) de alternativas ao medicamento pleiteado disponíveis no SUS. Esse dado é relevante para a aplicação do Tema 106 do STJ, que estabelece, como um dos critérios para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, a

> comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.[39]

A informação acerca da existência de alternativas disponíveis no SUS é utilizada para definir o ônus da prova que o paciente tem de superar, isto é, para se definir quais fármacos fornecidos pelo SUS o paciente tem de comprovar que são ineficazes para fazer jus ao medicamento conforme o Tema 106. Nesse âmbito, inclusive, que o exercício do contraditório pelos pacientes se torna mais relevante, para que se permita que o laudo médico possa eventualmente ser complementado com informações acerca dos tratamentos alternativos indicados pelo NatJus.

[39] Os outros dois requisitos são a "incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito" e a "existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Em terceiro e quarto lugar na saúde pública e em segundo e terceiro lugar na saúde suplementar, vêm a mobilização de informações, respectivamente, sobre a existência de ou a qualidade das evidências científicas sobre a efetividade e a segurança do medicamento, e informações sobre a indicação do medicamento à condição do autor. O fornecimento dessas informações é o objetivo central dos NatJus (Resolução CNJ n.º 388/2021) e, por isso, chama atenção que, na saúde pública, essas informações ficam atrás de informações sobre alternativas disponíveis no SUS. Isso sugere que a principal função atualmente exercida pelo NatJus SP é diferente daquela inicialmente pensada para os NatJus, já que, no âmbito da saúde pública, a principal função dos pareceres é o fornecimento de informações sobre as políticas do SUS, não a avaliação de evidências científicas.

O quinto lugar é ocupado pelo argumento de que o medicamento pleiteado já é fornecido pelo SUS. No âmbito da saúde pública, esse argumento é mobilizado tanto para concluir que, por isso, não seria necessário judicializar para se obter o medicamento, quanto para, justamente porque o medicamento já faz parte do SUS, determinar o seu fornecimento judicialmente. No âmbito da saúde suplementar, o argumento é utilizado para rechaçar a necessidade de o tratamento ser fornecido pelo plano de saúde.

Em sexto lugar, aparece a mobilização de informações acerca da decisão da CONITEC sobre o medicamento. Nesse caso, o NatJus parece atuar como tradutor da decisão da CONITEC, visto que Wang et al. (2020) constataram que os pareceres da CONITEC não costumam ser citados nem mesmo quando trazidos pelas partes. As notas técnicas do NatJus podem cumprir a função de selecionar os principais pontos apresentados pela CONITEC que sejam relevantes para a solução do caso concreto, bem como, em alguns casos, a exercer a função de representar o referendo de não uma, mas duas instituições à decisão do magistrado.

Em menor frequência apareceram as informações sobre a situação regulatória do medicamento – sendo mobilizados dados sobre o registro do medicamento pela Anvisa e por agências de outros países – e sobre a situação de urgência do paciente. A pouca frequência de ambas as informações pode ser explicada pelo universo analisado. Os NatJus emitem poucos pareceres sobre medicamentos não registrados e, como foram analisadas principalmente sentenças, a urgência não foi tema essencial para as decisões.

4.3.4 Por que os juízes discordam dos pareceres técnicos

Em 91,4% das decisões que citam ao menos uma das informações do parecer do NatJus (n=202) – 169 de saúde pública e 33 de saúde suplementar –, o magistrado acolheu os argumentos do parecer. Nos 58 casos restantes (8,6%), sendo apenas seis da saúde suplementar, os magistrados mobilizaram uma série de razões para justificar suas discordâncias com os órgãos técnicos (Tabela 12).

Tabela 12. Motivos para desconsideração do parecer do NatJus

Que motivos a decisão apresenta para não acolher os argumentos do parecer do NatJus?	**Saúde Pública**	**Saúde Suplementar**
A prescrição médica deve sempre prevalecer em relação à avaliação do NatJus	21 (40,4%)	3 (50%)
A prescrição do médico deve prevalecer diante das condições fáticas do caso concreto	19 (36,5%)	0 (0%)
Os pareceres do NatJus não são vinculantes	7 (13,5%)	1 (16,7%)
O NatJus alega que a judicialização é desnecessária, mas o paciente seguiu o procedimento administrativo adequado	5 (9,6%)	0 (0%)
NatJus não indica inadequação do medicamento ao paciente	3 (5,8%)	1 (16,7%)
Há pareceres favoráveis em casos semelhantes	3 (5,8%)	0 (0%)
Agravo de instrumento concedeu tratamento contrário ao que o NatJus havia decidido e ele deve ser mantido	2 (3,8%)	0 (0%)
Juízo discorda de avaliação feita pelo NatJus sobre relatório médico	2 (3,8%)	0 (0%)
Juízo alega incompletude do parecer do NatJus	2 (3,8%)	0 (0%)
SUS não oferece opção de tratamento para a moléstia	1 (1,9%)	0 (0%)
CONITEC recomendou incorporação do medicamento	1 (1,9%)	0 (0%)
NatJus emitiu parecer com base em custo-benefício	1 (1,9%)	0 (0%)
O tratamento está no rol da ANS	0 (0%)	1 (16,7%)
Tratamento deve ser concedido mesmo *off label*	0 (0%)	1 (16,7%)
Total	52 (100%)	6 (100%)

Fonte: elaboração própria. Cada decisão pode trazer mais de um motivo para desconsiderar o parecer.

O principal motivo na saúde pública e na saúde suplementar para o não acolhimento da conclusão do parecer do NatJus foi o de que a prescrição médica deve sempre prevalecer em relação à avaliação do NatJus. Nesse argumento, defende-se que, se o médico prescreveu um determinado medicamento, não caberia a uma agência burocrática a revisão dessa indicação. Essa motivação leva ao questionamento de por que, então, os magistrados solicitaram parecer do NatJus. São três as principais hipóteses. Primeiro, os pareceres podem ter sido solicitados pelas partes a contragosto do magistrado, que optou por não negar o pedido e posteriormente rechaçar o peso argumentativo do parecer técnico. Segundo, o magistrado pode ter solicitado parecer sem intenção alguma de o utilizar, por pressão do tribunal, e principalmente do comitê de saúde do tribunal, que incentivam e promovem os NatJus. Terceiro, o parecer pode ter sido solicitado com a intenção de mobilizá-lo apenas caso concordasse com o juízo prévio sobre o caso feito pelo magistrado, possivelmente em casos em que o magistrado acreditava que o

NatJus emitiria juízo compatível com o seu. Em caso de conflito de opiniões, então, o magistrado se limitaria a afirmar a prevalência da prescrição médica.

A segunda, a terceira e a quinta motivações mais mobilizadas são, em alguma medida, versões mais fracas desse argumento. Respectivamente, argumenta-se que a prescrição médica deve prevalecer apenas no caso concreto, ou se constata que o parecer é apenas consultivo, ou se argumenta que a prescrição só não deve prevalecer se o NatJus indicar a inadequação da prescrição. Se essas motivações forem utilizadas com frequência, elas se aproximam da tese mais forte de que a prescrição médica deve sempre prevalecer. Aplicadas adequadamente, no entanto, as teses de prevalência da prescrição a depender do caso concreto e de que o parecer é apenas consultivo podem representar o meio-termo correto entre a adesão às evidências médicas e às políticas públicas, e o contraditório ofertado às partes no caso concreto. A tese de que a prescrição só não deve prevalecer se o NatJus indicar inadequação do medicamento prescrito, entretanto, parece deturpar a função do órgão, visto que redistribui o ônus da prova e o torna responsável por ter de demonstrar que a prescrição está incorreta, em vez de ser o paciente que deve demonstrar a retidão do pedido. Além disso, a tese impõe ao órgão maior necessidade argumentativa, em detrimento da função de apenas fornecer subsídios para que o magistrado é que avalie o caso concreto.

As motivações restantes estão associadas a outros tipos de discordâncias entre o magistrado e o NatJus. Primeiro, discordância sobre o que há de ser feito em casos de pedidos de medicamentos inseridos no SUS – o NatJus entende que a judicialização é desnecessária nesses casos, mas magistrados concedem o medicamento indicando que o paciente seguiu o processo administrativo adequado. Segundo, discordância sobre a avaliação correta do caso concreto, seja sobre como o relatório médico deve ser interpretado – em especial, se ele seguiu os requisitos do Tema 106 do STJ ou não –, seja sobre a (in)adequação da aplicação de informações trazidas por pareceres do NatJus a casos semelhantes. Por fim, há a discordância manifestada não pelo magistrado, mas pelas instâncias superiores, que deve prevalecer, segundo os magistrados, sobre o entendimento do NatJus. Este último ponto reforça a relevância do papel dos desembargadores e ministros do STJ na adesão dos juízes ao NatJus e ao melhor uso das informações trazidas pelo órgão.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta dissertação, busquei construir o trabalho com a mais ampla discussão da literatura sobre NatJus já produzido. Diante de diversos trabalhos que ainda dialogam pouco entre si, espero que esta organização das pesquisas anteriores possa contribuir para que trabalhos posteriores possam ser produzidos sobre base mais sólida. Esse esforço se faz especialmente relevante agora que, após a decisão do Tema 6 do STF, a importância dos NatJus mudou de patamar. Entretanto, se apenas uma conclusão for ser extraída deste trabalho, deve-se extrair que, em que pese tantos trabalhos já tenham sido publicados sobre os NatJus, ainda sabemos muito pouco sobre como estes órgãos têm efetivamente atuado e quais tem sido seus impactos sobre a judicialização da saúde. O quadro atualmente delineado sobre a atuação dos NatJus, no entanto, não parece ser muito positivo.

Com exceção de Dias Júnior (2023) – trabalho ainda recente –, a literatura discutiu pouco o fato de que os NatJus discordam bastante entre si, o que tende a promover um aumento nas desigualdades de acesso a medicamentos. Dados como os que foram aqui apresentados, no entanto, já estavam disponíveis e poderiam ter sido coletados há vários anos. Se as críticas de Vasconcelos (2020) e Wang (2018; 2021) aos NatJus já eram pertinentes considerando apenas a estrutura dos NatJus quando comparados à CONITEC, diante de dados empíricos aqui apresentados, demonstrando que diversos NatJus tomam de maneira consistente decisões que ignoram custo-efetividade e, assim, passam por cima das decisões da CONITEC e do SUS, a pertinência da manutenção dos NatJus torna-se ainda mais questionável.

A literatura também ainda traz muito poucos dados sobre que papel exatamente os NatJus têm desempenhado no processo judicial. Nesta dissertação, produzi dados sobre o TJSP e o NatJus SP que trazem um alerta: magistrados não têm utilizado os pareceres dos NatJus para discutir evidências científicas. Nesse sentido, ao menos em São Paulo, os NatJus não parecem estar exercendo a função que foram criados para exercer. Considerando que os dados aqui analisados são de 2023, e que muito provavelmente quadro semelhante poderia ter sido observado em quase qualquer momento depois da criação do órgão, esse diagnóstico também poderia já ter sido feito há alguns anos e o NatJus SP poderia inclusive ter já sido reformulado, ou poderia o CNJ estar liderando discussões para avaliar uma possível reformulação dos NatJus.

Se a cúpula do Judiciário pretende levar a sério a função de formular e implementar política pública judiciária voltada a reduzir e aprimorar a judicialização da saúde, é necessário ser também levada a sério a função de avaliar esta política pública e fomentar que a Academia

e a sociedade civil contribuam com essa tarefa. Sem um amplo processo de avaliação prévia, serão frequentes os paradoxos como o que acabamos observando no Tema 6. As premissas desta decisão são louváveis, mas entram em choque com o que a realidade nos diz sobre as determinações dessa mesma decisão.

A primeira premissa da corrente vencedora no Tema 6 foi a de que, como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. No entanto, diversos NatJus desconsideram a limitação de recursos e a necessidade de se considerar a custo-efetividade ao realizar decisões de incorporação de tecnologias ao SUS.

A segunda premissa foi a de que a concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, afetando o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. Como visto, o sistema atual de NatJus promove divergências extremas na maneira como cada indivíduo irá ser avaliado perante o Judiciário e permite até mesmo que, na prática, muitos juízes tenham a possibilidade de escolher que recomendação desejam receber de um NatJus, por meio da escolha entre o NatJus local e o NatJus Nacional. Há enorme variedade no apoio técnico fornecido pelos NatJus, portanto, a depender do estado em que o paciente judicializa e do juiz que avaliará seu caso.

A terceira e última premissa foi a de que o Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a CONITEC, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. Além disso, a concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. Entretanto, novamente, os dados aqui apresentados mostram que o papel atribuído aos NatJus em processos judiciais conflita com esse objetivo, visto que, em diversos NatJus, nem a CONITEC, nem a custo-efetividade são levadas a sério, e, observando a prática no TJSP, vemos que, ao menos neste tribunal, mesmo as decisões que já contam com apoio técnico não costumam discutir medicina baseada em evidências.

Este cenário aponta para algo sobre o qual Rodrigues e Lima (2021) já alertavam antes mesmo da conclusão do julgamento do Tema 6: o voto do ministro Barroso – que seria o redator do acórdão neste caso – poderia incorrer em dificuldades associadas a *path dependence*.[40] Isto

[40] Repetindo a definição adotada por Rodrigues e Lima (2021) ao fazer esta crítica, partindo de Prado e Trebilock (2009), a teoria do "*path dependence* descreve como o reforço de um dado conjunto de arranjos ao longo do tempo aumenta o custo de mudá-los".

é, diante de todos os esforços financeiros, de tempo e de pessoal, empregados pelo CNJ e pelo restante do Judiciário para constituir os NatJus, o ministro, e os ministros que seguiram seu voto, poderiam se sentir constrangidos a atribuir papel relevante aos NatJus mesmo que análises dessa política demonstrassem que ela precisa ser revista e talvez até mesmo abolida.

Ao final, a insistência do Judiciário na oferta de assistência técnica como solução para os problemas da judicialização da saúde segue partindo de um diagnóstico, no melhor dos casos, incompleto, porque "reduz a questão do fornecimento de tratamentos pelo SUS a um problema de eficácia a ser resolvida pela evidência científica quando, na verdade, é uma decisão de política em que a ciência é apenas um dos fatores a ser considerado" (Wang, 2018). Se o problema fosse tratado como uma questão de política e, para isso, efetivamente houvesse deferência à CONITEC e aos órgãos do SUS, as três premissas indicadas no Tema 6 poderiam se concretizar. No entanto, enquanto o modelo atual dos NatJus for mantido, dificilmente essas premissas serão tiradas do papel e, sem elas, a judicialização tende a seguir promovendo alocações de recursos públicos que prejudicam a qualidade do serviço fornecido pelo SUS e o direito à saúde daqueles que mais acessam e dependem desse sistema.

6 REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Nívea Aparecida de; et al. Notas técnicas para judicialização de anticoagulantes orais diretos: uma avaliação do perfil. **Medicina (Ribeirão Preto)**, v. 55, n. 2, p. e-192624, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2176-7262.rmrp.2022.192624>.

ANJOS, Pedro Germano dos; OLIVEIRA, Gabrielle Crus. O Conselho Nacional de Justiça e o problema da judicialização das políticas públicas de saúde: reflexos na atuação judiciária em 2019-2020. **Revista CNJ**, v. 4, n. 1, p. 193–206, 2020.

ARRUDA, Simone Cristina de. Análise sobre a judicialização da saúde no estado de mato grosso no período de 2011-2012. **Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário**, v. 6, n. 1, p. 86-111, jan./mar. 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17566/ciads.v6i1.308>.

ASENSI, Felipe Dutra; PINHEIRO, Roseni (coord.). **Justiça Pesquisa: Judicialização da saúde no Brasil**. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2015. Disponível em: <https://bibliotecadigital.cnj.jus.br/jspui/bitstream/123456789/307/1/Justi%c3%a7a%20Pesquisa%20-%20Judicializa%c3%a7%c3%a3o%20da%20Sa%c3%bade%20no%20Brasil.pdf>.

ASPERTI, Maria Cecília de Araujo; et al. Why The “Haves” Come Out Ahead in Brazil? Revisiting Speculations Concerning Repeat Players and One-Shooters in the Brazilian Litigation Setting. **Direito Público**, v. 16, n. 88, 2019. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/3503>. Acesso em: 3 mar. 2024.

ASSOCIAÇÃO JUÍZES PELA DEMOCRACIA – AJD. **Ref.: Termo de Cooperação Técnica n. 000.045/2015 – Núcleo de Apoio Técnico e de Mediação (NAT)**. Associação Juízes pela Democracia, 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/ju/juizes-pedem-extincao-nucleo-mediacao.pdf>.

ÁVILA, Ana Paula Oliveira; MELO, Karen Cristina Correa de. Separação de poderes e diálogos institucionais nos litígios envolvendo o direito à saúde. **Revista de Investigações Constitucionais**, v. 5, n. 1, p. 83-108, jan./abr. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5380/rinc.v5i1.54934>.

AZEVEDO, Paulo Furquim de; *et al*. **Judicialização da Saúde no Brasil**: Perfil das Demandas, Causas e Propostas de Solução. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2019.

BARROS, Lívia Dias; CASTRO, Gina Gouveia Pires De. A Judicialização da Saúde em Pernambuco Após a Audiência Pública nº 4 do Supremo Tribunal Federal: Uma Análise Quantitativa da Atuação do Judiciário na Garantia do Direito Social à Saúde. **Revista Brasileira de Direitos e Garantias Fundamentais**, v. 2, n. 2, p. 154–174, 2016.

BORGES, Danielle da Costa Leite. Individual Health Care Litigation in Brazil through a Different Lens. **Health and Human Rights**, v. 20, n. 1, p. 147–162, 2018.

CAETANO, Cristiana Ropelatto; MATHEUS, Filipe Carvalho; DIEHL, Eliana Elisabeth. Organização dos entes públicos para atender a judicialização do acesso a medicamentos no estado de Santa Catarina, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 5561–5575, 2021.

CALIXTO, Fabiana; ALMEIDA, Ana Paula; FRANÇA, Luiz Henrique. Diálogos interinstitucionais na judicialização da saúde como estratégia de sustentabilidade do SUS. **Saúde em Debate**, v. 46, p. 1015–1029, 2023.

CAMBRICOLI, Fabiana. Núcleo criado para ajudar TJ-SP a julgar processos de saúde está parado. **Estadão**, 20 ago. 2016. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/saude/nucleo-criado-para-ajudar-tj-sp-a-julgar-processos-de-saude-esta-parado/>.

CAVALCANTI, Hylda. Núcleo de assistência às demandas judiciais de saúde do RJ já emitiu 2.800 pareceres. **CNJ**, 3 mai. 2011. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/nucleo-de-assistencia-as-demandas-judiciais-de-saude-do-rj-ja-emitiu-2800-pareceres/>.

CHAGAS, Flávia de Azevedo Faria Rezende. **A judicialização da saúde e as tutelas de urgência**: uma visão do plantão do Poder Judiciário. Dissertação de Mestrado, Fundação Oswaldo Cruz, 2019.

COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONITEC. **Abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe para o tratamento de pacientes adultas com câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-**. Relatório de Recomendação – Medicamento – Nº 678 – Novembro de 2021. Brasília: CONITEC, set. 2021a. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2021/20211207_relatorio_678_abemaciclibe_palbociclibe_ribociclibe_carcinoma_mama_final.pdf>.

COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONITEC. **Empagliflozina para o tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e doença cardiovascular estabelecida**. Relatório de Recomendação – Medicamento – Nº 403 – Dezembro de 2018. Brasília: CONITEC, dez. 2018a. Disponível em: < http://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Relatorios/2018/Recomendacao/Relatorio_Empagliflozina_DM2eDoencaCardiovascular.pdf>.

COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONITEC. **Pembrolizumabe (em monoterapia ou associado à quimioterapia) para pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas avançado ou metastático (PD-L1 positivo) em primeira linha de tratamento**. Relatório de Recomendação – Medicamento – Nº 859. Brasília: CONITEC, nov. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2023/20231227_pembrolizumabe_859_cancer_pulmao_cnp.pdf>.

COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONITEC. **Pembrolizumabe, axitinibe, ipilimumabe e nivolumabe para tratamento de primeira linha de câncer de células renais**. Relatório de Recomendação – Medicamento – Nº 660. Brasília: CONITEC, ago. 2021b. Disponível em: <http://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/20210629_Relatorio_Pembrolizumabe_Axitinibe_Ipilimumabe_Nivolumabe_CCR_primeira_linha_CP_59.pdf>.

COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONITEC. **Pirfenidona para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI)**. Relatório de Recomendação – Medicamento – Outubro/2018. Brasília: CONITEC, out. 2018b. Disponível em: < https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2018/relatorio_pirferidona_fibrosepulmonaridioptica_cp65_2018.pdf>.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. **Judicialização e sociedade**: ações para acesso à saúde pública de qualidade. Brasília, DF: Conselho Nacional de Justiça, 2021.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. **Programas e Ações – Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus) – Sistema e-NatJus**. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude-3/e-NatJus/>. Acesso em 4 mar. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. Resolução Nº 388 de 13/04/2021. **Dispõe sobre a reestruturação dos Comitês Estaduais de Saúde, fixados pela Resolução CNJ no 238/2016, e dá outras providências**. Brasília, DJe/CNJ nº 95/2021, de 15 de abril de 2021, p. 2-5.

DIAS JÚNIOR, Osmar Sebastião. **Fortalecimento das capacidades estatais: estudo de caso sobre a atuação dos NATJUS na incorporação do zolgensma para o tratamento da atrofia muscular espinhal tipo I**. Dissertação de Mestrado, Escola Nacional de Administração Pública, 2023.

DOMINGUES, Mara Luiza de Paiva; et al. Avaliação do risco de viés dos ensaios clínicos referenciados nas notas técnicas sobre os anticoagulantes orais diretos disponíveis no e-NatJus. **Medicina (Ribeirão Preto)**, v. 56, n. 4, e-212675, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2176-7262.rmrp.2023.212675>.

FERRAZ, Octavio Luiz Motta. **Health As a Human Right**. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2021.

FERREIRA, Siddharta Legale; COSTA, Aline Matias da. Núcleos de Assessoria Técnica e Judicialização da Saúde: constitucionais ou inconstitucionais? **Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro**, v. 20, n. 36, p. 219–240, 2013.

FORTUNATO, Beatriz Casagrande; BOTELHO, Marcos César. Descompasso na saúde pública: o acesso à justiça e a judicialização versos o direito à saúde na Constituição de 1988. **Prisma Juridico**, v. 20, n. 1, p. 153–172, 2021.

FREIRE, Lucas. Diagnosticar falhas e solucionar litígios de saúde: o processo de criação da CRLS. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 38, n. 111, p. e3811018, 2023.

GALANTER, Marc. Why the Haves Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change Essay. **Law & Society Review**, v. 9, n. 1, p. 95–160, 1974.

GONÇALVES, Ana Clara Anacleto; *et al*. Profile of judicialized cannabis: Analyzing technical notes. **Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences**, v. 60, p. e23951, 2024. Disponível: <https://doi.org/10.1590/s2175-97902024e23951>.

GOMES, Dalila F. Judicialização da saúde e a audiência pública convocada pelo Supremo Tribunal Federal em 2009: o que mudou de lá para cá? **Saúde em Debate**, v. 38, n. 100, p. 139-156, jan.-mar. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/0103-104.20140008>.

GOMES, Thisciane Ferreira Pinto; et al. Perfil de notas técnicas para suporte técnico-científico à decisão judicial do medicamento Zolgensma® (onasemnogeno abeparvoveque). **HU Revista**, v. 49, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.34019/1982-8047.2023.v49.43373>.

HALL, Mark A.; WRIGHT, Ronald F. Systematic Content Analysis of Judicial Opinions. **California Law Review**, v. 96, n. 1, p. 63–122, 2008.

HENRIQUE, Milene de Carvalho; BRITO, João Ornato Benigno; MEL, Musa Denaise de Sousa Morais. Eficiência na solução das demandas de judicialização da saúde na Comarca de Araguaina-TO. **Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário**, v. 2, n. 2, p. 320–338, 2013.

HENRIQUE, Milene de Carvalho; MENDONÇA, Mara Regina Leite; BRAGA, Elizangela Andrade. NatJus e Desjudicialização da Saúde. In: *In*: CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE – CONASS (Org.). **Boas Práticas e Diálogos Institucionais**. 2018, v. 3. (Coletânea Direito à Saúde).

HOSSEPIAN JUNIOR, Arnaldo; ROCHA, Rodrigo Silva. O Judiciário e a Questão da Saúde: a Busca de uma Judicialização Qualificada e de Soluções Negociadas – um Projeto do Fórum da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. *In*: CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE – CONASS (Org.). **Boas Práticas e Diálogos Institucionais**. 2018, v. 3. (Coletânea Direito à Saúde).

LISBOA, Luana. Medicamento de R$ 92 mil para fibrose cística chega ao SUS. **Folha de S. Paulo**, 7 jun. 2024. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2024/06/medicamento-de-r-92-mil-para-fibrose-cistica-chega-ao-sus.shtml>.

LOPES, Raquel. SUS não entrega ao menos 76 medicamentos e procedimentos incorporados à rede pública desde 2018. **Folha de S. Paulo**, 20 jan. 2025. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2025/01/sus-nao-entrega-ao-menos-76-medicamentos-e-procedimentos-incorporados-a-rede-publica-desde-2018.shtml>.

MARIANO, Cynara Monteiro; *et al*. Diálogos sanitários interinstitucionais e a experiência de implantação do NATJUS. **Revista de Investigações Constitucionais**, v. 5, n. 1, p. 169–188, 2018.

MITCHELL, Ryan. **Web Scraping with Python**: collecting more data from the modern web. O'Reilly, 2018.

MORGULIS, Maria Clara de Azevedo. **Essays on Economic Analysis of Law**. Doutorado em Economia, Insper, São Paulo, 2021.

MOTA, Karla Spinoza Coelho. Judicialização do cinacalcete no estado do Rio de Janeiro. **Jornal Brasileiro de Economia da Saúde**, v. 13, n. 2, p. 175-185, 2021. Disponível em: <https://jbes.com.br/index.php/jbes/article/view/133>.

NASCIMENTO, Bianca Santos; MIRANDA, Wellington Gomes. Natjus: meio de fomento para a desjudicialização das demandas de assistência à saúde no estado do Tocantins. **Revista Jurídica Ministério Público do Estado do Tocantins**, v. 13, n. 18, p. 129-154, 2020. Disponível em: <https://cesaf.mpto.mp.br/revista/index.php/revistampto/article/view/34>.

NOGUEIRA, José Luiz; CARVALHO, Lélia; DADALTO, Luciana. Parcerias entre Universidades e Poder Judiciário: experiência de Minas Gerais. **Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário**, v. 6, n. 1, p. 55-71, jan./mar. 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17566/ciads.v6i1.337>.

NORÕES, Mariane Paiva. **Núcleo de Apoio Técnico e de Mediação e a Judicialização da Saúde Suplementar do Estado do Ceará**. Dissertação de Mestrado em Direito Constitucional. Universidade de Fortaleza, 2018.

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO [DO TOCANTINS] – NAT-TO. **Relatório Anual das consultas realizadas ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) em 2014**. s/ data. Disponível em: <https://www.tjto.jus.br/saude/NatJus-nucleo-de-apoio-tecnico/relatorios/20667-NatJus-estadual-relatorio-de-atividades-anual-2014-pdf/viewdocument/20667>.

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO [DO TOCANTINS] – NAT-TO. **Relatório Anual – 2015**. Palmas, fevereiro de 2016. Disponível: <https://www.tjto.jus.br/saude/NatJus-nucleo-de-apoio-tecnico/relatorios/20668-NatJus-estadual-relatorio-de-atividades-anual-2015-pdf/viewdocument/20668>.

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO [DO TOCANTINS] – NAT-TO. **Relatório Anual – 2016**. Palmas, fevereiro de 2017. Disponível: <https://www.tjto.jus.br/saude/NatJus-nucleo-de-apoio-tecnico/relatorios/20669-NatJus-estadual-relatorio-de-atividades-anual-2016-pdf/viewdocument/20669>.

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO [DO TOCANTINS] – NAT-TO. **Relatório Anual – 2017**. Palmas, fevereiro de 2018. Disponível: <https://www.tjto.jus.br/saude/NatJus-nucleo-de-apoio-tecnico/relatorios/20670-NatJus-estadual-relatorio-de-atividades-anual-2017-pdf/viewdocument/20670>.

ORNELAS, Thaíse Siqueira. A Desjudicialização das Demandas por Medicamentos: uma Análise sobre a Efetividade do Núcleo De Apoio Técnico – NAT após a sua Instalação no Município de Joinville. **Revista da ESMESC**, v. 25, n. 31, p. 13–40, 2018.

PEREIRA, Sylvia Patrícia Dantas. **Contribuição dos pareceres do NATJUS/RN no desfecho dos processos judiciais que solicitam medicamentos ao Estado do Rio Grande do Norte**. Mestrado em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023.

PIRES, Eliane de Jesus Cunha. **As decisões judiciais sobre o direito à saúde na vara de saúde pública do termo judiciário de São Luís no período de setembro/2020 a**

setembro/2022. Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça, Universidade Federal do Maranhão, 2023.

PINHEIRO, Jonatas Dos Santos; CHAVES, Fábio Barbosa. Judicialização da saúde: a contribuição das medidas administrativas recomendadas pelo CNJ aplicadas pelo Poder Judiciário do Tocantins. **Revista Integralização Universitária**, v. 13, n. 21, p. 60–73, 2020. DOI: 10.31501/1982-9280.2019V13N21p.60-73.

PORTELA, Ronaldo; *et al*. Judicialização de produtos à base de canabidiol no Brasil: uma análise de 2019 a 2022. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, n. 8, p. e00024723, 2023. DOI: 10.1590/0102-311xpt024723.

REGOLIN, Fabiana; et al. Ações judiciais por artroplastia de quadril no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, 2016-2018. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, n. 5, e00178621, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT178621>.

RIBEIRO, Leandro Molhano; HARTMANN, Ivan Alberto. Judicialization of the right to health and institutional changes in Brazil. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, vol. 3, n. 3, p. 35-52, set./dez. 2016. DOI: 10.5380/rinc.v3i3.48160.

ROCHA, Danilo Di Paiva Malheiros; QUEIROZ, Loara Jheniffer Correia de; RODRIGUES, Walter Manuel Alves. A participação dos Núcleos de Apoio Técnico (NATJUS) nas decisões judiciais. **Mediação**, v. 16, n. 2, p. 125–136, 2021.

RODAS, Sérgio. Juízes pedem extinção do núcleo de mediação em ações contra planos de saúde. **Consultor Jurídico**, 21 set. 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-set-21/juizes-pedem-fim-mediacao-acoes-planos-saude-tj-sp/>.

RODRIGUES, Daniel dos Santos; LIMA, Jordão Horácio da Silva. Judicialização da saúde, acesso a medicamentos e diálogos institucionais. **A & C – Revista de Direito Administrativo e Constitucional**, v. 21, n. 83, p. 161-180, jan./mar. 2021.

SAAD, Elizabeth Maria; BRAGA, José; MACIEL, Elvira Maria Godinho de. Bases jurídicas e técnicas das sentenças dos Juizados Especiais Fazendários do Rio de Janeiro (RJ), 2012-2018. **Saúde em Debate**, v. 43, p. 71–82, 2020.

SANTIAGO, Arthemísia Ferreira Paulo. **Judicialização de políticas sociais como estratégia do Poder Judiciário**: o Fórum da Saúde e o Cadastro Nacional de Adoção. Doutorado em Sociologia, Universidade Federal de Pernambuco, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/17500.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO – SES/MT. **TJ e Saúde do Estado instalam núcleo de apoio a juízes em decisões de Saúde**. 9 nov. 2011. Disponível em: <http://www.saude.mt.gov.br/portal/manchetes/manchete.php?id= 3584>. Acesso em: 5 maio 2012.

SILVA, Miriam Ventura da. **O processo decisório judicial e a assessoria técnica: a argumentação jurídica e médico-sanitária na garantia do direito à assistência terapêutica no Sistema Único de Saúde**. Doutorado em Ciências na Saúde Pública,

Fundação Oswaldo Cruz, 2012. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/37648>. Acesso em: 15 nov. 2023.

SOARES, Eduardo Jonas. **Judicialização do direito à saúde**: reflexos da atuação do núcleo de apoio técnico na qualificação das decisões e redução das demandas judiciais no estado de Santa Catarina. Dissertação de Mestrado em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, 2021.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. **Recurso Extraordinário 566.471 Rio Grande Do Norte**. Relator: Min. Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso. Publicado em 26 set. 2024.

TJGO. NATJUS Goiás. **Revista do Comitê Executivo de Saúde do CNJ em Goiás**, edição 1. Goiânia: CNJ; TJGO, 2021.

TJTO. Núcleo de Apoio Técnico – NATJUS. **Relatório Anual – 2019**. Palmas: TJTO, 2020.

TOLEDO, Isabela Porto de; *et al*. Supporting evidence-based judicial decisions on health care in Brazil: an experience report. **Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário**, v. 13, n. 3, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.17566/ciads.v13i3.1259>.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. **Acórdão 1787/2017**, Plenário, Processo n. 009.253/2015-7, Sessão: 16/8/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – TJSP. 'Acessa SUS' evitará ações desnecessárias para fornecimento de remédios. **TJSP** – Notícias, 13 fev. 2017. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=38743>.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ – TJPR. Núcleo de Apoio Técnico (NAT) vai emitir pareceres técnicos na área do Direito à Saúde. **TJPR** – Notícias, 8 nov. 2013. Disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/noticias/-/asset_publisher/9jZB/content/nucleo-de-apoio-tecnico-nat-vai-emitir-pareceres-tecnicos-na-area-do-direito-a-saude/18319>.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO – TRF2. NAT JUS/RJ. **Portal TRF2**, [s. d.]b. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/comite-estadual-de-saude-rj/NatJus/>.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO – TRF2. Órgãos relevantes nas demandas judiciais. **Portal TRF2**, [s. d.]a. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/comite-estadual-de-saude-rj/o-sus/orgaos-relevantes-nas-demandas-judiciais/>.

VAL, Eduardo Manuel; PELEGRINO, Mirian. Judicialização da Saúde uma Questão de ("In") Justiça – Experiência Brasileira. **Revista Internacional Consinter de Direito**, v. 6, n. 11, p. 133–150, 2020.

VASCONCELOS, Natalia Pires de. Business as Usual: Inequality and Health Litigation during the COVID-19 Pandemic in Brazil. In: GERMAIN, Sabrina; YONG, Adrienne (Orgs.). **Beyond the Virus**: Multidisciplinary and International Perspectives on Inequalities Raised by COVID-19. Bristol: Bristol University Press, 2023, p. 137–163.

VASCONCELOS, Natalia Pires de. **Mandado de Segurança ou Ministério da Saúde?** Doutorado em Direito do Estado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

VASCONCELOS, Natalia Pires de. Solução do problema ou problema da solução? STF, CNJ e a judicialização da saúde. **REI – Revista Estudos Institucionais**, v. 6, n. 1, p. 83–108, 2020.

VASCONCELOS, Natalia Pires de; et al. Covid-19 e judicialização da saúde no município de São Paulo. In: WANG, Daniel Wei Liang; TERRAZAS, Fernanda Vargas (Orgs.). **Judicialização da Saúde nos Municípios**. Brasília: Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, 2022, p. 431–467.

WANG, Daniel *et al*. **A judicialização da saúde suplementar**: uma análise empírica da jurisprudência de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal de Justiça de São Paulo. São Paulo: FGV Direito SP, 2023.

WANG, Daniel Wei Liang. **Health technology assessment, courts, and the right to healthcare**. Londres: Routledge, 2022.

WANG, Daniel; *et al*. Health technology assessment and judicial deference to priority-setting decisions in healthcare: Quasi-experimental analysis of right-to-health litigation in Brazil. **Social Science & Medicine**, v. 265, p. 113401, 2020.

WANG, Daniel Wei Liang. Resposta sofisticada a problema subestimado? **Valor Econômico**, 10 jul. 2018.

YAMAUTI, Sueli Miyuki; *et al*. Strategies Implemented by Public Institutions to Approach the Judicialization of Health Care in Brazil: A Systematic Scoping Review. **Frontiers in Pharmacology**, v. 11, 2020.